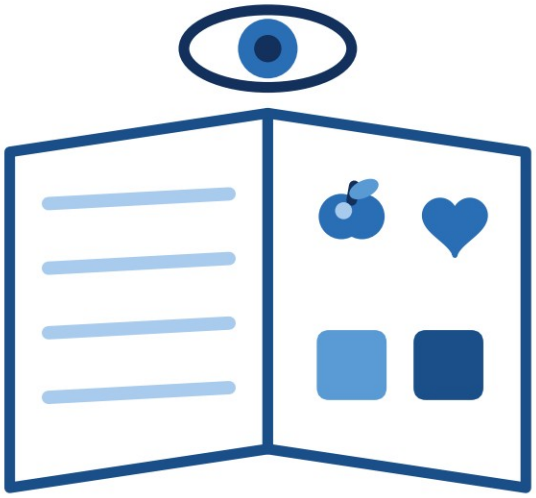
COURS



CHAPITRE

05

Littératie en santé

Littératie en santé | Repérer | Adapter | Vérifier la compréhension

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

5.1 Compétences mobilisées 3

5.2 Croisement référentiel × précisions × indications 3

5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

5.3 Cours 5

5.3.1 Définir la littératie en santé 5

5.3.2 Les données en France 12

5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique 16

5.3.4 Repérer sans stigmatiser 19

5.3.5 Adapter les messages et les supports 23

5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire » 32

5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet 35

5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire 37

5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé 42

5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique 47

5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones 51

5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet 55

5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles 57

5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type 59

5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls 61

5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie 62

5.4 Approfondissements 66

5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé) 66

5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat 67

5.4.3 Les organisations « amies de la littératie » 69

5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations 70

5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes 72

5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école 73

5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75

5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 76

Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet 77

Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve 78

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 79

Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours 80

5.7 L'essentiel à retenir 81

5.8 Entraînement 82

5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 82

5.8.2 Exercices 83

5.8.3 Questions de réflexion 87

5.8.4 Étude de cas 88

5.8.5 Mises en situation express 88

5.8.6 Exercices complémentaires 91

5.9 Glossaire 92

5.10 Renvois bibliographiques par notion 93

5.12 Bibliographie numérotée 93

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la littératie en santé et la littératie alimentaire, et en décrire les dimensions (accéder, comprendre, évaluer, appliquer) et les niveaux (fonctionnel, interactif, critique) ;
- présenter les données françaises disponibles (enquête HLS19, illettrisme, illectronisme) et les relier aux inégalités sociales de santé (chapitre 2) ;
- expliquer les conséquences d'un faible niveau de littératie sur la santé et sur l'efficacité des actions de prévention ;
- repérer, sans stigmatiser, les difficultés de littératie d'un public (approche des « précautions universelles ») ;
- adapter un message écrit, oral ou numérique au niveau de littératie du public (guide « Communiquer pour tous », facile à lire et à comprendre – FALC –, pictogrammes, lisibilité) ;
- vérifier la compréhension par la technique du « faire dire » (teach-back) ;
- intégrer la littératie dans la conception, l'animation et l'évaluation d'un projet de santé publique.

5.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Prendre en compte la littératie dans le diagnostic et dans chaque étape du projet	Analyse et diagnostic de situation posé ; démarche d'évaluation construite
C3.2	Rendre les ateliers culinaires accessibles (recettes en images, quantités concrètes, démonstration)	Besoins et spécificités du public identifiés ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés
C3.5	Cœur du chapitre : adapter les supports écrits, oraux et numériques, repérer la précarité numérique, vérifier la compréhension	Précarité numérique repérée et prise en compte ; supports et contenus adaptés au public ; écoute active mobilisée ; posture adaptée

5.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Littératie en santé : définitions, dimensions	Définir ; citer les 4 compétences et les 3 domaines	Modèle de Sørensen ; niveaux de Nutbeam
Données épidémiologiques	Connaître les ordres de grandeur en France	Données datées et sourcées (HLS19, ANLCI, Insee)
Littératie et inégalités sociales de santé	Expliquer le lien avec le gradient social	Lien avec le chapitre 2 et l'universalisme proportionné
Repérage des difficultés	Identifier des signaux sans stigmatiser	Pas d'évaluation « scolaire » du public ; précautions universelles
Adaptation des messages et des supports	Appliquer les règles de communication accessible	« Communiquer pour tous » (Santé publique France), FALC, pictogrammes
Vérification de la compréhension	Utiliser le « faire dire »	Posture : c'est le professionnel qui vérifie sa propre clarté

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Littératie numérique et alimentaire	Prendre en compte l'illectronisme ; développer les compétences alimentaires	Lien avec les chapitres 4, 14 et 15 (communication)

5.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Littératie en santé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61 pour les notions, p. 24 et 25 pour le lien avec le bloc 1, p. 122 pour les ressources). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 5.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Définition de la littératie en santé	5.3.1 (définitions datées, modèles de Sørensen et de Nutbeam)
Guide 2025, p. 61	Déterminants de la littératie en santé	5.3.2 (gradient social, données HLS19, PIAAC, Insee, DEPP) ; 5.3.3
Guide 2025, p. 61	Concept et enjeux	5.3.3 (conséquences pour la santé, inégalités) ; 5.4.3 et 5.4.4 (organisations)
Guide 2025, p. 61	Freins et leviers pour augmenter le niveau de littératie	5.3.4 à 5.3.14 (repérer, adapter, faire dire, numératie, numérique, allophones, outils)
Guide 2025, p. 24-25	Améliorer la littératie des personnes prises en soin (lien avec le bloc 1) ; littératie numérique	5.3.6 ; 5.3.10 ; 5.4.1
Guide 2025, p. 122	Ressources : « Communiquer pour tous » (mise à jour 2025), avis de la CNS (2017), Van den Broucke (2017), Le Brun et coll. (2025)	5.3.5 ; 5.12 (références 10, 25 à 27)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.5	Publics, supports adaptés, communication accessible	5.3.12 à 5.3.15 ; 5.6

5.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Aucun des fascicules du CNED disponibles (*Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année ; *Synthèse du cours en bref*, 1re année ; fascicules d'hygiène et d'atelier) ne traite la littératie en santé : la notion est récente dans le référentiel de 2024. Le chapitre s'appuie donc sur le guide de 2025 et sur ses ressources. Les passages du CNED qui s'en rapprochent sont reliés au cours ci-dessous.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)	Éducation pour la santé, promotion de la santé, éducation thérapeutique	5.3.1 (niveaux de Nutbeam et éducation pour la santé) ; chapitre 1
Synthèse 1re année M3 S1 §2 (p. 29)	Information nutritionnelle : étiquetage et Nutri-Score	5.3.8 (lire une étiquette)
Synthèse 1re année M2 S2 §6 (p. 18)	Précarité et pauvreté	5.3.3 (littératie et inégalités sociales de santé) ; chapitre 4

Attention – données mises à jour – Ce qui a changé depuis les premières versions du cours

- **Illectronisme** : le chiffre de 15,4 % des 15 ans ou plus (2021) est remplacé par la dernière enquête de l'Insee : en 2025, **7 %** des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme (10 % en 2021) et **34 %** ont des

difficultés numériques (publication du 19 février 2026). Attention, la tranche d'âge n'est plus la même.

- **Compétences des adultes** : les résultats de PIAAC 2023 sont maintenant chiffrés : **28 %** des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit et 27 % du calcul (Dares, décembre 2024).
- **Lecture des jeunes** : à la Journée défense et citoyenneté 2025, **14 %** des jeunes sont en difficulté de lecture, dont 6 % en très grande difficulté (DEPP, octobre 2026).
- **Illettrisme** : le chiffre de 7 % des 18-65 ans (enquête IVQ 2011) reste la dernière mesure nationale publiée.
- **HLS19** : les résultats de 2021 restent les derniers pour la France ; le cycle HLS24 recueille ses données jusqu'en juin 2026.
- **Nutri-Score** : l'algorithme révisé s'applique en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025, et non « depuis 2024 ».
- **« Communiquer pour tous »** : le guide de 2018 a été mis à jour en février 2025.

5.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

5.3.1 Définir la littératie en santé

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Des définitions qui se sont élargies

Le mot **littératie** (de l'anglais *literacy*) désigne d'abord la capacité à lire, écrire et compter pour fonctionner dans la vie quotidienne. Appliquée à la santé, la notion s'est élargie : il ne s'agit plus seulement de savoir lire une notice, mais de **trouver**, **comprendre**, **juger** et **utiliser** les informations pour prendre des décisions favorables à sa santé, dans les soins comme dans la vie de tous les jours.

Définition – Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012)

« La littératie en santé est liée à la littératie et englobe les **connaissances**, la **motivation** et les **compétences** permettant d'**accéder**, de **comprendre**, d'**évaluer** et d'**appliquer** l'information en santé, afin de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne en matière de **soins**, de **prévention** des maladies et de **promotion de la santé**, pour maintenir ou améliorer la qualité de vie tout au long de la vie. » Cette définition, issue d'une revue de 17 définitions et 12 modèles, est la plus utilisée en Europe (consortium HLS-EU).

Définition – Littératie en santé organisationnelle

Capacité d'une **organisation** (hôpital, centre social, service de restauration, site internet) à rendre l'information et les services **faciles à trouver, à comprendre et à utiliser** pour tous. Elle déplace la responsabilité : la littératie n'est pas seulement une compétence de la personne, c'est aussi une **qualité de l'environnement** (signalétique, documents, accueil, démarches en ligne).

Attention – La littératie n'est pas l'intelligence ni le niveau d'études

Une personne très diplômée peut avoir une littératie en santé limitée dans une situation stressante (annonce d'un diagnostic, langue étrangère, fatigue, deuil) ou dans un domaine nouveau (lire un tableau nutritionnel). La littératie dépend de la **personne**, de la **situation** et de la **complexité de l'information**. On parle donc de **situations de littératie limitée** plutôt que de « personnes illettrées en santé ».

Les 12 dimensions du modèle de Sørensen

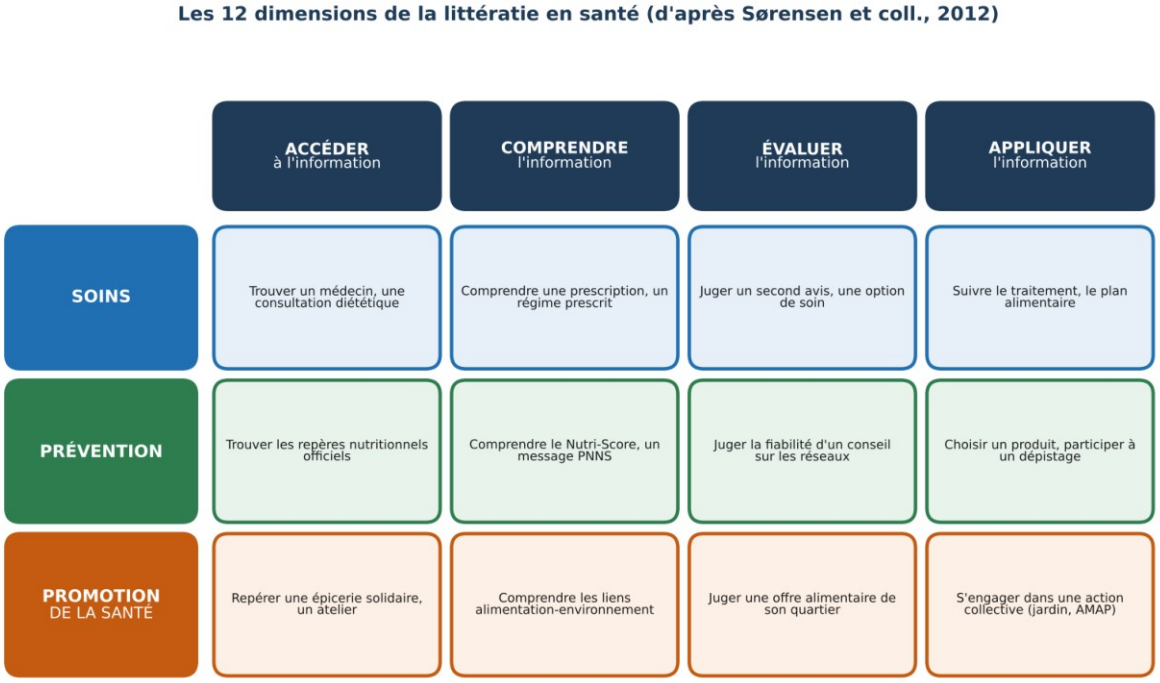


Figure 5.1 – Les 12 dimensions de la littératie en santé

Comprendre le schéma – Figure 5.1

1. Les **colonnes** représentent les quatre **compétences** de traitement de l'information : **accéder** (rechercher, trouver, obtenir), **comprendre**, **évaluer** (interpréter, juger, filtrer) et **appliquer** (communiquer, décider, agir).
2. Les **lignes** représentent les trois **domaines** de la santé : **soins** (être malade, patient), **prévention** (être à risque), **promotion de la santé** (être citoyen dans son milieu de vie).
3. Le croisement donne **12 dimensions** ; l'enquête européenne HLS-EU les mesure par 47 questions du type : « Sur une échelle de très facile à très difficile, à quel point est-il facile pour vous de… comprendre les informations sur les emballages des aliments ? »
4. Exemples alimentaires : *accéder* aux repères du PNNS sur *mangerbouger.fr* ; *comprendre* le Nutri-Score ; *évaluer* un conseil de régime lu sur un réseau social ; *appliquer* en choisissant un produit au magasin.
5. Intérêt pour le diététicien : ce modèle sert de **grille** pour diagnostiquer les besoins d'un public (à quelle étape la difficulté se situe-t-elle ?) et pour construire des objectifs pédagogiques précis.

Les trois niveaux de Nutbeam

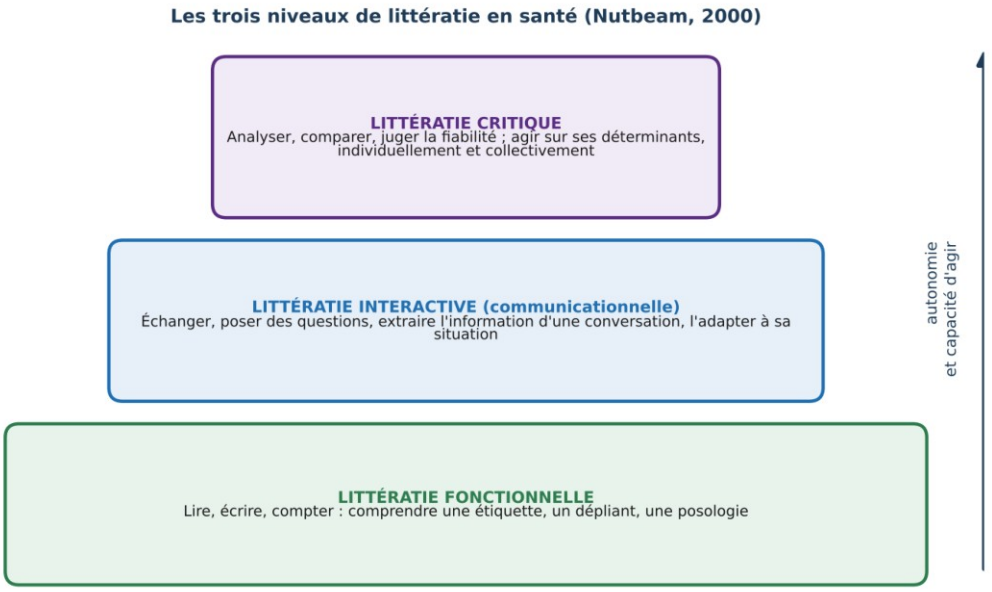


Figure 5.2 – Les trois niveaux de littératie en santé

Comprendre le schéma – Figure 5.2

1. Littératie fonctionnelle : compétences de base en lecture, écriture et calcul permettant de comprendre une information simple (une étiquette, une date limite de consommation, un dépliant). L'information « descend » vers la personne.

2. Littératie interactive ou communicationnelle : compétences cognitives et sociales permettant d'**échanger** (poser des questions au médecin, au diététicien), d'extraire l'information d'une conversation et de l'adapter à sa situation.

3. Littératie critique : capacité à **analyser** les informations, à en juger la fiabilité (publicité, réseaux sociaux, « fausses informations ») et à agir sur les **déterminants** de sa santé, individuellement et collectivement (association de parents qui obtient une meilleure offre à la cantine).

4. Plus on monte, plus la personne gagne en **autonomie** et en **pouvoir d'agir** (*empowerment*, chapitre 3). L'éducation pour la santé vise les trois niveaux ; la promotion de la santé (Charte d'Ottawa) vise particulièrement le niveau critique.

La littératie alimentaire

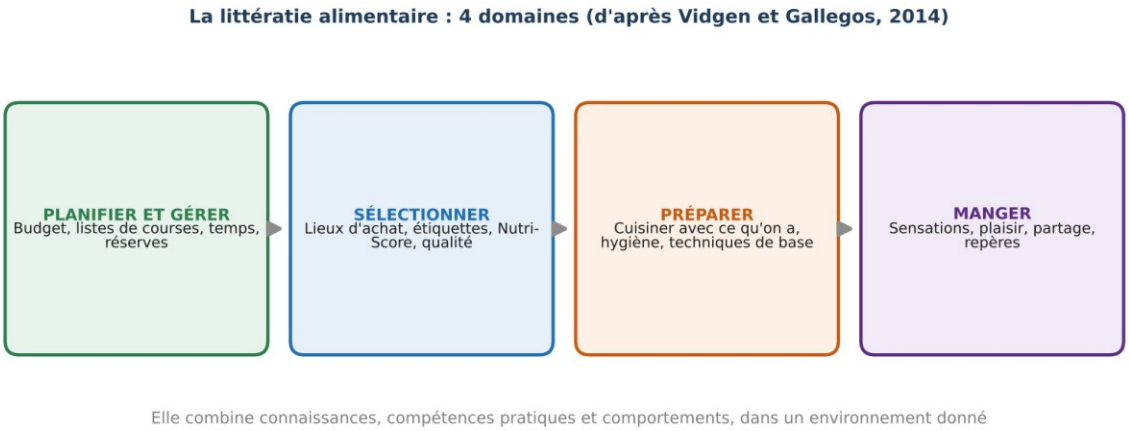


Figure 5.3 – Les quatre domaines de la littératie alimentaire

Définition – Littératie alimentaire (food literacy)

Ensemble de **connaissances**, de **compétences** et de **comportements** interreliés, nécessaires pour **planifier, gérer, sélectionner, préparer et manger** des aliments afin de répondre à ses besoins et d'en déterminer les apports (Vidgen et Gallegos, 2014, qui décrivent 4 domaines et 11 composantes).

Comprendre le schéma – Figure 5.3

1. Planifier et gérer : prévoir les repas, faire une liste, gérer un budget et des réserves, organiser son temps.

2. Sélectionner : savoir où acheter, lire une étiquette (liste d'ingrédients, Nutri-Score, dates), juger la qualité et la fraîcheur.

3. Préparer : cuisiner avec ce que l'on a, appliquer les règles d'hygiène, maîtriser des techniques de base (cuire des légumes secs, faire une soupe).

4. Manger : écouter ses sensations, partager, connaître les repères de consommation.

5. Lien avec le BC3 : un atelier culinaire en centre social développe directement la littératie alimentaire ; elle est un **objectif** à part entière, que l'on peut évaluer (« sait lire une étiquette », « sait cuisiner les lentilles »).

D'où vient la notion : quatre définitions datées

L'expression *health literacy* apparaît en 1974 dans un article de Scott Simonds sur l'éducation pour la santé à l'école : il proposait déjà de fixer des niveaux minimaux de connaissances en santé à atteindre, comme on le fait pour la lecture ou le calcul. La notion se développe ensuite dans les années 1990, d'abord aux États-Unis dans le monde du soin, puis en Europe dans celui de la promotion de la santé. Les définitions successives montrent comment elle s'est élargie.

Année	Auteur ou institution	Ce que la définition met en avant
1998	Nutbeam, glossaire de la promotion de la santé de l'OMS	Les compétences cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des personnes à accéder à l'information, à la comprendre et à l'utiliser pour maintenir une bonne santé
2004	Institute of Medicine (États-Unis), rapport *Health Literacy: A Prescription to End Confusion*	La capacité à obtenir, traiter et comprendre l'information et les services de santé de base nécessaires pour prendre des décisions appropriées

Année	Auteur ou institution	Ce que la définition met en avant
2012	Sørensen et coll., consortium HLS-EU	Connaissances, motivation et compétences ; quatre compétences et trois domaines (définition du cours)
2021	Glossaire de la promotion de la santé de l'OMS (mise à jour)	Les connaissances et compétences personnelles qui s'acquièrent par les activités quotidiennes, les interactions sociales et les générations, et qui sont soutenues par les organisations et les ressources disponibles

La dernière définition ajoute deux idées importantes : la littératie s'apprend aussi dans la vie de tous les jours et dans la famille, et elle dépend des **organisations** qui rendent l'information accessible ou non.

Définition – Ne pas confondre trois notions voisines

- **Alphabétisation** : apprentissage de la lecture et de l'écriture par des adultes qui ne les ont jamais apprises.
- **Éducation pour la santé** : action organisée qui aide les personnes à acquérir des connaissances et des compétences pour leur santé (chapitre 1). C'est un **moyen** ; la littératie en est l'un des **résultats**.
- **Littératie en santé** : ce que la personne sait faire avec l'information de santé, dans une situation donnée, compte tenu de l'information qu'on lui donne.

Lien diététique – Ce que cette évolution change pour le diététicien

Avec les premières définitions, on cherchait surtout à repérer les patients qui comprenaient mal. Avec les définitions récentes, on se demande aussi : mes supports, mon accueil et mes démarches sont-ils faciles à comprendre ? Le diététicien agit donc à deux niveaux : il développe les compétences du public (ateliers, éducation) et il simplifie ce que sa structure produit (menus, fiches, inscriptions).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.1

Classez les trois actions suivantes selon qu'elles développent les compétences des personnes ou qu'elles rendent l'organisation plus accessible : a) un atelier où les participants comparent des étiquettes ; b) la réécriture du règlement de la cantine avec des pictogrammes ; c) un groupe de parents qui apprend à préparer une question pour la réunion avec la mairie.

Corrigé

a) Compétences des personnes (littératie fonctionnelle et critique). b) Organisation plus accessible (littératie organisationnelle). c) Compétences des personnes, au niveau interactif et critique : le groupe apprend à échanger et à agir sur un déterminant.

La littératie distribuée : on ne comprend pas toujours seul

Dans la vie réelle, beaucoup de personnes ne traitent pas seules l'information de santé. Un enfant lit le courrier à ses parents, une voisine explique l'ordonnance, un collègue montre l'application de la mutuelle. Edwards et coll. (2015) ont appelé ce phénomène la **littératie en santé distribuée** : les compétences utiles sont réparties entre la personne et son entourage, qui joue le rôle de **médiateur**.

Définition – Littératie en santé distribuée

Ensemble des compétences de littératie mobilisées par une personne **et** par les membres de son réseau (famille, amis, voisins, aidants) pour trouver, comprendre, juger et utiliser une information de santé. La littératie d'un foyer n'est donc pas celle de son membre le moins à l'aise.

Atout	Risque	Ce que fait le professionnel
L'entourage aide à comprendre et à agir	Le médiateur peut se tromper ou déformer le message	Vérifier ce qui a été compris par la personne elle-même (faire dire)
L'aide est disponible au quotidien, dans la langue de la famille	La personne perd son autonomie et ses choix	S'adresser d'abord à la personne, demander son accord pour associer un proche
Le groupe d'entraide crée de la confiance	Un enfant porte une responsabilité qui n'est pas la sienne	Ne pas utiliser un enfant comme interprète ; proposer un adulte relais ou un interprète professionnel
Le proche aidant connaît les habitudes	Le secret des informations personnelles n'est plus garanti	Demander à la personne ce qu'elle accepte de partager

Exemple – Un atelier qui s'appuie sur l'entourage

Dans une résidence pour personnes âgées, une diététicienne invite chaque résident à venir à l'atelier « petit-déjeuner » avec la personne qui fait ses courses (enfant, aide à domicile, voisin). Les deux repartent avec la même liste de courses en images. Trois semaines plus tard, elle demande au résident, puis à l'accompagnant, ce qui a changé. L'atelier développe ainsi la littératie du « binôme » sans retirer au résident ses choix.

La littératie en santé mentale

La notion a été étendue à d'autres domaines. Jorm et coll. (1997) ont défini la **littératie en santé mentale** comme les connaissances et les croyances sur les troubles psychiques qui aident à les reconnaître, à les prendre en charge ou à les prévenir. Pour le diététicien, elle concerne en particulier les troubles des conduites alimentaires (chapitre 4) : savoir reconnaître les signes, savoir à qui s'adresser, et ne pas croire que « c'est un caprice ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.2

Un père vient à un atelier avec sa fille de 11 ans, qui traduit tout ce que dit l'animatrice. Citez un atout et deux risques de cette situation, puis proposez une solution pour la séance suivante.

Corrigé

Atout : le père peut participer et la fille apprend aussi. Risques : la fille peut mal traduire des mots techniques ; elle porte une responsabilité d'adulte et entend des informations qui ne la concernent pas (par exemple sur la santé de son père). Solution : demander au père dans quelle langue il est à l'aise et prévoir une médiatrice ou un interprète pour les consignes importantes ; s'appuyer sur la démonstration et les images ; laisser la fille participer à l'atelier comme enfant, sans rôle de traductrice.

Les onze composantes de la littératie alimentaire

Vidgen et Gallegos (2014) ont construit leur définition à partir d'entretiens avec des experts et avec de jeunes adultes de milieux défavorisés en Australie. Ils décrivent, dans les quatre domaines, **onze composantes** qui sont autant d'objectifs possibles pour un atelier. Le tableau en donne une version simplifiée en français.

Domaine	Composante (d'après Vidgen et Gallegos, 2014)	Exemple d'objectif d'atelier
Planifier et gérer	1. Donner une place à l'alimentation dans son budget et son temps	Savoir prévoir un budget alimentaire pour la semaine
	2. Prévoir ses repas et ses achats	Savoir écrire ou dessiner une liste de courses pour 5 repas

Domaine	Composante (d'après Vidgen et Gallegos, 2014)	Exemple d'objectif d'atelier
	3. Faire des choix réalistes qui tiennent compte de ses besoins et de ses contraintes	Savoir adapter un menu quand l'argent manque en fin de mois
Sélectionner	4. Connaître les lieux où se procurer des aliments et leurs avantages	Savoir comparer le marché, le supermarché et l'épicerie solidaire
	5. Savoir ce que contient un aliment, d'où il vient, comment le conserver et l'utiliser	Savoir lire une liste d'ingrédients et une date
	6. Juger la qualité d'un aliment	Savoir choisir des fruits mûrs et repérer un emballage abîmé
Préparer	7. Faire un plat bon avec les aliments disponibles et le matériel de la maison	Savoir cuisiner un plat complet avec une seule plaque
	8. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité	Savoir refroidir et conserver un reste
Manger	9. Comprendre le lien entre l'alimentation et le bien-être	Savoir dire pourquoi un petit-déjeuner aide un enfant à l'école
	10. Ajuster ses consommations à ses besoins	Savoir reconnaître sa faim et choisir une portion
	11. Partager les repas et manger avec les autres	Savoir organiser un repas partagé

Attention – Littératie alimentaire et pauvreté

La littératie alimentaire ne suffit pas quand l'argent, le temps ou l'équipement manquent. Une personne peut savoir cuisiner les lentilles mais ne pas avoir de cuisine dans un hôtel social. Le diététicien évite donc de présenter le manque de compétences comme la cause principale d'une alimentation déséquilibrée : il agit aussi sur l'accès aux aliments et sur l'environnement (chapitre 2).

Lien diététique – Ce que l'on sait de l'effet des ateliers cuisine

Les revues de la littérature sur les interventions de cuisine chez l'adulte (par exemple Reicks et coll., 2014) rapportent des effets favorables sur la confiance en cuisine, les attitudes et certains comportements alimentaires, mais les études sont souvent courtes, sans groupe témoin et sur de petits effectifs. Il faut donc évaluer ses propres ateliers (chapitre 9) et ne pas promettre des résultats que l'on ne mesurera pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.3

Un centre social prévoit trois ateliers : « cuisiner les restes », « faire ses courses avec 30 € », « le goûter des enfants ». Pour chacun, indiquez le domaine de la littératie alimentaire principal et une composante du tableau.

Corrigé

« Cuisiner les restes » : préparer, composantes 7 (faire un plat avec ce que l'on a) et 8 (conserver un reste en sécurité). « Faire ses courses avec 30 € » : planifier et gérer, composantes 1 à 3, et sélectionner, composante 4. « Le goûter des enfants » : manger, composantes 9 et 10, et planifier, composante 2.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.1 – Définir la littératie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre compétences et les trois domaines de la définition de Sørensen et coll. (2012).

2. Nommez les trois niveaux de Nutbeam et donnez un exemple alimentaire du niveau critique.
3. Qu'ajoute la définition de l'OMS de 2021 par rapport aux premières définitions ?
4. Définissez la littératie en santé distribuée.
5. Citez les quatre domaines de la littératie alimentaire.
6. Pourquoi parle-t-on de « situations de littératie limitée » ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.1

1. Accéder, comprendre, évaluer, appliquer ; soins, prévention, promotion de la santé.
2. Fonctionnel, interactif, critique ; par exemple un groupe d'habitants qui obtient un marché de fruits et légumes à prix solidaires dans le quartier.
3. La littératie s'acquiert aussi dans la vie quotidienne et dans la famille, et elle dépend des organisations et des ressources disponibles.
4. Les compétences de la personne et de son entourage (famille, voisins, aidants) mobilisées ensemble pour utiliser une information de santé.
5. Planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger.
6. Parce que la littératie varie selon la personne, la situation (stress, langue, fatigue) et la complexité de l'information.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

5.3.2 Les données en France

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

L'enquête HLS19

L'enquête **HLS19** (*Health Literacy Survey 2019-2021*) a été conduite dans 17 pays européens par le réseau **M-POHL** de l'OMS Europe, avec un questionnaire commun. En France, elle a porté sur un échantillon représentatif d'adultes ; les résultats ont été publiés en 2021.

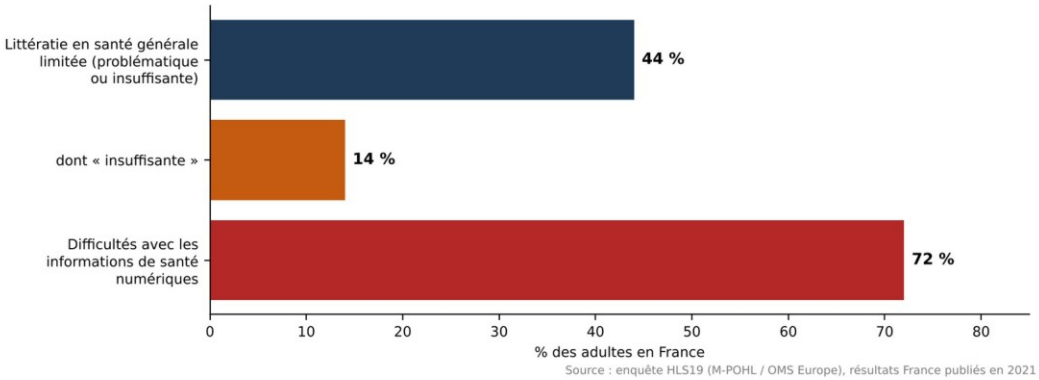


Figure 5.4 – La littératie en santé des adultes en France (HLS19)

Comprendre le schéma – Figure 5.4

1. Environ **44 %** des adultes ont une littératie en santé générale **limitée** : « problématique » (environ 30 %) ou « insuffisante » (environ 14 %) ; autrement dit, plus de **4 adultes sur 10** déclarent des difficultés à trouver, comprendre, juger ou utiliser les informations de santé.

2. Les difficultés sont encore plus fréquentes pour les informations **numériques** (environ 72 % déclarent au moins des difficultés), ce qui interroge les campagnes « tout en ligne ».
3. Comme ailleurs en Europe, le niveau suit un **gradient social** : il est plus bas chez les personnes ayant des difficultés financières, un faible niveau d'études, chez les plus âgés et chez les personnes en mauvaise santé.
4. Les tâches jugées les plus difficiles concernent l'**évaluation** (juger la fiabilité d'une information dans les médias, savoir si un conseil s'applique à soi).
5. Prudence : ces données sont **déclaratives** (difficulté ressentie) ; elles se comparent dans le temps et entre pays parce que l'instrument est commun.

Illettrisme et illectronisme

Indicateur	Donnée	Source
Illettrisme	7 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France, soit environ 2,5 millions de personnes ; plus de la moitié sont en emploi	ANLCI, enquête Information et vie quotidienne (Insee), 2011
Compétences des adultes	En 2023, 28 % des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit et 27 % du calcul ; scores de la France (255 en littératie, 257 en numératie) inférieurs à la moyenne de l'OCDE (261 et 264)	OCDE, PIAAC 2e cycle ; Dares Analyses n° 73, décembre 2024
Illectronisme	En 2025, 7 % des 16-74 ans n'utilisent pas internet ou n'ont aucune compétence numérique (10 % en 2021) ; 34 % sont en difficulté numérique, illectronisme ou compétences faibles	Insee, enquête TIC ménages 2025, publiée le 19 février 2026
Langue	Une part des publics des quartiers prioritaires maîtrise peu le français écrit (primo-arrivants)	Diagnostics locaux, structures d'apprentissage du français

Définition – Illettrisme, analphabétisme, français langue étrangère (FLE)

- **Illettrisme** : situation de personnes qui ont été **scolarisées en France** mais n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante (définition de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, ANLCI).
- **Analphabétisme** : personnes qui n'ont **jamais été scolarisées** et n'ont pas appris à lire et à écrire.
- **Français langue étrangère** : personnes scolarisées dans une autre langue, qui apprennent le français ; elles peuvent avoir une bonne littératie dans leur langue.
- **Illectronisme** : difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques et internet, par manque d'équipement ou de compétences.

Attention – Les chiffres ne se résument pas

L'illettrisme (7 %), l'illectronisme (7 % des 16-74 ans), les difficultés numériques (34 %) et la littératie en santé limitée (44 %) mesurent des choses **différentes** : on ne les additionne pas. Une personne peut lire parfaitement et avoir du mal à juger une information de santé ; une autre peut lire difficilement mais très bien échanger avec un professionnel.

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **HLS19** : dernières données françaises publiées (2021) ; le cycle suivant, **HLS24**, auquel participe la France, recueille ses données de juillet 2024 à juin 2026 ; son rapport international n'était pas publié au 26

octobre 2026.

- **PIAAC 2023** : résultats publiés en décembre 2024 ; en France, 28 % des 16-65 ans ont une faible maîtrise de l'écrit (Dares, 2024).
- **Illectronisme** : dernière enquête TIC ménages de l'Insee (2025, publiée le 19 février 2026) : 7 % des 16-74 ans.
- **Communiquer pour tous** : guide de Santé publique France (mai 2018, mis à jour en février 2025), cité par le guide d'accompagnement de 2025.
- **PNNS 5 (2026-2030) / SNANC** : le PNNS 5, lancé le 8 avril 2026, met l'accent sur les milieux de vie et sur la réduction des inégalités sociales de santé en nutrition (voir le chapitre 1).

Comment se calcule le niveau de littératie dans l'enquête HLS19

Pour lire correctement les chiffres de HLS19, il faut savoir comment le niveau de chaque personne est obtenu. La version courte utilisée dans de nombreux pays, le questionnaire **HLS19-Q12**, pose 12 questions du type « À quel point est-il facile pour vous de… ». Chaque question a quatre réponses possibles : très facile, facile, difficile, très difficile.

Méthode pas à pas – Du questionnaire au niveau de littératie (HLS19-Q12)

1. On compte les réponses valides (on retire les « je ne sais pas »). Un score n'est calculé que si la personne a répondu à la grande majorité des questions.

2. On compte les réponses « facile » ou « très facile ».

3. Score = réponses faciles ou très faciles / réponses valides × 100 (de 0 à 100).

4. On classe le score : plus de 83,3 = excellent ; plus de 66,7 à 83,3 = suffisant ; plus de 50 à 66,7 = problématique ; 50 ou moins = insuffisant. Les niveaux « problématique » et « insuffisant » forment la littératie **limitée**.

Calcul détaillé – Trois personnes interrogées (données fictives)

- Mme A. répond « facile » ou « très facile » à 9 questions sur 12 : 9 / 12 × 100 = **75,0** : niveau **suffisant**.
- M. B. répond facilement à 8 questions sur 12 : 8 / 12 × 100 = **66,7** : niveau **problématique**.
- Mme C. répond « je ne sais pas » à une question et facilement à 6 des 11 autres : 6 / 11 × 100 = **54,5** : niveau **problématique**. Si l'on avait divisé par 12, on aurait trouvé 50,0 et classé à tort Mme C. au niveau insuffisant.

Leçon : un pourcentage se calcule sur les réponses valides, et une valeur placée juste sur un seuil doit être classée avec soin.

Attention – Ce que mesure vraiment ce score

Le score mesure la **difficulté ressentie** face à des tâches d'information, pas une compétence testée. Deux biais sont possibles : une personne peut surestimer sa facilité par fierté, ou la sous-estimer par manque de confiance. Les niveaux servent à comparer des groupes et des pays, pas à juger un individu.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.4

Lors d'un diagnostic, un questionnaire inspiré du HLS19-Q12 donne les résultats suivants pour quatre personnes : a) 12 réponses valides dont 11 faciles ; b) 12 réponses valides dont 7 faciles ; c) 10 réponses valides dont 5 faciles ; d) 12 réponses valides dont 9 faciles. Calculez les scores et classez chaque personne.

Corrigé

a) 11 / 12 × 100 = 91,7 : excellent. b) 7 / 12 × 100 = 58,3 : problématique. c) 5 / 10 × 100 = 50,0 : insuffisant (50 ou moins). d) 9 / 12 × 100 = 75,0 : suffisant. Deux personnes sur quatre (b et c) ont une littératie limitée. On rappelle que, sur un si petit nombre, le résultat ne décrit pas un public : il sert seulement à s'entraîner au calcul.

D'autres sources pour décrire les compétences d'un public

L'enquête HLS19 n'est pas la seule source utile pour préparer un diagnostic. Trois autres sources aident à situer les compétences de base d'une population, à condition de bien savoir ce que chacune mesure.

Source	Ce qu'elle mesure	Ce que l'on retient pour un projet
Enquête internationale sur les compétences des adultes (PIAAC, OCDE ; 2e cycle réalisé en 2022-2023, résultats publiés en décembre 2024)	Compétences testées en lecture (littératie), en calcul (numératie) et en résolution de problèmes, chez les 16-65 ans	Les scores moyens des adultes en France sont inférieurs à la moyenne de l'OCDE ; 28 % ont une faible maîtrise de l'écrit (Dares, 2024) ; une part importante des adultes ne dépasse pas les niveaux les plus bas, surtout parmi les moins diplômés et les plus âgés
Tests de lecture de la Journée défense et citoyenneté (DEPP, chaque année)	Lecture des jeunes Français de 16 à 25 ans	En 2025, **14 %** des jeunes sont en difficulté de lecture, dont **6 %** en très grande difficulté, assimilable à l'illettrisme (DEPP, note n° 26.43, octobre 2026)
Enquête TIC ménages (Insee)	Usage d'internet et compétences numériques des 16-74 ans	L'illectronisme (7 % en 2025, contre 10 % en 2021) est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées, peu diplômées et aux revenus modestes
Données locales (centres sociaux, associations d'apprentissage du français, France Services)	Demandes d'aide, publics accueillis	Elles décrivent le terrain réel du projet, mais seulement pour les personnes qui viennent déjà

Méthode pas à pas – Utiliser ces chiffres dans un diagnostic, sans erreur

1. Citer la source, l'année et la population exacte (âge, territoire).

2. Ne pas additionner des indicateurs différents (illettrisme, illectronisme, littératie en santé).

3. Ne pas appliquer un pourcentage national à un quartier sans dire que c'est une **estimation**.

4. Compléter par des données locales et par des entretiens avec les acteurs du terrain.

5. Présenter les chiffres comme un **besoin d'adaptation** des actions, jamais comme un défaut des habitants.

Exemple – Une phrase de diagnostic bien construite

« Selon l'Insee (enquête 2025, publiée en 2026), 7 % des 16-74 ans sont en situation d'illectronisme en France et 34 % ont des difficultés numériques ; cette part est plus élevée chez les personnes âgées. Le club de retraités compte 120 adhérents ; lors de notre recueil, 22 des 80 adhérents présents disent n'avoir jamais utilisé internet. Nous prévoyons donc une inscription par téléphone et sur papier. »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.5

Un étudiant écrit dans son diagnostic : « Dans le quartier, 7 % + 34 % + 44 % = 85 % des habitants ont des problèmes de littératie. » Relevez les trois erreurs et réécrivez la phrase.

Corrigé

Erreurs : il additionne des indicateurs qui mesurent des choses différentes ; il compte plusieurs fois les mêmes personnes ; il applique des chiffres nationaux, portant sur des populations différentes (18-65 ans scolarisés en France, 16-74 ans, adultes), au quartier sans le dire. Réécriture : « En France, environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (HLS19, 2021) et 34 % des 16-74 ans ont des difficultés numériques (Insee, 2025). Ces chiffres nationaux ne décrivent pas directement le quartier ; nous les complétons par les données du centre social. »

5.3.3 Pourquoi la littératie compte en santé publique

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §6 (p. 18)

Les conséquences d'une littératie limitée

Les revues de la littérature (Berkman et coll., 2011, pour l'agence américaine AHRQ) associent un faible niveau de littératie en santé à :

- un **moindre recours à la prévention** (dépistages, vaccinations) et un recours plus tardif aux soins ;
- davantage d'**hospitalisations** et de passages aux urgences ;
- une moins bonne **compréhension des traitements** et des conseils (posologies, régimes prescrits) ;
- une moins bonne **gestion des maladies chroniques** (diabète, insuffisance cardiaque) ;
- un état de santé perçu plus mauvais et une mortalité plus élevée chez les personnes âgées.

En nutrition, une littératie limitée rend plus difficile la lecture des étiquettes, la compréhension des portions et des fréquences (« 5 fruits et légumes », « au moins 2 fois par semaine »), le tri entre informations fiables et publicités.

Littératie et inégalités sociales de santé

Lien diététique – Retour au chapitre 2

La littératie est à la fois un **déterminant** de la santé et un **médiateur** des inégalités : les personnes défavorisées ont plus souvent une littératie limitée, et les messages de prévention écrits, abstraits ou numériques profitent d'abord aux personnes les plus favorisées. Une campagne non adaptée peut donc **creuser** le gradient social (effet « loi inverse des soins »). L'**universalisme proportionné** (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à tous, avec une intensité et des modalités adaptées : la communication accessible en fait partie.

Exemple – Le Nutri-Score : un outil pensé pour la littératie

Le Nutri-Score a été conçu comme un logo **synthétique**, coloré et gradué (A à E), précisément parce que le tableau nutritionnel (pour 100 g, en kJ et en kcal) est difficile à utiliser pour une grande partie des consommateurs. Les études ont montré qu'il améliore la capacité à classer les produits selon leur qualité nutritionnelle, y compris chez les personnes ayant un faible niveau d'études. Il ne dispense pas d'expliquer : comparer **au sein d'une même famille** de produits, regarder aussi la liste d'ingrédients.

Par quels chemins la littératie agit-elle sur la santé ?

Constater qu'une littératie limitée est associée à une moins bonne santé ne dit pas **pourquoi**. Paasche-Orlow et Wolf (2007) ont proposé un modèle qui décrit trois chemins principaux. Il aide à choisir où agir dans un projet.

Chemin (Paasche-Orlow et Wolf, 2007)	Ce qui se passe	Exemple en nutrition	Où agir
Accès aux soins et à la prévention	La personne trouve mal les services, renonce aux démarches, arrive plus tard	Une famille ne demande pas le tarif social de la cantine ; un patient ne prend pas rendez-vous avec la diététicienne	Simplifier les démarches, accompagner, aller vers les publics
Relation avec les professionnels	L'échange est moins riche : moins de questions, moins de compréhension, moins de décision partagée	Un patient repart avec un plan alimentaire qu'il n'a pas compris et n'ose pas le dire	Former les professionnels, faire dire, donner du temps
Prendre soin de soi au quotidien	La personne applique moins bien les conseils et gère moins bien sa maladie	Une personne vivant avec un diabète ne sait pas adapter son repas quand elle mange à l'extérieur	Éducation pratique, supports simples, entraînement avec des aliments réels

Le modèle rappelle que la littératie ne joue pas seule : l'âge, la langue, les revenus, la culture, mais aussi la complexité du système de santé interviennent. Il montre surtout que les professionnels et les organisations sont sur deux des trois chemins.

À retenir – Trois chemins, trois leviers

Accès (simplifier et accompagner), relation (communiquer clairement et vérifier), autonomie au quotidien (éduquer avec des situations concrètes). Un projet efficace agit sur au moins deux de ces chemins.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.6

Mme L., 58 ans, a appris qu'elle a une hypertension. Elle a reçu un dépliant sur le sel et n'est pas venue à l'atelier du centre de santé, car l'inscription se faisait en ligne. Lors d'une consultation, elle a dit « oui » à toutes les questions. Repérez, pour chacun des trois chemins du modèle, un élément de la situation, puis proposez une action par chemin.

Corrigé

Accès : l'inscription en ligne l'a empêchée de venir à l'atelier ; action : inscription par téléphone ou à l'accueil. Relation : elle a dit « oui » à tout, sans que l'on vérifie sa compréhension ; action : faire dire, questions ouvertes, un seul message par consultation. Autonomie au quotidien : un dépliant ne suffit pas à savoir repérer le sel caché ; action : atelier pratique avec des emballages et une recette de plat peu salé, remise d'une fiche en images.

Le coût d'une littératie limitée

Plusieurs études ont essayé d'estimer ce que coûte au système de santé une littératie limitée, à cause des hospitalisations évitables, des complications des maladies chroniques et des passages aux urgences. Aux États-Unis, Vernon et coll. (2007) l'estimaient entre 106 et 238 milliards de dollars par an. Une revue européenne (Eichler et coll., 2009) concluait à un surcoût de l'ordre de **3 à 5 %** des dépenses totales de santé. Ces chiffres sont des ordres de grandeur, calculés avec des méthodes et dans des systèmes de santé différents.

Calcul détaillé – Ce que représente un ordre de grandeur de 3 à 5 % (exemple fictif)

Un territoire de santé dépense 400 millions d'euros par an pour les soins de ses habitants (donnée fictive).

- Hypothèse basse : 400 × 3 / 100 = **12 millions d'euros**.
- Hypothèse haute : 400 × 5 / 100 = **20 millions d'euros**.
- Un programme de formation de 50 professionnels à la communication claire coûte 25 000 € (donnée

fictive) : il représente 25 000 / 12 000 000 × 100 = **0,21 %** de l'hypothèse basse.

Interprétation : on ne peut pas en déduire que le programme « rapportera » 12 millions. Le calcul montre seulement que l'enjeu financier est important au regard du coût des actions ; l'efficacité réelle d'un programme doit être évaluée.

Attention – Un argument à manier avec respect

L'argument économique peut convaincre un financeur, mais il ne doit pas faire des personnes à littératie limitée un « coût ». Dans un dossier de projet, on le présente avec l'argument de **justice sociale** : rendre l'information accessible est d'abord une question d'égalité d'accès à la santé (chapitre 2).

Littératie et alimentation : ce que montrent les études

Les travaux sur la littératie et l'alimentation montrent des associations cohérentes : une littératie en santé limitée va souvent avec une moins bonne compréhension des étiquettes et des portions, un usage moins fréquent des informations nutritionnelles et, dans certaines études, une alimentation de moins bonne qualité. Ces associations sont en partie expliquées par le niveau d'études et les revenus, qui jouent sur les deux à la fois : on parle de **facteurs de confusion** (chapitre 16). C'est pourquoi les actions efficaces combinent l'éducation et l'amélioration de l'environnement (prix, offre, étiquetage simple comme le Nutri-Score).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.7

Une étude observe que les personnes à littératie limitée consomment moins de fruits et légumes. Un élu conclut : « Il suffit de leur apprendre à lire les étiquettes. » Expliquez pourquoi cette conclusion est trop rapide.

Corrigé

L'étude montre une association, pas une cause. Les personnes à littératie limitée ont souvent aussi des revenus plus faibles et moins accès à des commerces de fruits et légumes : ces facteurs de confusion peuvent expliquer une partie de la différence. Apprendre à lire une étiquette est utile, mais ne règle ni le prix ni l'offre. L'action doit combiner éducation, accès (prix, marché, paniers) et information simple.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.2 et 5.3.3 – Données et enjeux

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle part des adultes a une littératie en santé limitée en France selon HLS19 ? Et quelles sont les deux catégories qui la composent ?
2. Une personne répond facilement à 8 questions sur 12 du HLS19-Q12. Calculez son score et donnez son niveau.
3. Pourquoi ne peut-on pas additionner les taux d'illettrisme et d'illectronisme ?
4. Citez les trois chemins du modèle de Paasche-Orlow et Wolf (2007).
5. Citez trois conséquences d'une littératie limitée sur la santé.
6. Qu'est-ce qu'un facteur de confusion dans l'association entre littératie et alimentation ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.2 et 5.3.3

1. Environ 44 % ; littératie « problématique » (environ 30 %) et « insuffisante » (environ 14 %).
2. 8 / 12 × 100 = 66,7 : niveau problématique (de plus de 50 à 66,7).
3. Ils mesurent des choses différentes, sur des populations différentes, et une même personne peut être

comptée dans les deux.

4. L'accès aux soins et à la prévention ; la relation avec les professionnels ; la capacité à prendre soin de soi au quotidien.
5. Moins de prévention, plus d'hospitalisations et de passages aux urgences, moins bonne compréhension des traitements, moins bonne gestion des maladies chroniques.
6. Un facteur, comme le revenu ou le niveau d'études, lié à la fois à la littératie et à l'alimentation, qui peut expliquer une partie de leur association.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de données et le modèle des trois chemins, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.2 et 5.3.3 et je refais les exercices d'application.

5.3.4 Repérer sans stigmatiser

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Méthode pas à pas – L'approche des « précautions universelles »

Il est impossible de savoir, en regardant quelqu'un, s'il a des difficultés de littératie ; les personnes les **cachent** souvent par honte. Plutôt que de « tester » le public, on applique à **tous** une communication claire : c'est l'approche des **précautions universelles** (*health literacy universal precautions*, AHRQ). Tout le monde y gagne, et personne n'est désigné.

Signaux possibles (à interpréter avec prudence)	Exemples
Évitement de l'écrit	« J'ai oublié mes lunettes », « Je le lirai chez moi », formulaire rempli par un proche
Difficultés avec les chiffres	Confusion entre grammes et kilos, entre 100 g et la portion, difficulté à calculer un prix au kilo
Questions déjà traitées dans le document	Demander ce qui est écrit sur le support distribué
Faible participation à l'écrit	Questionnaires non remplis, fiches recettes non utilisées
Difficultés numériques	Pas d'adresse mail, inscription en ligne impossible, smartphone utilisé seulement pour appeler

Méthode pas à pas – Questions simples pour adapter, sans juger

- « Comment préférez-vous recevoir les informations : par écrit, en vidéo, en parlant ? »
- « Est-ce que quelqu'un vous aide habituellement pour les papiers ? »
- « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? »
- Dans un questionnaire de diagnostic : proposer une passation **orale** (entretien) ou avec pictogrammes, plutôt qu'un questionnaire écrit autoadministré.

Faut-il mesurer la littératie de chaque personne ? Les outils et le débat

Des outils de mesure individuelle existent depuis les années 1990. Ils sont utiles en **recherche** et pour évaluer un programme, mais leur usage pour trier les personnes dans un atelier ou une consultation est discuté.

Outil	Principe	Durée	Usage raisonnable
REALM (Davis et coll., 1993)	La personne lit à voix haute une liste de mots médicaux ; on compte les mots bien prononcés	2 à 3 minutes	Recherche ; il mesure la lecture de mots, pas la compréhension
TOFHLA et sa version courte (Parker et coll., 1995)	Textes à trous et questions sur une ordonnance, un rendez-vous	7 à 22 minutes	Recherche
NVS (Weiss et coll., 2005)	Six questions sur une étiquette de crème glacée (encadré L3, 5.5)	3 minutes	Recherche, évaluation de programmes
Question unique (Chew et coll., 2004)	« Êtes-vous à l'aise pour remplir seul(e) des formulaires médicaux ? »	Moins d'une minute	Repérage rapide en soins, avec tact
Questionnaires de difficulté ressentie (HLS-EU, HLQ)	Autoévaluation de tâches de santé	5 à 20 minutes	Enquêtes de population, diagnostic d'un groupe

Attention – Pourquoi on ne « teste » pas le public d'un atelier

Faire lire une liste de mots ou remplir un test à des adultes venus pour un atelier peut être vécu comme un examen humiliant. La personne peut partir et ne plus revenir. De plus, le résultat ne change presque rien à ce que l'on doit faire : avec les **précautions universelles**, la communication est déjà adaptée à tous. On réserve donc ces outils aux études, avec un consentement éclairé et une présentation respectueuse.

Exemple – Utiliser un outil pour évaluer un programme, pas pour trier les personnes

Un réseau d'éducation thérapeutique veut savoir si son programme améliore la capacité des patients à lire une étiquette. Avec l'accord des participants, il fait passer un court test inspiré du NVS au début et à la fin du programme, de façon anonyme. Il compare les résultats du groupe, sans jamais les utiliser pour exclure ou classer un patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.8

Une stagiaire propose de faire lire une liste de mots médicaux à chaque nouveau participant d'un atelier de cuisine, « pour faire des groupes de niveau ». Donnez deux arguments contre cette idée et une alternative.

Corrigé

Arguments : le test peut humilier et faire fuir les personnes qui en ont le plus besoin ; il mesure la lecture de mots médicaux, pas la capacité à cuisiner ou à comprendre une recette ; les groupes de niveau stigmatisent. Alternative : appliquer à tous les précautions universelles (consignes orales et en images, démonstration, binômes mixtes) et demander simplement à l'inscription comment la personne préfère recevoir les informations.

Comprendre la honte pour mieux accueillir

Les difficultés avec l'écrit sont souvent cachées. Parikh et coll. (1996) ont interrogé des patients d'un hôpital américain dont la littératie était limitée : environ **4 sur 10** disaient ressentir de la honte face à leurs difficultés de lecture ; parmi eux, environ **les deux tiers** n'en avaient jamais parlé à leur conjoint, et près d'**un sur cinq** n'en avait jamais parlé à personne. Les personnes développent alors des **stratégies de contournement** très efficaces, qui rendent les difficultés invisibles pour les professionnels.

Stratégie de contournement	Ce que le professionnel peut faire, pour tous
Venir toujours accompagné d'un proche qui lit	Proposer de lire ensemble les documents importants à tous les participants

Stratégie de contournement	Ce que le professionnel peut faire, pour tous
Mémoriser à l'oral ce qui a été dit	Répéter les messages clés en fin de séance ; laisser un support en images
Repérer les produits par la couleur ou la forme de l'emballage	Utiliser de vrais emballages en atelier ; associer couleurs et pictogrammes
Prendre les papiers « pour les lire à la maison »	Remplir les formulaires ensemble, dans un endroit calme
Ne pas revenir quand un écrit est demandé	Réduire l'écrit à l'inscription et à l'évaluation (oral, smileys, gommettes)

À retenir – Une règle d'accueil

Ce n'est pas à la personne de révéler ses difficultés : c'est à la structure de rendre l'information accessible sans que personne n'ait à se signaler. Une phrase neutre, valable pour tous, aide : « Ici, on remplit les papiers ensemble, c'est plus rapide. »

Calcul détaillé – Appliquer des proportions à un groupe (ordre de grandeur, données fictives)

Un programme d'ateliers accueille 60 adultes, dont on estime, d'après le diagnostic, que 25 environ ont une littératie limitée.

- Si 4 sur 10 ressentent de la honte : 25 × 0,4 = **10 personnes**.
- Si les deux tiers d'entre elles n'en ont pas parlé à leur conjoint : 10 × 2 / 3 ≈ **7 personnes**.

Interprétation : ces chiffres viennent d'une étude ancienne et étrangère ; on ne peut pas les appliquer exactement au groupe. Ils montrent simplement qu'une partie du public peut vivre ses difficultés en silence, ce qui justifie une communication claire pour tous.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.9

À la fin d'un atelier, une participante refuse de remplir le questionnaire de satisfaction : « Je n'ai pas le temps, je le ferai la prochaine fois. » Proposez deux façons de recueillir son avis sans la mettre en difficulté, valables pour tout le groupe.

Corrigé

Une évaluation par gommettes sur des smileys pour tout le groupe, avec les questions lues à voix haute ; un tour de parole rapide « Une chose que vous allez refaire ». On peut aussi proposer à chacun de répondre à l'oral à l'animatrice en rangeant la salle. Ces solutions valent pour tous et ne désignent personne.

Les précautions universelles en pratique : la boîte à outils de l'AHRQ

L'agence américaine pour la recherche et la qualité en santé (AHRQ) a publié en 2010, puis révisé, une **boîte à outils des précautions universelles en littératie** (*Health Literacy Universal Precautions Toolkit*). Elle est conçue pour les cabinets et les centres de soins, mais ses principes s'appliquent très bien à une structure de santé publique, à un centre social ou à un service de restauration. Elle s'organise en quatre domaines.

Domaine de la boîte à outils	Exemples d'outils	Adaptation pour une action en nutrition
Améliorer la communication orale	Faire dire, préparer les messages clés, utiliser des mots simples	Trois messages au plus par atelier, démonstration avant explication
Améliorer la communication écrite	Évaluer et simplifier les documents, utiliser des supports adaptés	Fiches recettes en photos testées auprès du public

Domaine de la boîte à outils	Exemples d'outils	Adaptation pour une action en nutrition
Améliorer l'autonomie et le pouvoir d'agir	Fixer des objectifs avec la personne, l'encourager à poser des questions	Chaque participant choisit une action à essayer chez lui
Améliorer les systèmes de soutien	Orienter vers les aides, faciliter les démarches, s'occuper des besoins non médicaux	Lien avec l'épicerie solidaire, aide à l'inscription à la cantine, contact France Services

Méthode pas à pas – Lancer une démarche de précautions universelles dans une structure

1. **Constituer une petite équipe** : un responsable, un professionnel de terrain, un usager.
2. **Faire un état des lieux** : relire les documents, observer l'accueil, demander l'avis de quelques usagers.
3. **Choisir deux ou trois améliorations** faciles et visibles (signalétique, inscription, fiches).
4. **Tester** chaque amélioration avec des usagers avant de la généraliser.
5. **Former** toute l'équipe, y compris l'accueil et les bénévoles.
6. **Suivre** quelques indicateurs : nombre d'inscriptions par téléphone, réussite des « faire dire », documents testés.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.10

Une épicerie solidaire veut appliquer les précautions universelles. Proposez une action pour chacun des quatre domaines de la boîte à outils.

Corrigé

Communication orale : les bénévoles présentent oralement les nouveaux produits du mois et vérifient avec « montrez-moi ». Communication écrite : affichage des prix avec des chiffres en gros et des pictogrammes de familles d'aliments, testé avec des bénéficiaires. Autonomie : à chaque atelier, chacun choisit une recette à refaire et la raconte la fois suivante. Systèmes de soutien : un point d'aide aux démarches (CAF, cantine) avec un partenaire, et une orientation vers France Services.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.4 – Repérer sans stigmatiser

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez l'approche des précautions universelles.
2. Citez trois signaux possibles de difficulté avec l'écrit.
3. Pourquoi un signal n'est-il jamais une preuve ?
4. Citez un outil de mesure individuelle de la littératie et dites dans quel cadre on peut l'utiliser.
5. Citez deux stratégies de contournement utilisées par des personnes qui cachent leurs difficultés.
6. Citez les quatre domaines de la boîte à outils de l'AHRQ.

Corrigé – Point d'étape 5.3.4

1. Appliquer à tout le public une communication claire, au lieu de chercher à repérer ou tester les personnes en difficulté.
2. « J'ai oublié mes lunettes », formulaire rempli par un proche, questions sur ce qui est déjà écrit, difficulté avec les chiffres, pas d'adresse mail.
3. Parce qu'il peut avoir d'autres causes (fatigue, oubli réel, manque de temps) ; on ne pose pas de diagnostic sur une personne.
4. REALM, TOFHLA, NVS ou la question unique de Chew ; en recherche ou pour évaluer un programme, avec

consentement, jamais pour trier les participants.

5. Venir avec un proche qui lit, mémoriser à l'oral, repérer les produits par la couleur, emporter les papiers « pour les lire à la maison ».

6. Communication orale, communication écrite, autonomie et pouvoir d'agir, systèmes de soutien.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.4 et je refais les exercices d'application.

5.3.5 Adapter les messages et les supports

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 122 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

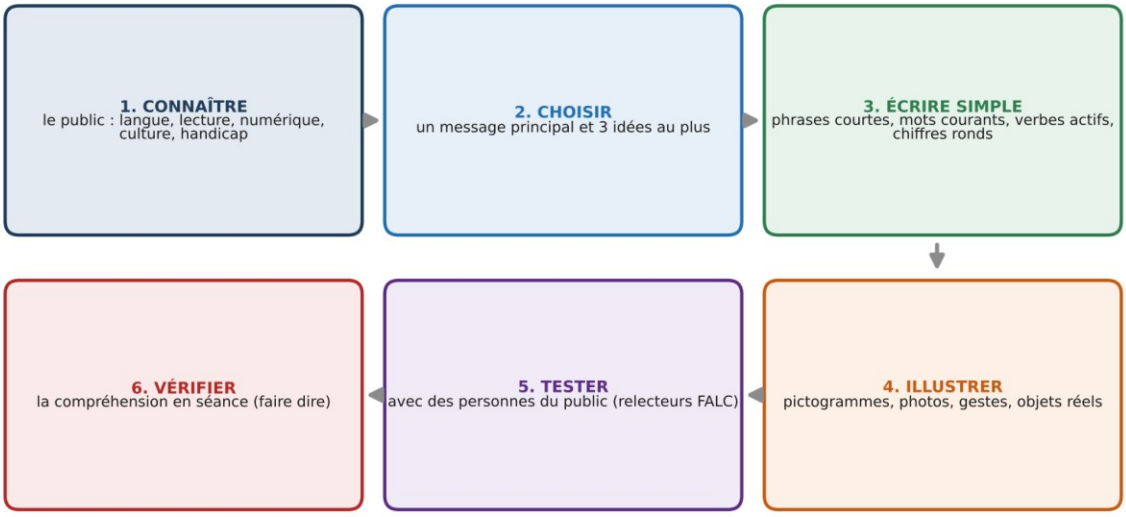


Figure 5.5 – Six étapes pour une communication accessible

Comprendre le schéma – Figure 5.5

1. Connaître le public : langue, maîtrise de l'écrit, accès au numérique, culture, handicap (visuel, auditif, cognitif) ; le diagnostic (chapitre 7) doit recueillir ces informations.

2. Choisir un message principal et au plus trois idées secondaires : trop d'informations noient l'essentiel.

3. Écrire simple : phrases courtes (une idée par phrase), mots courants, verbes actifs, pas de sigles, chiffres ronds et concrets (« une poignée » plutôt que « 30 g »).

4. Illustrer : pictogrammes, photos réalistes, objets réels (emballages, verres, cuillères), gestes ; l'image doit dire la même chose que le texte.

5. Tester le support auprès de personnes du public (relecteurs, groupe test) avant de l'imprimer.

6. Vérifier la compréhension en séance par le « faire dire ».

Les règles d'écriture claire (guide « Communiquer pour tous »)

Règle	À éviter	À préférer
Une idée par phrase, 15 mots au plus	« Afin de favoriser un apport suffisant en fibres, il est recommandé de privilégier les féculents complets lors de chacun des repas. »	« Mangez du pain complet ou des pâtes complètes. Ils contiennent des fibres. »
Mots courants	Légumineuses, apports, privilégier	Lentilles, pois chiches, haricots secs ; manger ; choisir
Forme active et directe	« Il est conseillé de limiter… »	« Mangez moins de… »
Phrases positives	« Ne pas oublier de boire »	« Buvez de l'eau »
Chiffres concrets	« 400 g de fruits et légumes par jour »	« 5 fruits et légumes par jour : une portion = la taille d'un poing »
Pas de sigles	PNNS, AJR, IMC	« Les conseils officiels » ; expliquer si nécessaire
Mise en page aérée	Texte justifié, italique, majuscules, police fantaisie	Police sans empattement, 14 points au moins, aligné à gauche, gras pour l'essentiel, puces
Image utile	Image décorative ou ambiguë	Photo réelle du geste ou de l'aliment

Définition – FALC – Facile à lire et à comprendre

Méthode de rédaction issue des **règles européennes** (Inclusion Europe, 2009), conçue avec et pour les personnes en situation de **handicap intellectuel**, mais utile à beaucoup d'autres publics (personnes âgées, personnes apprenant le français, personnes fatiguées ou stressées). Un document FALC est **relu et validé** par des personnes concernées et peut porter le logo européen « Facile à lire ». Exemple de ressource en santé : *SantéBD*, bandes dessinées en FALC pour expliquer la santé et les consultations.

Mesurer la lisibilité d'un texte

La **lisibilité** d'un texte dépend de la longueur des phrases et des mots. L'indice de **Flesch**, adapté au français par Kandel et Moles (1958), en donne une estimation :

Méthode pas à pas – Indice de lisibilité de Kandel et Moles (adaptation française de Flesch)

L = 207 − 1,015 × (nombre de mots / nombre de phrases) − 73,6 × (nombre de syllabes / nombre de mots)
Interprétation (échelle de Flesch) : 0-30 très difficile ; 30-50 difficile ; 50-60 assez difficile ; 60-70 standard ; 70- 80 assez facile ; 80-90 facile ; 90-100 très facile.

Exemple – Calcul détaillé : un dépliant avant et après réécriture

Version initiale : 120 mots, 5 phrases, 204 syllabes.

- Mots par phrase : 120 / 5 = **24** ; syllabes par mot : 204 / 120 = **1,7**.
- L = 207 − 1,015 × 24 − 73,6 × 1,7 = 207 − 24,36 − 125,12 = **57,52** → « assez difficile ».

Version réécrite : 96 mots, 12 phrases, 144 syllabes.

- Mots par phrase : 96 / 12 = **8** ; syllabes par mot : 144 / 96 = **1,5**.
- L = 207 − 1,015 × 8 − 73,6 × 1,5 = 207 − 8,12 − 110,4 = **88,48** → « facile ».

Gain : 88,48 − 57,52 = **30,96 points**. Limite : l'indice ne mesure ni le sens, ni la mise en page, ni l'adéquation au public ; il complète le test auprès des personnes, il ne le remplace pas.

Adapter l'oral, l'atelier et le numérique

Support	Adaptations
Oral (séance, atelier)	Parler lentement, mots simples, un message à la fois, reformuler, montrer (gestes, objets), répéter les messages clés en fin de séance, s'appuyer sur l'expérience des participants
Atelier culinaire	Recettes en images (photos de chaque étape), quantités en contenants courants (verre, cuillère, poignée), démonstration avant de faire, binômes mixtes
Écrit (affiche, dépliant)	Un message par affiche, titre qui dit l'essentiel, pictogrammes, tests de compréhension
Numérique (site, réseaux, vidéo)	Vidéos courtes sous-titrées, audio, navigation simple, version papier ou accompagnement (médiateur numérique, France Services) ; ne jamais réserver une inscription au seul numérique
Langues	Traduction professionnelle ou interprétariat (médiation en santé), supports multilingues testés ; éviter les traducteurs automatiques non relus pour des messages de santé
Handicap	Contrastes et grande police (déficience visuelle), sous-titres et langue des signes (déficience auditive), FALC (déficience intellectuelle), accessibilité des locaux

Situer un texte sur l'échelle et compter les syllabes

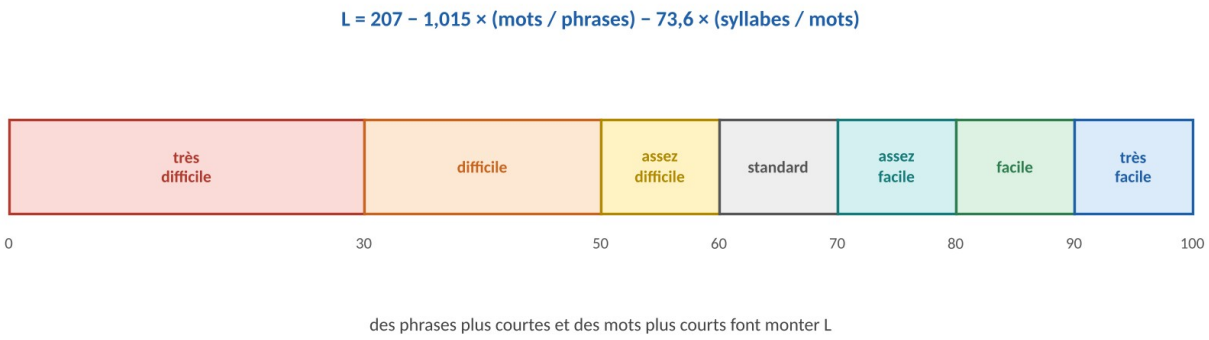


Figure 5.5 bis – L'échelle de lisibilité de Kandel et Moles

Comprendre le schéma – Figure 5.5 bis

1. La barre va de **0** (texte très difficile) à **100** (texte très facile) ; chaque couleur correspond à une catégorie de l'échelle de Flesch reprise par Kandel et Moles (1958).
2. Les zones ne sont pas de même largeur : la zone « très difficile » couvre 0 à 30, alors que les zones « assez difficile » à « très facile » ne couvrent que 10 points chacune. Un gain de 10 points peut donc faire changer de catégorie.
3. La formule rappelle les deux leviers : la **longueur des phrases** (mots par phrase) et la **longueur des mots** (syllabes par mot). Le second pèse beaucoup : passer de 1,7 à 1,5 syllabe par mot fait gagner 73,6 × 0,2 = 14,72 points.
4. Pour un public à littératie limitée, on vise au moins la zone « facile » (80 et plus), puis on teste le support auprès de quelques personnes.

Méthode pas à pas – Compter mots, phrases et syllabes à la main

1. Les mots : chaque groupe de lettres séparé par un espace compte pour un mot ; « l'eau » compte pour deux mots (l' et eau) ; un nombre écrit en chiffres compte pour un mot.

2. Les phrases : on compte les phrases terminées par un point, un point d'exclamation ou d'interrogation ; une liste à puces sans point compte pour une phrase par puce.

3. Les syllabes : on les compte **à l'oreille**, comme on les prononce en parlant normalement ; le « e » muet de fin de mot ne compte pas (« lé-gumes » = 2) ; un sigle ou un nombre se compte comme il se dit (« 14 » = qua-torze = 2).

4. Une seule convention : on garde la même façon de compter pour la version initiale et la version réécrite ; c'est la **comparaison** qui compte, plus que la valeur exacte.

Calcul détaillé – Une phrase comptée pas à pas

« Mangez des légumes à chaque repas. » : man-gez (2) des (1) lé-gumes (2) à (1) chaque (1) re-pas (2) = **9 syllabes** ; **6 mots** ; **1 phrase**.

- Mots par phrase : 6 ; syllabes par mot : 9 / 6 = **1,5**.
- L = 207 − 1,015 × 6 − 73,6 × 1,5 = 207 − 6,09 − 110,4 = **90,51** : très facile.

Remarque : une phrase seule donne un indice peu fiable ; on calcule l'indice sur un passage d'au moins 100 mots, ou sur tout le support s'il est court.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.11

Comptez les mots, les syllabes et calculez l'indice de la consigne suivante : « Lavez vos mains avant de cuisiner. Coupez les carottes en rondelles. » (On compte « ron-delles » = 2 syllabes.)

Corrigé

Mots : 6 + 5 = 11 ; phrases : 2 ; syllabes : la-vez (2) vos (1) mains (1) a-vant (2) de (1) cui-si-ner (3) = 10 ; cou-pez (2) les (1) ca-rottes (2) en (1) ron-delles (2) = 8 ; total 18. Mots par phrase : 11 / 2 = 5,5 ; syllabes par mot : 18 / 11 = 1,636. L = 207 − 1,015 × 5,5 − 73,6 × 1,636 = 207 − 5,58 − 120,44 = 80,98 : facile. Le calcul porte sur un texte très court : il sert ici d'entraînement.

Remplacer les mots du métier par des mots de tous les jours

Le vocabulaire de la nutrition est plein de mots techniques que le professionnel n'entend plus comme difficiles. Une liste de remplacements, établie en équipe et complétée après chaque test de support, fait gagner du temps et rend les documents cohérents.

Mot du métier	Mot ou expression de tous les jours
Légumineuses, légumes secs	Lentilles, pois chiches, haricots secs (donner des exemples)
Féculents	Pain, pâtes, riz, pommes de terre, semoule
Produits laitiers	Lait, yaourt, fromage
Apport, consommation	Ce que l'on mange, ce que l'on boit
Privilégier	Choisir plus souvent
Limiter	Manger moins souvent, en petite quantité
Collation	Petit en-cas, goûter
Hydratation	Boire
Matières grasses ajoutées	Huile, beurre, crème

Mot du métier	Mot ou expression de tous les jours
Aliments ultra-transformés	Produits avec une longue liste d'ingrédients que l'on n'a pas dans sa cuisine
Densité énergétique	Aliment qui apporte beaucoup de calories pour un petit volume
Rassasiement	Se sentir plein à la fin du repas
Glucides complexes	Pain, pâtes, riz (le mot « glucides » est à expliquer s'il est utile)
Portion	Quantité dans l'assiette ; montrer avec la main, un verre, une cuillère
Équilibré	Varié, avec des légumes, un féculent et un peu de viande, de poisson, d'œufs ou de légumes secs

Attention – Simplifier sans infantiliser

Écrire simplement ne veut pas dire écrire comme pour un enfant. On garde un ton adulte, on vouvoie (sauf public d'enfants ou d'adolescents), on évite les diminutifs et les jeux de mots. Si un mot technique est utile, par exemple « allergène » ou « Nutri-Score », on le garde et on l'explique une fois avec des mots simples.

Exemple – Une phrase réécrite en deux temps

Version initiale : « La consommation de féculents complets permet d'augmenter les apports en fibres et de favoriser le rassasiement. » Première réécriture : « Le pain complet et les pâtes complètes contiennent des fibres. » Seconde réécriture, après le test : « Le pain complet et les pâtes complètes calent plus longtemps. » Lors du test, plusieurs personnes ne savaient pas à quoi servent les fibres : l'effet ressenti (« calent plus longtemps ») a été mieux compris que le nom du nutriment.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.12

Réécrivez avec des mots de tous les jours : « Privilégiez les légumineuses et limitez les produits ultra-transformés lors de vos collations. »

Corrigé

« Mangez plus souvent des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs. Pour le goûter, choisissez un fruit, du pain ou un yaourt plutôt que des biscuits ou des barres. » On a remplacé chaque mot technique par des exemples concrets et découpé la phrase en deux idées.

Mettre en page pour être lu

Un texte bien écrit peut rester difficile à lire s'il est mal présenté. La mise en page est la première chose que voit le lecteur : elle décide souvent s'il va lire ou non.

Élément	Ce qui aide	Ce qui gêne
Police	Sans empattement (de type Arial, Verdana), 14 points au moins pour un document à lire seul, 12 au minimum	Police fantaisie ou manuscrite, petits caractères
Mise en valeur	Le gras pour les mots importants	L'italique, le souligné en dehors des liens, les MAJUSCULES sur des phrases entières
Alignement	Texte aligné à gauche, une phrase par ligne si possible	Texte justifié (espaces irréguliers), phrase coupée entre deux pages
Espace	Interligne large, marges, paragraphes courts, beaucoup de blanc	Page pleine, texte serré

Élément	Ce qui aide	Ce qui gêne
Structure	Titre qui dit l'essentiel, intertitres sous forme de question, puces	Titre abstrait, longs paragraphes
Couleurs	Texte foncé sur fond clair, contraste fort	Texte sur une photo, couleurs pâles, information donnée seulement par la couleur
Images	Une image à côté du texte qu'elle illustre	Image décorative, éloignée du texte
Chiffres	En chiffres (« 3 verres »), unités connues	Chiffres en lettres longues, grands nombres, pourcentages non expliqués

Méthode pas à pas – Relire un support en 5 minutes avant de le tester

1. Le titre dit-il ce que le lecteur va trouver ou faire ?

2. Y a-t-il un seul message principal, visible en premier ?

3. Chaque phrase fait-elle moins de 15 mots ?

4. La police, la taille et le contraste respectent-ils le tableau ci-dessus ?

5. Chaque image dit-elle la même chose que le texte voisin ?

6. Le lecteur sait-il quoi faire à la fin (venir, appeler, essayer une recette) ?

À vous de jouer – Exercice d'application 5.13

Une affiche pour un atelier est écrite en majuscules italiques jaunes sur la photo d'un marché. Le titre est « PROGRAMME ALIMENTATION SANTÉ ». Relevez quatre défauts et proposez une nouvelle présentation.

Corrigé

Défauts : majuscules et italique difficiles à lire ; texte jaune sur une photo, contraste faible ; titre abstrait qui ne dit pas ce que l'on va faire ; aucune information pratique visible. Nouvelle présentation : fond blanc, titre en gras noir « Cuisinons ensemble le mardi », photo de personnes qui cuisinent placée à côté du texte, trois informations avec pictogrammes (horloge : mardi 14 h ; lieu : salle du rez-de-chaussée ; pièce barrée : gratuit), contact téléphonique en gros.

Les images qui aident et celles qui trompent

Une revue de la littérature de Houts et coll. (2006) a montré que des images bien choisies, placées à côté d'un texte ou d'une explication orale, améliorent l'**attention**, la **compréhension**, la **mémorisation** et l'**application** des consignes de santé, surtout chez les personnes à littératie limitée. Mais une image peut aussi tromper : elle doit être choisie, puis testée.

Image qui aide	Image qui trompe ou gêne
Photo réelle d'un geste (rincer les lentilles)	Dessin humoristique dont on ne comprend pas le sens
Photo d'une portion à côté d'une main ou d'un verre	Photo d'une assiette sans repère de taille
Pictogramme simple, toujours le même pour la même idée	Pictogramme différent à chaque page pour la même idée
Image qui montre ce qu'il faut faire	Image qui montre seulement ce qu'il ne faut pas faire (le geste « interdit » est souvent retenu)
Personnes diverses, dans des situations réalistes	Corps idéalisés, images qui stigmatisent (personne en surpoids triste)

Attention – Un pictogramme n'est pas universel

Un même pictogramme peut être compris différemment selon la culture, l'âge ou l'habitude. Une croix rouge peut vouloir dire « interdit » ou « soins » ; une main levée peut vouloir dire « stop » ou « bonjour ». Les normes de conception des pictogrammes publics (série ISO 9186) prévoient d'ailleurs de **tester leur compréhension** auprès du public avant de les utiliser.

Calcul détaillé – Tester quatre pictogrammes d'allergènes (données fictives)

On montre quatre pictogrammes, sans texte, à 15 parents d'une crèche, et l'on demande « Qu'est-ce que cela veut dire ? ». Dans ce cours, on retient qu'un pictogramme est **validé** si au moins deux personnes sur trois le comprennent (66,7 %).

- Lait (verre de lait) : 14 / 15 × 100 = **93,3 %** : validé.
- Œuf : 13 / 15 = **86,7 %** : validé.
- Gluten (épi de blé) : 8 / 15 = **53,3 %** : non validé ; plusieurs parents ont répondu « céréales » ou « pain ».
- Fruits à coque (noisette) : 9 / 15 = **60,0 %** : non validé.

Décision : on garde les deux premiers ; pour le gluten et les fruits à coque, on ajoute le mot sous l'image et des exemples d'aliments (« blé : pain, pâtes, gâteaux »), puis on refait le test.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.14

Pour une fiche sur l'hygiène en cuisine, une collègue propose trois images : une main barrée devant un réfrigérateur, la photo d'une personne qui se lave les mains, un dessin de microbe souriant. Dites lesquelles garder et pourquoi.

Corrigé

On garde la photo d'une personne qui se lave les mains : elle montre le geste attendu. La main barrée est ambiguë (on ne sait pas ce qui est interdit) et montre ce qu'il ne faut pas faire. Le microbe souriant donne une image positive de ce qu'on veut éviter et n'apporte aucune information. On peut ajouter une photo du réfrigérateur rangé correctement, avec un mot sous chaque zone.

Écrire en FALC pas à pas

Les règles européennes du FALC ont été publiées en 2009 par Inclusion Europe dans le guide *L'information pour tous*, rédigé avec des personnes en situation de handicap intellectuel. Elles vont plus loin que l'écriture claire : chaque règle est pensée pour une personne qui lit peu ou lentement et qui a besoin de repères stables.

Étape	Règles principales du FALC
Avant d'écrire	Savoir qui va lire et ce qu'il doit savoir ou faire ; associer dès le début des personnes concernées
Les mots	Mots simples et connus ; expliquer un mot difficile la première fois ; toujours le même mot pour la même chose ; pas de mots d'une autre langue, pas d'abréviations ni de sigles ; pas d'images de langage (« avoir un petit creux »)
Les phrases	Phrases courtes, une idée par phrase ; forme active et positive ; s'adresser directement au lecteur (« vous ») ; les idées dans l'ordre où elles se passent
Les nombres	En chiffres (« 3 » et non « trois ») ; éviter les pourcentages et les grands nombres (« beaucoup de personnes ») ; dates écrites en entier (« mardi 12 janvier »)
La mise en page	Police claire et grande, pas d'italique, texte aligné à gauche, une phrase par ligne si possible, ne pas couper une phrase entre deux pages ; images à côté du texte

Étape	Règles principales du FALC
Après l'écriture	Faire relire par des personnes concernées ; corriger ; elles valident le document, qui peut alors porter le logo européen « Facile à lire »

Exemple – Une consigne d'hygiène réécrite en FALC

Version initiale : « Le lavage des mains, réalisé avant toute manipulation de denrées et après chaque passage aux sanitaires, constitue une mesure d'hygiène essentielle. »

Version FALC (avec une photo à gauche de chaque ligne) :

- « Lavez vos mains avec du savon. »
- « Lavez vos mains avant de cuisiner. »
- « Lavez vos mains après être allé aux toilettes. »
- « Lavez vos mains pendant 30 secondes. Chantez une petite chanson dans votre tête. »

Le verbe « lavez » est répété : en FALC, la répétition aide à repérer l'information.

Attention – FALC, écriture claire : ne pas confondre

L'écriture claire s'adresse à tout le monde et le professionnel peut l'appliquer seul. Le FALC est une méthode précise, conçue avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel ; un document n'est FALC que s'il a été **relu et validé** par des personnes concernées. Des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des associations proposent ce travail de relecture, qui doit être reconnu et, si possible, rémunéré.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.15

Réécrivez en FALC l'invitation suivante, pour des adultes d'un foyer d'hébergement : « Un atelier de sensibilisation à l'équilibre alimentaire aura lieu le 12/03/2027 à 14h30 au réfectoire ; la participation de 80 % des résidents est souhaitée. »

Corrigé

« Venez cuisiner avec nous. » « C'est le vendredi 12 mars 2027. » « Nous commençons à 14 heures 30. » « C'est dans la salle à manger. » « Nous allons préparer un repas bon pour la santé. » « Nous voulons que beaucoup de personnes viennent. » (Photos : des personnes qui cuisinent, une horloge, la salle à manger.) Le pourcentage a été remplacé par « beaucoup de personnes », la date est écrite en entier avec le jour de la semaine, le jargon (« sensibilisation », « équilibre alimentaire ») a disparu. Le document est ensuite relu par des résidents.

D'autres formules de lisibilité, et pourquoi on ne les mélange pas

La formule de Kandel et Moles est une adaptation au français de la formule de Rudolf **Flesch** (1948), conçue pour l'anglais : L = 206,835 − 1,015 × (mots / phrases) − 84,6 × (syllabes / mots). Les mots français ont en moyenne plus de syllabes que les mots anglais ; Kandel et Moles (1958) ont donc réduit le poids des syllabes (73,6 au lieu de 84,6) pour que les scores des deux langues restent comparables. D'autres indices existent, par exemple l'indice **Gunning Fog** (1952), qui estime un nombre d'années d'études nécessaires à partir de la longueur des phrases et de la part des mots de trois syllabes ou plus, et des outils en ligne en français, comme **Scolarius**, développé au Québec.

Calcul détaillé – Le même texte, deux formules

Un texte français compte 120 mots, 12 phrases et 180 syllabes : 10 mots par phrase, 1,5 syllabe par mot.

- Formule française (Kandel et Moles) : 207 − 1,015 × 10 − 73,6 × 1,5 = 207 − 10,15 − 110,4 = **86,45** : facile.

- Formule anglaise (Flesch) appliquée par erreur : 206,835 − 10,15 − 84,6 × 1,5 = 206,835 − 10,15 − 126,9 = **69,79** : standard.

Un second texte compte 180 mots, 10 phrases et 324 syllabes : 18 mots par phrase, 1,8 syllabe par mot.

- Kandel et Moles : 207 − 18,27 − 132,48 = **56,25** : assez difficile. Flesch : 206,835 − 18,27 − 152,28 = **36,29** : difficile.

Leçon : la formule anglaise sous-estime la lisibilité d'un texte français d'environ 15 à 20 points. On utilise toujours la formule adaptée à la langue, et on ne compare que des scores calculés avec la même formule.

Méthode pas à pas – Utiliser un outil de lisibilité en ligne avec prudence

1. Vérifier quelle formule l'outil utilise et pour quelle langue.

2. Retirer du texte les titres, les listes de chiffres et les tableaux, qui faussent le calcul.

3. Comparer la version initiale et la version réécrite avec le même outil.

4. Ne jamais coller dans un outil en ligne un texte qui contient des données personnelles (nom, situation de santé) : règles du RGPD (chapitre 6).

5. Compléter toujours par la relecture des mots difficiles et par un test auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.16

Un collègue annonce que la fiche de l'atelier obtient 62 « d'après un site américain » et qu'il faut tout réécrire. La fiche compte 100 mots, 10 phrases et 160 syllabes. Calculez l'indice de Kandel et Moles et donnez votre avis.

Corrigé

Mots par phrase : 100 / 10 = 10 ; syllabes par mot : 160 / 100 = 1,6. L = 207 − 10,15 − 73,6 × 1,6 = 207 − 10,15 − 117,76 = 79,09 : assez facile, à la limite de « facile ». Le site américain applique sans doute la formule anglaise, qui sous-estime les textes français (206,835 − 10,15 − 84,6 × 1,6 = 61,32, soit environ 62). Il n'est pas nécessaire de tout réécrire : on peut raccourcir quelques mots longs pour dépasser 80, puis tester la fiche auprès de quelques personnes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.5 – Adapter les messages et les supports

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les six étapes d'une communication accessible.

2. Donnez la formule de Kandel et Moles et la zone visée pour un public à littératie limitée.

3. Calculez l'indice d'un texte de 80 mots, 8 phrases et 120 syllabes.

4. Citez trois règles de mise en page qui facilitent la lecture.

5. Qui valide un document FALC ?

6. Pourquoi faut-il tester un pictogramme avant de l'utiliser ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.5

1. Connaître le public, choisir un message, écrire simple, illustrer, tester, vérifier par le faire dire.

2. L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots) ; on vise 80 et plus (facile ou très facile).

3. 80 / 8 = 10 mots par phrase ; 120 / 80 = 1,5 syllabe par mot ; L = 207 − 10,15 − 110,4 = 86,45 : facile.

4. Police sans empattement de 14 points, texte aligné à gauche, gras plutôt qu'italique ou majuscules, contraste fort, images à côté du texte, beaucoup d'espace.

5. Des personnes en situation de handicap intellectuel, qui relisent et valident le document.
6. Parce qu'un pictogramme peut être compris différemment selon la culture, l'âge ou l'habitude ; seul le test montre s'il est compris.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais le calcul de lisibilité et je relis les tableaux de la section.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.5 et je refais les exercices d'application.

5.3.6 Vérifier la compréhension : le « faire dire »

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 24-25 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

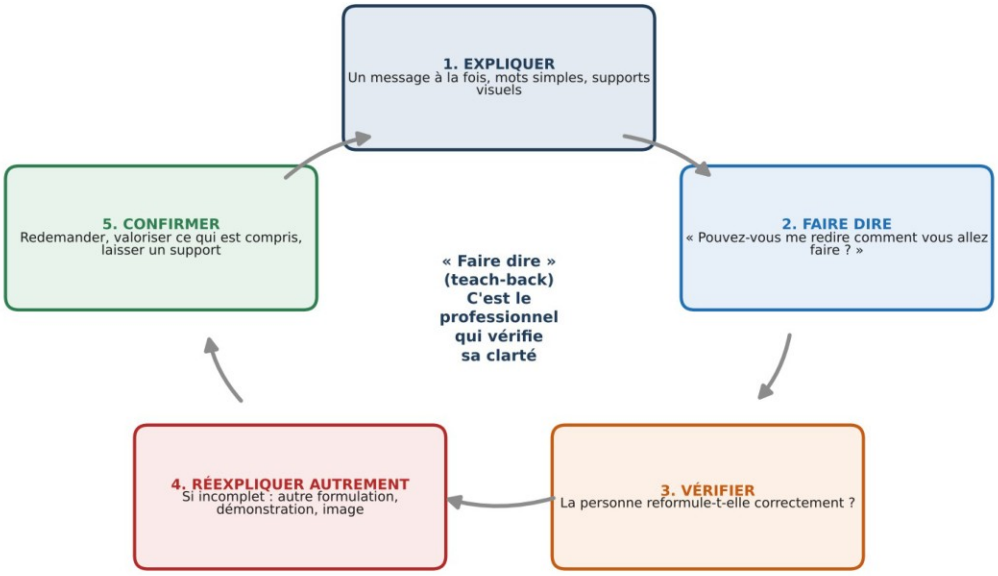


Figure 5.6 – La boucle du « faire dire » (teach-back)

Comprendre le schéma – Figure 5.6

1. Expliquer un message à la fois, avec des mots simples et un support visuel.

2. Faire dire : demander à la personne de reformuler **avec ses mots** ce qu'elle va faire, en présentant la demande comme une vérification de **sa propre clarté** (« Pour être sûr(e) d'avoir bien expliqué… »).

3. Vérifier la reformulation.

4. Si elle est incomplète, **réexpliquer autrement** (autre formulation, démonstration, image), sans répéter mot pour mot.

5. Confirmer par une nouvelle reformulation, valoriser, laisser un support.

6. La HAS a publié en 2015 une fiche-outil « Faire dire » pour les professionnels de santé ; la technique s'utilise aussi en atelier collectif (« Qui peut expliquer à son voisin comment on lit le Nutri-Score ? »).

Attention – Ce qu'il ne faut pas dire

« Vous avez compris ? » appelle presque toujours la réponse « oui », par politesse ou par gêne. On préfère une **question ouverte** qui demande d'agir : « Montrez-moi comment vous choisiriez entre ces deux céréales.

»

À vous de jouer – Exercice d'application 5.17

Réécrivez le message suivant pour des parents ayant une littératie limitée, puis formulez la question de « faire dire » : « Il est recommandé de limiter la consommation de boissons sucrées, y compris les jus de fruits, qui ne doivent pas excéder un verre par jour, et de privilégier l'eau, seule boisson indispensable. »

Corrigé

Réécriture : « L'eau est la meilleure boisson. Les sodas et les jus ont beaucoup de sucre. Les jus de fruits : un petit verre par jour, pas plus. » (avec un pictogramme verre d'eau en vert, soda en rouge). **Faire dire** : « Pour être sûre d'avoir été claire : qu'est-ce que vous allez donner à boire à vos enfants au goûter demain ? »

Découper, vérifier, faire faire : trois façons d'utiliser le « faire dire »

Le principe du « faire dire » et son usage en groupe ont été présentés au chapitre 3. En littératie, on l'utilise sous trois formes complémentaires.

Forme	Ce que l'on fait	Quand l'utiliser
Découper et vérifier (*chunk and check*)	On donne une information à la fois, puis on vérifie avant de passer à la suivante	Explication longue : un plan alimentaire, une recette en plusieurs étapes, une démarche administrative
Faire faire (*show me*)	On demande de **montrer** le geste plutôt que de le dire : verser une portion, lire une étiquette, régler une plaque	Gestes techniques, numératie (quantités, prix), public allophone
Faire dire à distance	Au téléphone ou en visioconférence, on demande à la personne de répéter le rendez-vous, l'adresse, ce qu'elle doit apporter	Rappel d'atelier, suivi après une séance, personnes isolées

Exemple – Découper et vérifier une recette de soupe

L'animatrice explique d'abord les trois premières étapes (laver, éplucher, couper) et demande à un binôme de les montrer. Elle passe ensuite à la cuisson (quantité d'eau, durée) et vérifie avec la question « Combien de verres d'eau allez-vous mettre ? ». Elle termine par le mixage et la conservation. Si elle avait tout expliqué d'un bloc, les participants auraient surtout retenu le début et la fin.

Aider les personnes à poser leurs questions : les trois questions clés

Le « faire dire » vérifie ce que la personne a compris. Il faut aussi l'aider à **demander** ce dont elle a besoin : c'est la littératie interactive. Aux États-Unis, la campagne *Ask Me 3* invite les patients à poser trois questions à chaque rencontre avec un professionnel. On peut l'adapter en atelier ou en consultation diététique :

1. « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui ? »
2. « Qu'est-ce que je dois faire ? »
3. « Pourquoi est-ce important pour moi ? »

Méthode pas à pas – Introduire les trois questions dans un atelier

1. Afficher les trois questions en gros, avec un pictogramme pour chacune.
2. Les présenter au début : « Vous avez le droit de nous poser ces questions à tout moment. »
3. En fin de séance, inviter chaque binôme à répondre aux trois questions pour lui-même.

4. Remettre une petite carte avec les trois questions à garder pour les rendez-vous médicaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.18

Vous appelez Mme R., 79 ans, pour lui rappeler l'atelier de jeudi. Rédigez votre message en découpant l'information, puis la question de « faire dire » que vous lui poserez à la fin de l'appel.

Corrigé

« Bonjour Madame R., c'est Julie, du CCAS. Je vous appelle pour l'atelier cuisine. [Pause] C'est jeudi, à 10 heures. [Pause] C'est à la salle des fêtes, à côté de la mairie. [Pause] Apportez une boîte pour emporter la soupe. » Question finale : « Pour être sûre de ne rien avoir oublié, vous pouvez me redire quel jour vous venez, à quelle heure, et ce que vous apportez ? » Si un élément manque, on le redit autrement (« jeudi, le jour du marché ») puis on vérifie à nouveau.

Ce que disent les études sur le « faire dire »

Le « faire dire » est recommandé par la HAS (2015) et par l'AHRQ. Les études qui l'ont évalué donnent des résultats encourageants, avec des limites qu'il faut connaître pour en parler honnêtement.

Étude	Ce qui a été observé	Limite
Schillinger et coll. (2003), patients diabétiques à littératie limitée	Les médecins vérifiaient rarement la compréhension de leurs patients ; quand ils le faisaient, l'équilibre du diabète des patients était meilleur	Étude d'observation : on ne peut pas affirmer que la vérification est la seule cause
Ha Dinh et coll. (2016), revue systématique chez des personnes avec une maladie chronique	Le « faire dire » améliore la compréhension, l'observance et l'autogestion dans de nombreuses études ; effets moins nets sur les hospitalisations	Études très différentes, souvent courtes et de qualité variable

À retenir – Ce que l'on peut dire au public et aux financeurs

Le « faire dire » est une méthode simple, peu coûteuse et sans effet indésirable connu, qui améliore la compréhension. Ses effets sur la santé à long terme sont moins bien démontrés. On le présente donc comme une bonne pratique de communication, et l'on évalue la compréhension dans ses propres actions.

Calcul détaillé – Mesurer l'effet du « faire dire » dans ses ateliers (données fictives)

Une diététicienne compare deux cycles d'ateliers sur les goûters des enfants. Dans le cycle 1, sans « faire dire », 11 parents sur 25 citent correctement deux goûters adaptés trois semaines plus tard. Dans le cycle 2, avec « faire dire » à chaque séance, 19 parents sur 27 les citent correctement.

- Cycle 1 : 11 / 25 × 100 = **44,0 %** ; cycle 2 : 19 / 27 × 100 = **70,4 %**.
- Différence : 70,4 − 44,0 = **26,4 points**.

Interprétation : le résultat est encourageant, mais les deux groupes ne sont pas les mêmes parents, les effectifs sont petits et d'autres changements ont pu jouer (animatrice plus expérimentée, nouvelle fiche). On parlera d'une amélioration observée, pas d'une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.19

Un financeur demande : « Le "faire dire" réduit-il les hospitalisations ? » Rédigez une réponse honnête en trois phrases.

Corrigé

« Les études montrent surtout que le "faire dire" améliore la compréhension et la capacité des personnes à appliquer les conseils. Ses effets sur les hospitalisations sont moins nets, car les études sont courtes et très différentes. Dans notre projet, nous mesurerons la compréhension des participants et l'application des conseils à la maison, ce qui est l'objectif de nos ateliers. »

5.3.7 Intégrer la littératie à chaque étape du projet

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Étape (chapitres 7 à 9)	Prise en compte de la littératie
Diagnostic	Recueillir la langue, la lecture, le numérique ; questionnaire oral ou imagé ; entretiens et groupes de parole
Objectifs	Inclure des objectifs de compétences (« savoir lire le Nutri-Score », « savoir cuisiner les lentilles »)
Conception des supports	Appliquer les règles d'écriture claire, FALC, pictogrammes ; tester avant diffusion
Animation	Méthodes actives, démonstrations, faire dire, binômes
Communication	Plusieurs canaux (oral, affiches, bouche-à-oreille, relais) ; ne pas tout miser sur le numérique
Évaluation	Outils d'évaluation accessibles (smileys, gommettes, entretien oral) ; indicateurs de compréhension

Écrire des objectifs de littératie

Un projet qui prend en compte la littératie inclut des **objectifs de compétences**, formulés avec un verbe d'action et vérifiables à la fin d'une séance. La grille de Sørensen aide à les choisir : chaque compétence (accéder, comprendre, évaluer, appliquer) donne une famille de verbes.

Compétence	Verbes utiles	Exemple d'objectif opérationnel
Accéder	Trouver, repérer, demander, contacter	À la fin de la séance, chaque participant sait trouver sur une affiche du marché les fruits et légumes de saison les moins chers
Comprendre	Expliquer, reformuler, montrer, associer	À la fin de l'atelier, 8 participants sur 10 savent expliquer avec leurs mots ce que veut dire la lettre A du Nutri-Score
Évaluer	Comparer, choisir, juger, vérifier	À la fin du cycle, les participants savent comparer deux paquets de céréales et dire lequel contient moins de sucre
Appliquer	Préparer, cuisiner, composer, organiser	Trois semaines après l'atelier, la moitié des participants déclarent avoir cuisiné les lentilles au moins une fois

Attention – Un objectif de littératie n'est pas un objectif de connaissance

« Connaître les repères du PNNS » est difficile à vérifier et ne dit rien de ce que la personne saura faire. On préfère « savoir choisir », « savoir préparer », « savoir demander ». Le verbe « comprendre » seul est trop vague : on le remplace par ce que la personne fera pour montrer qu'elle a compris (« expliquer », « montrer »).

Exemple – De l'objectif général aux objectifs opérationnels

Objectif général : améliorer la littératie alimentaire des familles hébergées au centre. Objectif spécifique : d'ici six mois, les familles savent préparer au moins deux plats complets avec les produits du colis alimentaire. Objectifs opérationnels : organiser six ateliers de cuisine de 2 heures entre janvier et mars ; à chaque atelier, au moins 7 participants sur 10 réussissent le « faire dire » sur la recette du jour.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.20

Transformez ces trois intentions en objectifs de compétences vérifiables : a) « sensibiliser au sucre caché » ; b) « faire connaître l'épicerie solidaire » ; c) « informer sur les dates de consommation ».

Corrigé

a) À la fin de l'atelier, chaque participant sait poser à côté d'une boisson le nombre de morceaux de sucre qu'elle contient. b) À la fin de la réunion, les participants savent dire où se trouve l'épicerie solidaire, quand elle est ouverte et comment y accéder. c) À la fin de l'atelier, les participants savent trier cinq produits entre « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant » et dire ce qu'ils feront de chacun après la date.

Concevoir avec les personnes concernées

Un support conçu **avec** le public est mieux compris et mieux accepté qu'un support conçu **pour** lui. La participation peut prendre plusieurs formes, de la simple relecture à la co-création, et elle s'organise dès le début du projet (chapitre 7).

Forme de participation	Exemple	Ce qu'elle apporte
Relecture et test	Trois mamans relisent la fiche recette et soulignent les mots difficiles	Repère les mots et les images mal compris
Groupe de travail	Des habitants choisissent les recettes et les photos du livret	Supports proches des pratiques réelles
Co-animation	Une habitante relais montre sa recette en atelier	Confiance, valorisation, modèle proche
Comité d'usagers	Des usagers donnent leur avis sur l'affichage des menus d'une cuisine centrale	Amélioration durable de l'organisation

Calcul détaillé – Combien de personnes pour tester un support ?

Le spécialiste de l'ergonomie Jakob Nielsen (2000) a proposé un modèle simple pour les tests d'utilisabilité : si chaque testeur repère en moyenne 31 % des problèmes d'un support, la part des problèmes repérés par n testeurs vaut $1 - (1 - 0{,}31)^n$.

- 1 testeur : 1 − 0,69 = **31,0 %** des problèmes.
- 3 testeurs : 1 − 0,69 × 0,69 × 0,69 = 1 − 0,329 = **67,1 %**.
- 5 testeurs : $1 - 0{,}69^5 = 1 - 0{,}156$ = **84,4 %**.
- 8 testeurs : $1 - 0{,}69^8 = 1 - 0{,}051$ = **94,9 %**.

Interprétation : quelques testeurs bien choisis repèrent déjà la plupart des problèmes ; il vaut mieux faire deux petits tests successifs (cinq personnes, correction, puis cinq autres) qu'un seul grand test. Le chiffre de 31 % est une moyenne observée dans des tests de sites internet : c'est un ordre de grandeur, pas une loi.

Attention – Respecter les personnes qui participent

La participation demande du temps aux habitants. On les informe de l'usage de leur avis, on les remercie publiquement s'ils le souhaitent, on leur montre ce qui a changé grâce à eux et, quand c'est possible, on reconnaît leur travail (bon d'achat, repas partagé, indemnisation prévue dans le budget du projet). On veille aussi à ne pas toujours solliciter les mêmes personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.21

Vous avez fait tester une affiche par 3 personnes. Selon le modèle de Nielsen, quelle part des problèmes avez-vous probablement repérée ? Combien de testeurs supplémentaires proposez-vous, et pourquoi ?

Corrigé

Avec 3 testeurs : $1 - 0{,}69^3 = 1 - 0{,}329 = 67{,}1\ \%$ des problèmes environ. On peut corriger l'affiche, puis la faire tester par 2 à 5 nouvelles personnes : avec 5 testeurs au total, on repère environ 84 % des problèmes, et la seconde série vérifie aussi que les corrections sont comprises. On choisit des testeurs proches du public visé (langue, âge, lecture).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.6 et 5.3.7 – Vérifier et intégrer au projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq temps de la boucle du « faire dire ».
2. Qu'est-ce que la technique « découper et vérifier » ?
3. Dans quels cas préfère-t-on « faire faire » plutôt que « faire dire » ?
4. Citez les trois questions clés que l'on peut apprendre aux participants à poser.
5. Transformez « sensibiliser aux étiquettes » en objectif de compétence vérifiable.
6. Selon le modèle de Nielsen, quelle part des problèmes d'un support cinq testeurs repèrent-ils environ ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.6 et 5.3.7

1. Expliquer, faire dire, vérifier, réexpliquer autrement si besoin, confirmer.
2. Donner une information à la fois et vérifier qu'elle est comprise avant de passer à la suivante.
3. Pour les gestes techniques, les quantités et les prix (numératie), et avec un public allophone.
4. « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? », « Qu'est-ce que je dois faire ? », « Pourquoi est-ce important pour moi ? »
5. Par exemple : « À la fin de l'atelier, chaque participant sait comparer deux paquets de biscuits avec le Nutri-Score et dire lequel il choisirait. »
6. Environ 84 % ($1 - 0{,}69^5$).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des sections 5.3.6 et 5.3.7, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les deux sections et je refais les exercices d'application.

5.3.8 Lire une étiquette : un savoir-faire de littératie alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M3 S1 §2 (p. 29)

L'étiquetage des denrées est encadré par le **règlement (UE) n° 1169/2011** (dit « INCO ») : dénomination, liste des ingrédients, allergènes mis en évidence, quantité nette, dates, conditions de conservation, déclaration

nutritionnelle (énergie, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel, pour 100 g ou 100 mL). Le **Nutri-Score**, logo facultatif en France depuis 2017, complète cette information ; son algorithme a été révisé (aliments en 2022, boissons en 2023) et rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, avec deux ans de transition pour les produits déjà sur le marché.



Figure 5.7 – Lire une étiquette en 6 étapes

Comprendre le schéma – Figure 5.7

1. La dénomination dit ce qu'est réellement le produit ; « préparation à base de… », « saveur… » signalent souvent une faible part de l'ingrédient mis en avant sur l'emballage.

2. La liste d'ingrédients est classée par ordre **décroissant** de poids : le premier ingrédient est le plus abondant ; les **14 allergènes** réglementaires apparaissent en gras ou soulignés ; une longue liste avec additifs signale souvent un produit ultra-transformé (chapitre 4).

3. Le Nutri-Score (de A, vert foncé, à E, orange foncé) permet de **comparer** des produits d'une **même famille** (deux céréales, deux pizzas), pas une pizza et une pomme.

4. Le tableau nutritionnel donne les valeurs **pour 100 g** (pour comparer) et parfois **par portion** (pour savoir ce que l'on mange réellement) ; la portion indiquée par le fabricant est souvent plus petite que celle réellement consommée.

5. Les dates : DLC (« à consommer jusqu'au ») et DDM (« à consommer de préférence avant »), chapitre 4.

6. Le prix au kilo, affiché en rayon, permet de comparer des conditionnements différents.

Exemple – Calcul détaillé : du tableau nutritionnel aux morceaux de sucre

Une boisson aux fruits contient **9,8 g de sucres pour 100 mL** ; la bouteille fait **33 cL** ; on retient qu'un morceau de sucre pèse **environ 5 g**.

- Sucres dans la bouteille : 9,8 × 330 / 100 = 9,8 × 3,3 = **32,3 g**.
- En morceaux de sucre : 32,3 / 5 = **6,5 morceaux**.
- Repère : l'OMS recommande de limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique (idéalement moins de 5 %) ; pour un adulte à 2 000 kcal, 10 % = 200 kcal, soit 200 / 4 = **50 g** de sucres par jour. La bouteille en représente 32,3 / 50 × 100 = **64,6 %**.
- Pour un enfant de 8 ans à environ 1 700 kcal : 10 % = 170 kcal, soit 170 / 4 = **42,5 g** ; la bouteille en

représente 32,3 / 42,5 × 100 = **76 %**.

En atelier, on matérialise : 6 à 7 morceaux de sucre posés à côté de la bouteille ; l'image est mieux comprise que les grammes (littératie numérique et calculatoire).

Exemple – Calcul détaillé : comparer deux produits « pour 100 g » et « par portion »

Pour 100 g	Céréales A (Nutri-Score A)	Céréales B (Nutri-Score D)	Portion habituelle
Énergie	360 kcal	420 kcal	40 g
Sucres	4,5 g	26 g	
Fibres	10 g	3 g	
Prix au kilo	3,20 €	4,90 €	

- Sucres par portion : A : 4,5 × 40 / 100 = **1,8 g** ; B : 26 × 40 / 100 = **10,4 g**, soit plus de 2 morceaux de sucre (10,4 / 5 = 2,1).
- Fibres par portion : A : 10 × 0,4 = **4 g** ; B : 3 × 0,4 = **1,2 g**.
- Coût par portion : A : 0,040 × 3,20 = **0,13 €** ; B : 0,040 × 4,90 = **0,20 €**.

Conclusion : le produit le mieux classé au Nutri-Score est aussi le moins cher par portion ; le message « mieux et moins cher » est particulièrement mobilisateur pour des publics à budget contraint.

Les allégations nutritionnelles : ce que les mots veulent dire

Les mentions comme « riche en fibres » ou « allégé » attirent l'œil sur l'emballage. Elles sont encadrées par le **règlement (CE) n° 1924/2006** sur les allégations nutritionnelles et de santé : chaque mention correspond à un **seuil précis**. Les connaître permet d'expliquer au public ce qu'elles promettent vraiment, et ce qu'elles ne disent pas.

Allégation	Condition (annexe du règlement 1924/2006)
Faible teneur en sucres	5 g de sucres au plus pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour une boisson)
Sans sucres	0,5 g de sucres au plus pour 100 g ou 100 mL
Sans sucres ajoutés	Aucun sucre ni aliment sucrant ajouté ; si le produit contient des sucres naturellement présents, l'étiquette doit l'indiquer
Faible teneur en matières grasses	3 g au plus pour 100 g (1,5 g pour 100 mL)
Pauvre en sel	0,12 g de sodium au plus pour 100 g, soit environ 0,3 g de sel
Source de fibres	3 g de fibres au moins pour 100 g, ou 1,5 g pour 100 kcal
Riche en fibres	6 g au moins pour 100 g, ou 3 g pour 100 kcal
Source de protéines	Les protéines apportent au moins 12 % de l'énergie du produit
Riche en protéines	Au moins 20 % de l'énergie
Allégé, réduit en…	Au moins 30 % de moins qu'un produit similaire (25 % pour le sel)

Attention – Une allégation ne fait pas un aliment favorable

« Allégé en matières grasses » ne veut pas dire « peu calorique » ni « peu sucré » : un produit allégé en gras peut être riche en sucres. « Sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres » : une compote ou un jus contiennent les sucres des fruits. « Source de fibres » peut figurer sur des biscuits très sucrés. En atelier, on apprend à vérifier l'allégation avec le tableau nutritionnel et à comparer avec le Nutri-Score.

Calcul détaillé – Vérifier trois allégations (produits fictifs)

- Des biscuits affichent « source de fibres » : 4,5 g de fibres et 450 kcal pour 100 g. Le seuil de 3 g pour 100 g est atteint ; pour 100 kcal, ils apportent 4,5 / 450 × 100 = **1,0 g** de fibres, sous le seuil de 1,5 g ; il suffit qu'une des deux conditions soit remplie : l'allégation est **autorisée**, mais les biscuits contiennent aussi 28 g de sucres pour 100 g.
- Des céréales affichent « source de protéines » : 8 g de protéines et 380 kcal pour 100 g. Part de l'énergie : 8 × 4 / 380 × 100 = **8,4 %**, sous le seuil de 12 % : l'allégation serait **non conforme**.
- Un yaourt « allégé » contient 1,6 g de lipides pour 100 g, contre 3,2 g pour le yaourt de référence : baisse de (3,2 − 1,6) / 3,2 × 100 = **50 %** : conforme. Mais il contient 9,5 g de sucres pour 100 g contre 12,5 g pour un yaourt aromatisé classique : la baisse des sucres, (12,5 − 9,5) / 12,5 × 100 = **24 %**, ne suffirait pas pour écrire « réduit en sucres ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.22

Une boisson affiche « faible teneur en sucres » et contient 4 g de sucres pour 100 mL. Un pain de mie affiche « riche en fibres » et contient 5 g de fibres et 250 kcal pour 100 g. Dites si chaque allégation est conforme.

Corrigé

Boisson : le seuil pour un liquide est de 2,5 g pour 100 mL ; avec 4 g, l'allégation n'est pas conforme. Pain de mie : 5 g pour 100 g est sous le seuil de 6 g, mais pour 100 kcal il apporte 5 / 250 × 100 = 2,0 g, sous le seuil de 3 g : l'allégation « riche en fibres » n'est pas conforme ; « source de fibres » le serait (5 g pour 100 g, au-dessus de 3 g).

Les apports de référence de l'étiquette : un repère à expliquer

Beaucoup d'emballages indiquent, à côté du tableau nutritionnel, un pourcentage des **apports de référence** (AR) par portion. Ces valeurs sont fixées par le règlement INCO (annexe XIII) pour un adulte moyen : ce ne sont pas des besoins personnels, mais des repères communs pour comparer.

Élément	Apport de référence (adulte, règlement INCO)
Énergie	8 400 kJ, soit 2 000 kcal
Matières grasses	70 g
Acides gras saturés	20 g
Glucides	260 g
Sucres	90 g
Protéines	50 g
Sel	6 g

Attention – Deux repères de sucres différents

L'AR des **sucres** de l'étiquette (90 g) porte sur **tous** les sucres, y compris ceux du lait et des fruits. Le repère de l'OMS (moins de 10 % de l'énergie, soit environ 50 g pour 2 000 kcal) ne porte que sur les **sucres libres** (ajoutés, miel, sirops, jus). Un pourcentage d'AR faible pour les sucres peut donc rassurer à tort. En atelier, on préfère traduire les sucres en morceaux.

Calcul détaillé – Une demi-pizza en pourcentage des apports de référence (produit fictif)

Pour 100 g : 245 kcal ; lipides 9,5 g ; acides gras saturés 4,2 g ; glucides 29 g ; sucres 3,6 g ; protéines 10,5 g ;

sel 1,3 g. La portion indiquée est une demi-pizza de 200 g.

- Énergie : 245 × 2 = 490 kcal, soit 490 / 2 000 × 100 = **24,5 %** de l'AR.
- Acides gras saturés : 8,4 g, soit 8,4 / 20 × 100 = **42,0 %**.
- Sel : 2,6 g, soit 2,6 / 6 × 100 = **43,3 %**.
- Sucres : 7,2 g, soit **8,0 %** de l'AR.

Interprétation : la demi-pizza apporte un quart de l'énergie de référence de la journée, mais près de la moitié du sel et des graisses saturées. On conseille de l'accompagner d'une grande salade et d'un fruit, et de limiter les autres aliments salés ce jour-là.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.23

Un paquet de chips indique pour une portion de 30 g : 160 kcal et 0,45 g de sel. Calculez le pourcentage des AR pour l'énergie et pour le sel. Que se passe-t-il si une personne mange le sachet entier de 150 g ?

Corrigé

Portion : énergie 160 / 2 000 × 100 = 8,0 % ; sel 0,45 / 6 × 100 = 7,5 %. Le sachet de 150 g contient 150 / 30 = 5 portions : 5 × 160 = 800 kcal, soit 40,0 % de l'AR, et 5 × 0,45 = 2,25 g de sel, soit 37,5 % de l'AR. La portion indiquée est petite : les pourcentages par portion peuvent sous-estimer ce qui est réellement mangé.

Comment le Nutri-Score est-il calculé ?

Le Nutri-Score a été proposé par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de Serge Hercberg et adopté en France par un arrêté du 31 octobre 2017, comme logo facultatif. Il est aussi utilisé en Belgique, en Espagne, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. Son calcul se fait en trois temps, pour 100 g ou 100 mL de produit.

Méthode pas à pas – Le principe du calcul (sans les tableaux de points)

1. Points défavorables : on attribue des points selon la teneur en énergie, en sucres, en acides gras saturés et en sel ; plus il y en a, plus il y a de points.

2. Points favorables : on attribue des points selon la teneur en fibres, en protéines et la part de fruits, légumes et légumineuses.

3. Score final : points défavorables moins points favorables ; le score est ensuite converti en une lettre de A à E, avec des seuils différents pour les aliments solides, les boissons et les matières grasses.

Ce qui a changé avec l'algorithme révisé (aliments 2022, boissons 2023)	Conséquence pour le consommateur
Les sucres et le sel sont pénalisés plus fortement	Des céréales sucrées et des produits salés perdent une lettre
Les céréales complètes sont mieux distinguées des céréales raffinées	Le pain et les pâtes complets sont mieux classés
Les huiles d'olive, de colza et de noix sont mieux classées	Elles peuvent obtenir la lettre B
La viande rouge est moins bien classée que la volaille et le poisson	Les plats à base de viande rouge baissent
Les boissons : l'eau est la référence, les boissons avec édulcorants sont pénalisées, les boissons lactées sucrées sont classées avec les boissons	Les boissons sucrées ou édulcorées sont moins bien classées qu'avant ; seule l'eau obtient la lettre A

Exemple – Expliquer un « changement de lettre » au public

Une participante s'étonne : « Mes céréales étaient B, maintenant elles sont D. Elles ont changé ? » Réponse simple : « La recette n'a peut-être pas changé. C'est la règle de calcul qui a changé : elle compte plus le sucre. Vos céréales contiennent beaucoup de sucre, c'est pour ça qu'elles ont perdu des lettres. Comparez-les avec un autre paquet de céréales du même rayon. »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.24

Expliquez en deux phrases simples, pour un atelier, pourquoi on ne peut pas comparer le Nutri-Score d'un soda et celui d'un fromage.

Corrigé

« Le Nutri-Score compare des produits qui se ressemblent : deux fromages entre eux, ou deux boissons entre elles. Un fromage et un soda ne servent pas à la même chose et ne sont pas calculés de la même façon. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.8 – Lire une étiquette

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel ordre sont classés les ingrédients d'une liste ? Comment repère-t-on les allergènes ?
2. Quelle différence y a-t-il entre DLC et DDM ?
3. Quel est le seuil de l'allégation « faible teneur en sucres » pour un aliment solide ?
4. Un produit de 400 kcal pour 100 g contient 10 g de protéines. Peut-il afficher « source de protéines » ?
5. Pourquoi l'apport de référence des sucres de l'étiquette (90 g) ne se compare-t-il pas au repère de l'OMS ?
6. Citez les deux familles de composants qui entrent dans le calcul du Nutri-Score.

Corrigé – Point d'étape 5.3.8

1. Par ordre décroissant de poids ; les 14 allergènes réglementaires sont mis en évidence (gras, souligné).
2. DLC (« à consommer jusqu'au ») : ne pas dépasser ; DDM (« de préférence avant ») : le produit reste consommable après la date s'il est bien conservé.
3. 5 g de sucres au plus pour 100 g.
4. 10 × 4 / 400 × 100 = 10 % de l'énergie, sous le seuil de 12 % : non.
5. L'AR porte sur tous les sucres ; le repère de l'OMS porte sur les sucres libres (environ 50 g pour 2 000 kcal).
6. Les composants défavorables (énergie, sucres, acides gras saturés, sel) et favorables (fibres, protéines, fruits, légumes et légumineuses).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs d'allégations et je relis le tableau des apports de référence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.8 et je refais les exercices d'application.

5.3.9 Comprendre et présenter des chiffres : la numératie en santé

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

La **numératie** (*numeracy*) est la capacité à comprendre et utiliser des nombres, des pourcentages, des proportions et des probabilités dans la vie courante. Une part importante de la population a des difficultés avec

les pourcentages et les risques ; or les messages de santé sont pleins de chiffres (« 5 par jour », « 30 minutes », « – 30 % de risque », « 25 g de fibres »).

Présenter un risque de façon compréhensible

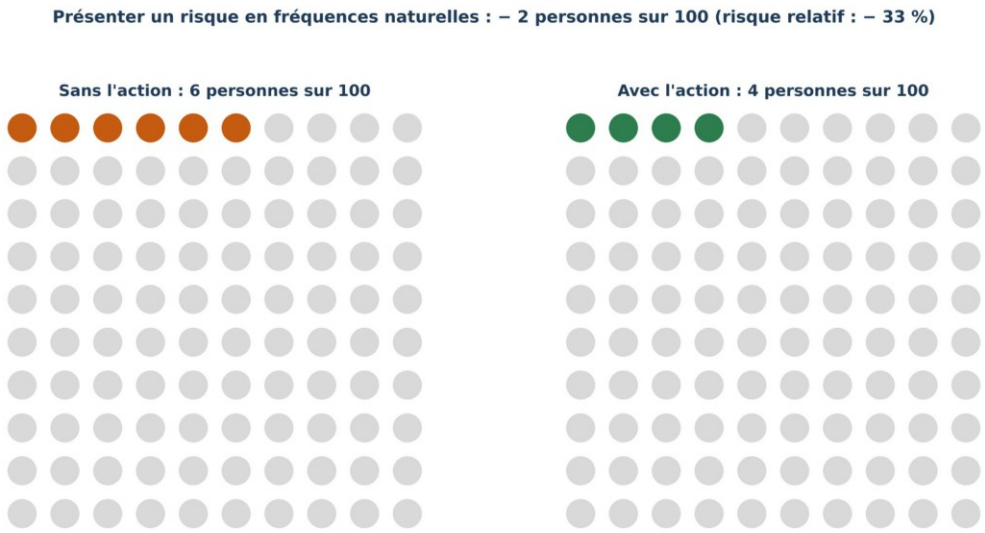


Figure 5.8 – Un risque présenté en fréquences naturelles

Comprendre le schéma – Figure 5.8

1. Les **fréquences naturelles** (« 6 personnes sur 100 ») sont mieux comprises que les pourcentages ou les probabilités (« 0,06 ») (Gigerenzer).
2. Les **tableaux d'icônes** (100 pictogrammes dont certains colorés) rendent visible l'ampleur réelle d'un risque.
3. Passer de 6 à 4 personnes sur 100 correspond à une **réduction absolue** de **2 personnes sur 100** (2 points) mais à une **réduction relative** de (6 − 4) / 6 × 100 = **33 %**.
4. Présenter seulement la réduction relative (« − 33 % ! ») **exagère** l'effet perçu ; la présentation honnête donne les deux, en fréquences naturelles (chapitre 2 : risque relatif et différence de risques).

À éviter	À préférer	Pourquoi
« Réduit le risque de 50 % »	« Le risque passe de 2 sur 100 à 1 sur 100 »	Le relatif seul exagère
« 0,3 % de la population »	« 3 personnes sur 1 000 »	Les petites proportions sont difficiles à se représenter
« 25 g de fibres par jour »	« Du pain complet, des légumes à chaque repas, des légumes secs 2 fois par semaine »	Les grammes de nutriments ne se voient pas dans l'assiette
« 400 g de fruits et légumes »	« 5 portions : une portion = un poing ou deux cuillères à soupe pleines »	Mesure concrète
« 10 % de l'apport énergétique »	« Pas plus d'un verre de jus par jour »	Traduire en aliments

À vous de jouer – Exercice d'application 5.25

Une publicité affirme : « Notre yaourt réduit de 40 % le risque de troubles digestifs ! » L'étude citée montre 5 personnes sur 100 avec troubles dans le groupe témoin et 3 sur 100 dans le groupe yaourt. Calculez les réductions absolue et relative et rédigez une phrase honnête.

Corrigé

Réduction absolue : 5 − 3 = **2 personnes sur 100** (2 points). Réduction relative : 2 / 5 × 100 = **40 %**. Phrase honnête : « Sur 100 personnes, 3 ont eu des troubles digestifs avec ce yaourt au lieu de 5 sans : 2 personnes sur 100 en ont été protégées. » Il faudrait aussi vérifier la qualité de l'étude, sa durée et qui l'a financée (chapitre 6).

Les pièges de calcul les plus fréquents, et comment les éviter

Les messages de nutrition contiennent beaucoup de chiffres. Certaines erreurs reviennent souvent, chez le public mais aussi chez les professionnels. Les connaître permet de les prévenir dans les supports et de les travailler en atelier.

Piège	Exemple	Ce qu'il faut savoir ou dire
Kilojoules et kilocalories	L'étiquette affiche « 1 674 kJ / 400 kcal » ; une personne retient 1 674	1 kcal = 4,184 kJ ; en atelier, on n'utilise que les kcal, ou mieux, des repères en aliments
Centilitres et millilitres	Une canette de 33 cL est lue « 33 mL »	33 cL = 330 mL ; on montre la canette réelle
Pour 100 g et par portion	On compare les sucres pour 100 g d'un produit et par portion d'un autre	On compare toujours sur la même base, de préférence pour 100 g
Pourcentage et points	« Le risque passe de 10 % à 8 % : il baisse de 2 % »	Il baisse de 2 **points** ; la baisse relative est de 20 %
« Deux fois moins »	« Deux fois moins sucré » compris comme « sans sucre »	Deux fois moins = divisé par 2 ; il reste la moitié du sucre
« Jusqu'à 30 % de moins »	La publicité annonce le chiffre maximal	« Jusqu'à » veut dire que certains produits baissent moins, voire pas du tout
Moyenne	« En moyenne, les élèves de la classe mangent 3 fruits par semaine » compris comme « chaque élève »	Une moyenne cache des personnes très au-dessus et très en dessous

Calcul détaillé – Trois conversions utiles en atelier

- Énergie : un plat affiche 2 100 kJ pour une portion ; 2 100 / 4,184 = **502 kcal**, environ un quart des 2 000 kcal de référence.
- Volume : une bouteille de boisson de 1,5 L contient 1 500 mL ; avec 8 g de sucres pour 100 mL, elle contient 8 × 15 = **120 g** de sucres, soit **24 morceaux** de 5 g.
- Points et pourcentage : la part d'enfants qui prennent un petit-déjeuner passe de 70 % à 84 % ; c'est une hausse de **14 points**, soit une hausse relative de 14 / 70 × 100 = **20 %**.

Méthode pas à pas – Présenter un chiffre dans un support grand public

1. Se demander si le chiffre est indispensable ; sinon, le remplacer par un repère concret.

2. Préférer les nombres entiers et arrondis (« environ 6 morceaux de sucre »).

3. Donner une seule unité, connue du public.

4. Comparer à quelque chose de familier (« autant de sucre que dans 3 yaourts aromatisés »).

5. Tester la compréhension du chiffre avec quelques personnes, comme pour le reste du support.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.26

Un article annonce : « La part des adolescents qui boivent des sodas chaque jour est passée de 25 % à 20 %, soit une baisse de 5 %. » Corrigez la phrase et calculez la baisse relative.

Corrigé

La baisse est de 5 points (25 − 20), et non de 5 %. La baisse relative vaut 5 / 25 × 100 = 20 %. Phrase corrigée : « La part des adolescents qui boivent des sodas chaque jour est passée de 25 % à 20 % : c'est 5 points de moins, soit une baisse d'un cinquième. » Pour le grand public : « Avant, 1 adolescent sur 4 buvait des sodas chaque jour ; maintenant, c'est 1 sur 5. »

Mesures ménagères : passer des grammes aux gestes

Un conseil en grammes est difficile à appliquer sans balance. En atelier comme sur les fiches recettes, on traduit les quantités en **mesures ménagères** : cuillère, verre, bol, poignée, main. Les correspondances varient selon l'ustensile, le remplissage et l'aliment ; il faut donc les construire avec les ustensiles réellement utilisés par le public.

Mesure ménagère	Volume approximatif	Repères de poids (approximatifs, à vérifier)
Cuillère à café rase	5 mL	Sucre : environ 5 g ; sel : environ 5 g
Cuillère à soupe rase	15 mL	Huile : environ 10 à 14 g selon le remplissage ; sucre : environ 12 à 15 g
Verre (type verre à eau)	150 à 200 mL	Riz ou lentilles crus : environ 150 à 180 g pour un verre plein
Bol	300 à 350 mL	Soupe : un bol plein
Poing fermé	—	Repère d'une portion de fruits ou de légumes (environ 80 à 100 g)
Paume de la main sans les doigts	—	Repère d'une portion de viande ou de poisson

Méthode pas à pas – Construire sa propre table de correspondance

1. Choisir l'ustensile du public (le verre de la cuisine du centre social, le bol des familles).

2. Remplir l'ustensile trois fois avec l'aliment et peser à chaque fois.

3. Calculer la moyenne et l'arrondir.

4. Écrire la correspondance sur la fiche recette, avec la photo de l'ustensile.

Calcul détaillé – Un verre de riz au centre social (données fictives)

Trois pesées d'un verre de riz cru rempli à ras bord : 162 g, 170 g et 166 g.

- Moyenne : (162 + 170 + 166) / 3 = 498 / 3 = **166 g**.
- Pour une recette qui demande 60 g de riz cru par personne, il faut 60 / 166 = **0,36 verre**, soit **un tiers de verre** environ par personne, ou **un verre pour 3 personnes**.

Sur la fiche : « Riz : 1 verre pour 3 personnes » avec la photo du verre. La consigne est plus facile à suivre que « 180 g de riz pour 3 personnes ».

À vous de jouer – Exercice d'application 5.27

Une recette pour 4 personnes demande 240 g de lentilles corail crues. Au centre social, un verre de lentilles corail pèse en moyenne 180 g. Combien de verres faut-il ? Proposez la formulation pour la fiche.

Corrigé

240 / 180 = 1,33 verre, soit environ un verre et un tiers. Formulation : « Lentilles corail : 1 verre plein et un tiers de verre » avec la photo du verre, ou plus simple : « 1 verre et demi pas tout à fait plein ». On vérifie la formulation en faisant mesurer un participant pendant l'atelier.

Construire un graphique ou un tableau d'icônes que tout le monde comprend

Un graphique peut aider à comprendre, ou au contraire tromper. Quelques règles simples rendent les graphiques plus honnêtes et plus lisibles, que ce soit dans un dossier de projet, un diaporama ou une affiche.

Règle	Pourquoi
Un axe des barres qui commence à zéro	Un axe tronqué grossit les différences
Un seul message par graphique, écrit dans le titre	Le lecteur sait ce qu'il doit voir
Pas d'effet 3D, pas de camembert à plus de 4 parts	Les angles et les volumes sont mal estimés
Les mêmes dénominateurs (« sur 100 », « sur 1 000 ») pour comparer	Comparer 2 sur 100 et 1 sur 50 demande un calcul
Les étiquettes directement sur les barres	Le lecteur ne fait pas d'aller-retour avec une légende
Des couleurs distinctes aussi en noir et blanc	Les personnes daltoniennes et les photocopies

Calcul détaillé – L'effet d'un axe tronqué

Deux quartiers : 42 % et 46 % des enfants prennent un petit-déjeuner chaque jour. La différence réelle est de 4 points, soit (46 − 42) / 42 × 100 = **9,5 %** de plus.

- Axe qui commence à 0 : les barres mesurent 42 et 46 unités ; la seconde est à peine plus haute.
- Axe qui commence à 40 : les barres mesurent 42 − 40 = 2 et 46 − 40 = 6 unités ; la seconde paraît **3 fois** plus haute.

Leçon : on vérifie toujours le début de l'axe avant d'interpréter un graphique, et l'on commence à zéro dans ses propres supports.

Méthode pas à pas – Construire un tableau d'icônes

1. Choisir le dénominateur : 100 icônes pour des risques de quelques pour cent, 1 000 pour des risques plus rares.

2. Ranger les icônes en lignes de 10, et colorer les personnes concernées en bloc, en commençant en haut à gauche.

3. Faire deux tableaux côte à côte (sans action, avec action) avec la même disposition.

4. Écrire sous chaque tableau la phrase en fréquences naturelles (« 6 personnes sur 100 »).

5. Tester la compréhension : « Dans quel groupe y a-t-il le moins de malades ? De combien ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 5.28

Un diaporama compare la part d'enfants en surpoids dans deux écoles : 18 % et 21 %. L'axe vertical va de 15 à 22 %. Expliquez ce que le lecteur risque de croire et proposez une correction.

Corrigé

Avec un axe qui commence à 15, les barres mesurent 3 et 6 unités : le lecteur croit que le surpoids est deux

fois plus fréquent dans la seconde école, alors que la différence réelle est de 3 points (environ 17 % de plus). Correction : faire commencer l'axe à 0, écrire les valeurs sur les barres, et présenter la différence en fréquences naturelles (« 18 enfants sur 100 contre 21 sur 100 »).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.9 – La numératie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce que la numératie ?
2. Un risque passe de 12 sur 100 à 9 sur 100. Donnez la réduction absolue et la réduction relative.
3. Convertissez 1 255 kJ en kcal.
4. Une part passe de 30 % à 36 %. Est-ce une hausse de 6 % ? Justifiez.
5. Comment construire sa propre correspondance entre un verre et un poids d'aliment ?
6. Pourquoi l'axe d'un graphique en barres doit-il commencer à zéro ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.9

1. La capacité à comprendre et utiliser des nombres, des pourcentages, des proportions et des probabilités dans la vie courante.
2. Absolue : 3 personnes sur 100 ; relative : 3 / 12 × 100 = 25 %.
3. 1 255 / 4,184 = 300 kcal environ.
4. Non : c'est une hausse de 6 points ; la hausse relative est de 6 / 30 × 100 = 20 %.
5. Remplir trois fois l'ustensile du public, peser, faire la moyenne, l'écrire sur la fiche avec la photo de l'ustensile.
6. Parce qu'un axe tronqué grossit visuellement les différences.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs de la section et je relis le tableau des pièges.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section 5.3.9 et je refais les exercices d'application.

5.3.10 La littératie numérique et l'inclusion numérique en pratique

Module · Guide 2025 : p. 61 ; p. 24-25 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Applications et sites : aider à choisir et à utiliser

Les applications de scan des produits, les sites officiels (*mangerbouger.fr*, *Mon espace santé*), les réseaux sociaux et les outils d'intelligence artificielle font désormais partie de l'environnement alimentaire. Le diététicien peut aider le public à les **utiliser** et à les **évaluer**.

Critère d'évaluation d'une application ou d'un site	Questions
Éditeur et financement	Qui édite l'outil ? Est-il financé par la publicité, par des marques, par un organisme public ?
Fondement scientifique	Sur quoi reposent les notes ou les conseils (Nutri-Score officiel, algorithme propre, avis d'experts) ?
Mise à jour	Les données sont-elles récentes ? Les repères suivis sont-ils ceux en vigueur ?
Protection des données	Quelles données sont collectées ? Consentement, revente, localisation (RGPD, chapitre 6) ?

Critère d'évaluation d'une application ou d'un site	Questions
Accessibilité	Lisible, simple, utilisable par des personnes âgées ou malvoyantes, disponible en plusieurs langues ?
Effets indésirables	Culpabilisation, obsession du comptage (calories, notes), restriction ?

Rendre un support numérique accessible

Les sites des organismes publics doivent respecter le **référentiel général d'amélioration de l'accessibilité** (RGAA), fondé sur les normes internationales **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*). Pour un support numérique de projet (page de présentation, vidéo, publication), quelques règles suffisent à améliorer nettement l'accessibilité : contraste suffisant, taille de texte modifiable, **texte alternatif** décrivant les images, vidéos **sous-titrées**, liens explicites (« Télécharger le livret de recettes » plutôt que « cliquez ici »), navigation simple.

Exemple – Calcul détaillé : un mini-audit d'accessibilité d'une page de projet

Une page de présentation d'ateliers est vérifiée avec 12 critères simples (contraste, titres structurés, texte alternatif des 4 images, sous-titres de la vidéo, liens explicites, langue déclarée, taille de police, formulaire accessible, absence d'information uniquement par la couleur, version imprimable, contact téléphonique, FALC).

- Critères respectés : 7 sur 12, soit 7 / 12 × 100 = **58,3 %**.
- Corrections prioritaires (rapides) : textes alternatifs des images, sous-titres de la vidéo, contact téléphonique visible : 3 critères de plus, soit 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.

Leçon : une grande partie de l'accessibilité repose sur des gestes simples, à intégrer dès la conception.

Couleurs et contrastes : un calcul simple pour un support lisible

Le contraste entre le texte et le fond est l'un des critères d'accessibilité les plus importants, pour les personnes malvoyantes mais aussi pour tous ceux qui lisent sur un téléphone en plein soleil ou sur une photocopie. Les règles internationales WCAG, reprises par le RGAA, le mesurent par un **ratio de contraste**.

Méthode pas à pas – Calculer un ratio de contraste

1. Trouver la **luminance relative** de chaque couleur (de 0 pour le noir à 1 pour le blanc) avec un outil de vérification du contraste ou un tableau fourni.

2. Ratio = (luminance la plus claire + 0,05) / (luminance la plus foncée + 0,05). Il va de 1 (aucun contraste) à 21 (noir sur blanc).

3. Comparer aux seuils : **4,5** au moins pour un texte courant et **3** pour un grand texte (niveau AA) ; **7** et **4,5** pour le niveau renforcé (AAA).

Calcul détaillé – Quatre couleurs pour une affiche d'atelier

Luminances relatives (calculées selon les WCAG) : blanc 1,0000 ; vert foncé (#2E7D32) 0,1548 ; jaune vif (#FFD600) 0,6935 ; rouge (#D32F2F) 0,1609 ; noir 0,0000.

- Texte vert foncé sur blanc : 1,05 / (0,1548 + 0,05) = 1,05 / 0,2048 = **5,13** : conforme pour un texte courant.
- Texte jaune sur blanc : 1,05 / (0,6935 + 0,05) = 1,05 / 0,7435 = **1,41** : illisible.
- Texte blanc sur fond rouge : 1,05 / (0,1609 + 0,05) = 1,05 / 0,2109 = **4,98** : conforme, de justesse.
- Texte noir sur fond jaune : (0,6935 + 0,05) / (0 + 0,05) = **14,87** : très bon contraste, utile pour un bandeau d'alerte.

Attention – Ne jamais donner une information par la couleur seule

Environ 8 % des hommes et 0,5 % des femmes d'origine européenne ont une forme de daltonisme, le plus souvent une difficulté à distinguer le rouge et le vert. Un code « vert = conseillé, rouge = à limiter » n'est pas compris par ces personnes. On double toujours la couleur par un mot, une forme ou un pictogramme (pouce levé, sablier), comme le fait le Nutri-Score avec ses lettres.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.29

Un menu de cantine indique les plats végétariens en vert clair sur fond blanc, avec un ratio de contraste de 1,9. Dites ce qui ne va pas et proposez deux corrections.

Corrigé

Le ratio de 1,9 est très inférieur au seuil de 4,5 : le texte est difficile à lire, en particulier pour les personnes malvoyantes. De plus, l'information est donnée seulement par la couleur, ce qui exclut les personnes daltoniennes. Corrections : écrire le texte en noir ou en vert très foncé (par exemple #1B5E20, ratio de 7,87 sur blanc) ; ajouter un pictogramme « feuille » et le mot « végétarien » à côté des plats concernés.

Aider un groupe face aux fausses informations sur l'alimentation

Les réseaux sociaux diffusent chaque jour des conseils alimentaires faux ou exagérés : « détox », régimes miracles, peur des conserves ou du pain. Pendant la pandémie de Covid-19, l'OMS a parlé d'**infodémie** (2020) pour désigner cette surabondance d'informations, vraies et fausses, qui rend difficile de trouver des sources fiables. La littératie critique aide à y faire face. Le professionnel a deux rôles : répondre aux idées fausses sans les renforcer, et entraîner le public à juger lui-même une information (grille des 6 questions, 5.4.1).

Méthode pas à pas – Répondre à une idée fausse : le « sandwich de vérité »

1. Commencer par le fait juste, en une phrase simple : « Les légumes en conserve gardent l'essentiel de leurs fibres et de leurs minéraux. »

2. Nommer l'idée fausse une seule fois, en disant qu'elle est fausse : « On lit parfois que les conserves sont "du poison" : c'est faux. »

3. Expliquer pourquoi elle circule : « Cette idée vient souvent de la peur des produits industriels, ou de vidéos qui vendent autre chose. »

4. Redire le fait juste et donner une action : « Les conserves de légumes et de légumes secs sont pratiques et pas chères. Rincez-les pour enlever une partie du sel. »

À retenir – Ce qui aide, ce qui ne marche pas

Ce qui aide : partir des questions du groupe, rester respectueux, montrer comment on vérifie une source, donner une alternative concrète. Ce qui ne marche pas : se moquer, accumuler les chiffres, répéter l'idée fausse dans le titre d'une affiche (« Les conserves, un poison ? ») : on risque de la rendre plus familière et donc plus crédible.

Exemple – Un atelier « vrai ou faux » avec des collégiens

L'animatrice projette trois publications réelles et anonymisées : une recette « détox » au citron, une vidéo qui dit que le pain fait grossir, et une publication de mangerbouger.fr. Par groupes, les élèves répondent aux questions : qui parle ? que veut-il ? sur quoi s'appuie-t-il ? que disent les sources officielles ? Chaque groupe présente sa conclusion. L'animatrice termine par un « sandwich de vérité » sur le pain.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.30

Une participante dit : « J'ai vu sur internet que les jus détox nettoient le foie. » Rédigez votre réponse en suivant les quatre étapes du sandwich de vérité.

Corrigé

1. « Le foie et les reins éliminent eux-mêmes les déchets du corps, chaque jour. » 2. « On lit souvent que des jus "détox" nettoient le foie : ce n'est pas démontré. » 3. « Ces messages circulent beaucoup parce qu'ils promettent un résultat rapide, et souvent pour vendre des produits. » 4. « Pour aider votre corps, buvez de l'eau et mangez des fruits et des légumes entiers : ils apportent aussi des fibres. »

Accompagner vers le numérique sans exclure

La dématérialisation touche aussi l'alimentation et la santé : inscription aux ateliers, prise de rendez-vous, Mon espace santé (ouvert à tous les assurés en 2022), aides sociales en ligne. Pour les personnes éloignées du numérique, plusieurs dispositifs publics existent. Le diététicien peut s'appuyer sur eux comme **partenaires** d'un projet.

Dispositif	Ce qu'il propose	Intérêt pour un projet en nutrition
Espaces France Services	Accueil de proximité pour les démarches administratives, avec un accompagnement au numérique	Aide à l'inscription en ligne, aux démarches CAF et cantine
Conseillers numériques (dispositif lancé en 2021)	Ateliers d'initiation et accompagnement individuel au numérique, dans les mairies, médiathèques, associations	Ateliers « mon téléphone pour cuisiner » : vidéos de recettes, applications utiles
Aidants Connect	Permet à un professionnel habilité (travailleur social, agent France Services) de faire une démarche en ligne pour le compte d'une personne, de façon sécurisée et avec son accord	Évite que la personne donne ses identifiants à un tiers
Médiathèques, associations d'éducation populaire	Accès libre à des ordinateurs, ateliers	Lieux relais pour diffuser un programme

Méthode pas à pas – Proposer un support numérique dans un projet, sans exclure

1. Toujours prévoir un canal non numérique équivalent (papier, téléphone, accueil).

2. Choisir des formats peu exigeants : message vocal, vidéo courte sous-titrée, photo.

3. Montrer en atelier comment accéder au support (scanner un code, ouvrir une vidéo).

4. Ne jamais demander de créer un compte ou de donner une adresse mail pour participer.

5. Évaluer l'usage réel du support numérique (nombre de vues, avis des participants).

Attention – Les identifiants des personnes

Il arrive qu'un professionnel ou un bénévole remplisse une démarche en ligne avec les identifiants d'une personne. C'est risqué pour la personne et pour le professionnel (accès à des données personnelles, responsabilité). On oriente vers un dispositif prévu pour cela, comme Aidants Connect, ou l'on accompagne la personne pour qu'elle fasse elle-même la démarche.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.31

Un CCAS veut remplacer les inscriptions papier aux ateliers par un formulaire en ligne. Proposez trois conditions pour que ce changement n'exclue personne.

Corrigé

Garder une inscription par téléphone et à l'accueil ; proposer un accompagnement pour remplir le formulaire (agent d'accueil, conseiller numérique, France Services) ; rendre le formulaire court et accessible (peu de champs, pas de compte à créer, texte lisible, contact visible). On suit ensuite la part des inscriptions faites par chaque canal pour vérifier que les publics habituels continuent de s'inscrire.

5.3.11 Communiquer avec des personnes allophones

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Une personne **allophone** est une personne dont la langue maternelle n'est pas la langue du pays où elle vit. Dans de nombreux quartiers, une part importante des familles maîtrise peu le français, au moins à l'écrit.

Ressource	Usage
Interprétariat professionnel (sur place ou par téléphone)	Échanges importants ou sensibles (santé, allergies) ; neutralité et confidentialité garanties ; référentiel de la HAS (2017)
Médiateurs en santé, habitants relais	Lien de confiance, compréhension des codes culturels ; ne remplacent pas un interprète pour une consultation
Supports multilingues testés	Fiches traduites par des professionnels et relues par des locuteurs ; préférer les ressources validées (Santé publique France, associations spécialisées)
Pictogrammes et photos	Recettes en images, gestes d'hygiène, allergènes ; vérifier qu'ils sont compris (certains symboles sont culturels)
Démonstration	Montrer avant d'expliquer ; faire faire
Cours de français à visée sociale	Partenariat avec les associations d'apprentissage du français : les ateliers culinaires peuvent être support d'apprentissage de la langue

Attention – Les enfants interprètes

Faire traduire des informations de santé par un enfant est à éviter : cela inverse les rôles familiaux, expose l'enfant à des informations qui ne le concernent pas et produit des erreurs de traduction. On recherche un interprète professionnel ou un adulte relais.

Travailler avec un interprète : avant, pendant, après

L'interprétariat professionnel fait l'objet d'un référentiel de la HAS (2017). Il peut se faire sur place ou par téléphone, ce qui le rend accessible même pour un atelier ou un entretien court. Un interprète professionnel traduit fidèlement, reste neutre et respecte le secret. Pour que l'échange se passe bien, le professionnel a lui aussi un rôle à jouer.

Moment	Ce que fait le professionnel
Avant	Réserver l'interprète à l'avance et vérifier la langue (et la variante régionale) ; présenter brièvement l'objectif de l'entretien ou de l'atelier et les mots techniques qui seront utilisés ; prévoir plus de temps (environ le double)

Moment	Ce que fait le professionnel
Au début	Présenter l'interprète et son rôle à la personne ; rappeler que tout sera traduit et que tout restera confidentiel
Pendant	Regarder et s'adresser à la **personne**, pas à l'interprète ; parler à la première personne (« Je vous conseille… ») ; faire des phrases courtes et s'arrêter souvent ; éviter les expressions imagées et l'humour difficile à traduire ; vérifier la compréhension avec le « faire dire »
Après	Faire un court bilan avec l'interprète (difficultés de traduction, malentendus culturels possibles) ; noter les mots qui ont posé problème pour les prochaines fois

Exemple – Une phrase difficile à traduire

La diététicienne dit : « Il faut y aller mollo sur le gras et ne pas avoir la main lourde sur le sel. » L'interprète doit d'abord deviner le sens de deux expressions familières avant de les traduire. Reformulation : « Mettez moins d'huile dans la poêle : une cuillère suffit. Mettez moins de sel : goûtez avant de saler. » Les deux phrases sont courtes, concrètes et se traduisent sans perte.

Attention – Médiateur, interprète, accompagnant : trois rôles différents

L'**interprète** traduit fidèlement et reste neutre. Le **médiateur en santé** crée le lien de confiance, explique les codes et accompagne vers les droits et les soins ; il peut traduire de façon informelle, mais ce n'est pas son rôle principal. Le **proche accompagnant** connaît la personne mais peut filtrer ou déformer l'information, volontairement ou non. Pour une information médicale importante (allergie, traitement, régime prescrit), on fait appel à un interprète professionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.32

Pendant un entretien avec interprète, une diététicienne dit à l'interprète : « Demandez-lui ce qu'elle mange le matin. » Relevez l'erreur, réécrivez la phrase, et citez deux autres règles à respecter pendant l'échange.

Corrigé

Elle parle à l'interprète et de la personne à la troisième personne, ce qui exclut la personne de l'échange. Réécriture, en regardant la personne : « Qu'est-ce que vous mangez le matin ? » Autres règles : faire des phrases courtes et s'arrêter pour laisser traduire ; éviter les expressions imagées ; vérifier la compréhension par le « faire dire » à la fin.

Des ressources multilingues et visuelles à connaître

Il est rarement utile de tout créer soi-même. Des ressources existent, conçues par des institutions ou des associations, souvent testées auprès des publics. Avant de les utiliser, on vérifie la date, la source et l'adaptation au public, comme pour tout outil pédagogique (5.3.13).

Ressource	Ce qu'elle propose	Point de vigilance
Livret de santé bilingue (Comede et Santé publique France)	Informations sur le système de santé et la prévention, en français et dans une autre langue, dans de nombreuses langues	Vérifier la dernière mise à jour et la présence de la langue souhaitée
Supports de Santé publique France et du PNNS	Affiches et dépliants sur les repères alimentaires, parfois en plusieurs langues ou en version adaptée	Repères de 2019 pour les adultes : vérifier la version

Ressource	Ce qu'elle propose	Point de vigilance
SantéBD	Bandes dessinées en FALC pour comprendre la santé, les consultations et certains examens	Conçu pour le handicap intellectuel, utile pour d'autres publics
Banques de pictogrammes libres de droits	Pictogrammes pour les recettes, les allergènes, les consignes	Tester la compréhension auprès du public (5.3.5)
Associations d'apprentissage du français et de médiation	Mots de vocabulaire alimentaire illustrés, ateliers de langue autour de la cuisine	Construire le partenariat en amont

Méthode pas à pas – Faire traduire un support écrit de santé

1. Simplifier d'abord le texte en français : un texte clair se traduit mieux.

2. Confier la traduction à un traducteur professionnel ou à un service spécialisé ; un outil de traduction automatique peut servir de brouillon, jamais de version finale.

3. Faire relire la traduction par une ou deux personnes dont c'est la langue, si possible du public visé.

4. Vérifier les images : certaines photos ou certains aliments peuvent ne rien évoquer ou choquer.

5. Tester le support traduit comme la version française, puis noter la date et la source sur le document.

Calcul détaillé – Choisir les langues à traduire (données fictives)

Dans une maison de quartier, le diagnostic oral auprès de 90 familles donne les langues parlées à la maison : arabe 28, turc 17, tamoul 9, roumain 7, autres langues (moins de 4 familles chacune) 11, français seulement 18.

- Familles qui parlent une autre langue que le français : 90 − 18 = **72**, soit 72 / 90 × 100 = **80,0 %**.
- Les trois premières langues réunissent 28 + 17 + 9 = **54** familles, soit 54 / 72 × 100 = **75,0 %** des familles qui parlent une autre langue.

Décision : traduire les supports clés en arabe, en turc et en tamoul ; pour les autres familles, s'appuyer sur les images, la démonstration et l'interprétariat par téléphone pour les entretiens importants.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.33

Une collègue a traduit la fiche « goûters » en roumain avec un traducteur automatique et veut l'imprimer à 200 exemplaires. Citez deux risques et décrivez ce que vous proposez avant l'impression.

Corrigé

Risques : erreurs de sens (mots de cuisine, quantités, allergènes) qui peuvent être dangereuses ; phrases incompréhensibles qui décrédibilisent la structure. Proposition : simplifier le texte français, faire relire ou traduire par une personne compétente dont c'est la langue, tester la fiche auprès de deux ou trois familles roumanophones, puis imprimer un petit nombre d'exemplaires.

Une adaptation pour chaque situation

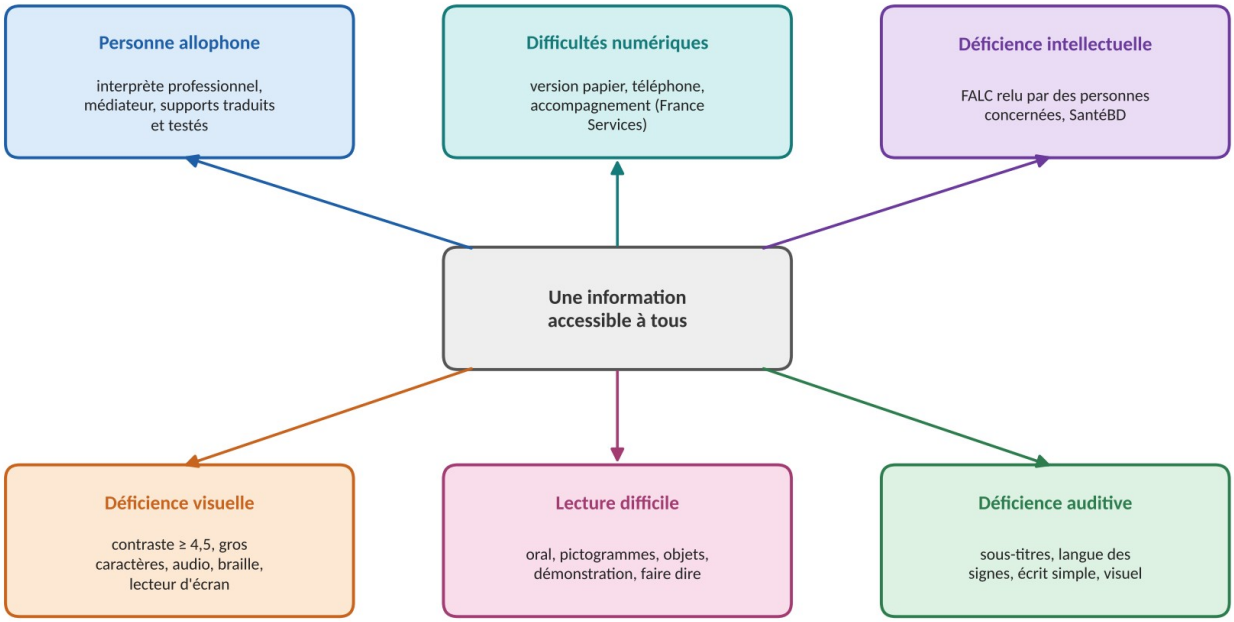


Figure 5.8 bis – Adapter l'information selon la situation de la personne

Comprendre le schéma – Figure 5.8 bis

1. Au centre, l'objectif commun : une information **accessible à tous**. Les six cases montrent des situations fréquentes, qui peuvent se cumuler chez une même personne.
2. **Langue** et **numérique** (en haut) relèvent surtout de l'organisation : interprète, médiateur, version papier, téléphone, accompagnement France Services.
3. **Déficiences** intellectuelle, visuelle et auditive : chacune appelle des adaptations précises (FALC, contraste et audio, sous-titres et langue des signes), qui se préparent avec les associations concernées.
4. **Lecture difficile** : l'oral, les objets, la démonstration et le faire dire, qui profitent à tous les publics.
5. Beaucoup d'adaptations sont utiles à plusieurs situations à la fois : une vidéo sous-titrée avec un commentaire audio aide les personnes sourdes, malvoyantes, allophones et celles qui lisent peu.

Situation	Adaptations à prévoir pour un atelier cuisine
Déficience visuelle	Accueil oral et description des lieux ; recette en gros caractères ou en audio ; ustensiles toujours rangés au même endroit ; repères tactiles (élastique sur un flacon) ; décrire ce que l'on fait pendant la démonstration
Déficience auditive	Interprète en langue des signes française ou codeur en langue française parlée complétée selon les personnes ; animatrice face au groupe, visage éclairé ; bruit réduit ; consignes écrites et visuelles ; boucle magnétique si disponible
Déficience intellectuelle	Supports en FALC, une étape à la fois, routines stables, durée courte, valorisation, aide d'un éducateur connu
Handicap moteur	Plan de travail à hauteur adaptée, ustensiles ergonomiques, circulation libre, toilettes accessibles
Troubles psychiques	Cadre rassurant, petit groupe, possibilité de faire une pause, pas d'obligation de parler

À vous de jouer – Exercice d'application 5.34

Un groupe d'atelier comprend une personne malvoyante et une personne qui parle peu le français. Proposez

trois adaptations qui aident les deux à la fois.

Corrigé

Décrire à voix haute chaque geste pendant la démonstration, avec des mots simples et des phrases courtes ; faire toucher et sentir les aliments et les ustensiles avant de commencer ; proposer une recette en audio (message vocal) avec des étapes numérotées ; travailler en binôme avec un participant qui guide. Ces adaptations s'appuient sur l'oral, le toucher et la démonstration plutôt que sur l'écrit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.10 et 5.3.11 – Numérique et langues

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel ratio de contraste minimal faut-il pour un texte courant (niveau AA) ?
2. Pourquoi ne faut-il jamais donner une information par la couleur seule ?
3. Citez les quatre étapes du « sandwich de vérité ».
4. Citez deux dispositifs publics d'accompagnement au numérique.
5. Citez deux règles à respecter pendant un entretien avec un interprète.
6. Pourquoi ne pas imprimer directement un support traduit automatiquement ?

Corrigé – Point d'étape 5.3.10 et 5.3.11

1. 4,5 (et 3 pour un grand texte).
2. Parce que les personnes daltoniennes (environ 8 % des hommes) et les photocopies en noir et blanc ne distinguent pas les couleurs.
3. Dire le fait juste, nommer l'idée fausse une fois en disant qu'elle est fausse, expliquer pourquoi elle circule, redire le fait juste avec une action.
4. Espaces France Services, conseillers numériques, Aidants Connect.
5. S'adresser à la personne et non à l'interprète, parler à la première personne, faire des phrases courtes, éviter les expressions imagées.
6. La traduction peut contenir des erreurs de sens dangereuses ; il faut la faire relire par une personne compétente et la tester.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes des deux sections et je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.10 et 5.3.11 et je refais les exercices d'application.

5.3.12 Concevoir et tester un support accessible : un exemple complet

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Exemple – Avant et après : la fiche « Bien conserver les aliments » d'une épicerie solidaire

Version initiale : texte de 260 mots en 9 phrases, police de 10 points, justifié, trois sigles (DLC, DDM, HACCP), aucune image ; 520 syllabes.

- Indice de lisibilité : mots par phrase 260 / 9 = **28,9** ; syllabes par mot 520 / 260 = **2,0** ; L = 207 − 1,015 × 28,9 − 73,6 × 2,0 = 207 − 29,33 − 147,2 = **30,47** : texte difficile, à la limite du « très difficile ».

Version réécrite : 110 mots en 16 phrases courtes, 160 syllabes ; 6 pictogrammes (réfrigérateur,

thermomètre, calendrier, poubelle barrée…) ; police de 14 points ; un seul message par encadré.

- L = 207 − 1,015 × (110 / 16) − 73,6 × (160 / 110) = 207 − 1,015 × 6,875 − 73,6 × 1,4545 = 207 − 6,98 − 107,05 = **92,97** : très facile.

Test auprès de 8 bénéficiaires : question « Où rangez-vous la viande dans le réfrigérateur ? » (bonne réponse : en haut ou dans la zone la plus froide, selon le modèle) : version initiale 3 bonnes réponses sur 8 (**37,5** %) ; version réécrite 7 sur 8 (**87,5 %**). Question « Peut-on manger un yaourt après la date ? » (réponse attendue : non si DLC) : 2 / 8 (**25 %**) puis 6 / 8 (**75 %**). **Conclusion** : l'indice de lisibilité confirme l'amélioration, mais c'est le **test auprès du public** qui prouve la compréhension.

Tester un support par l'entretien cognitif

Le test d'un support (5.3.12) peut se limiter à une ou deux questions. Pour un support important (livret, affiche d'une campagne, questionnaire de diagnostic), on utilise une méthode plus complète : l'**entretien cognitif**. Issue de la recherche sur les questionnaires (Willis, 2005), elle consiste à demander à quelques personnes du public de lire ou d'utiliser le support **à voix haute**, puis à leur poser des questions précises sur ce qu'elles ont compris.

Méthode pas à pas – Conduire un entretien cognitif de 20 minutes

1. Préparer : choisir 5 à 8 personnes proches du public (langue, âge, lecture), un lieu calme, une grille de questions ; expliquer que l'on teste le document, pas la personne.

2. Penser à voix haute : « Lisez ce document comme chez vous, et dites tout ce qui vous passe par la tête. » On n'aide pas, on note les hésitations.

3. Questions de relance : « Que veut dire ce mot pour vous ? » ; « Avec vos mots, que vous demande-t-on de faire ? » ; « Qu'est-ce qui vous a gêné ? » ; « Que représente cette image ? »

4. Tâche pratique : « Montrez-moi la quantité de riz pour 4 personnes », « Où appelez-vous pour vous inscrire ? »

5. Remercier et noter dans un tableau : problème repéré, nombre de personnes concernées, correction proposée.

Calcul détaillé – Le tableau de synthèse d'un test (livret de recettes, 6 testeuses, données fictives)

Problème repéré	Personnes concernées	Part	Décision
« Émincer » non compris	5 sur 6	83,3 %	Remplacer par « couper en fines lamelles » + photo
Photo de l'étape 3 confondue avec l'étape 4	3 sur 6	50,0 %	Refaire la photo en gros plan
Quantité « 1 verre » : quel verre ?	4 sur 6	66,7 %	Ajouter la photo du verre de référence
Numéro de téléphone trop petit	1 sur 6	16,7 %	Agrandir (correction simple, gardée même si une seule personne l'a signalée)

Règle de décision : on corrige tous les problèmes qui empêchent de comprendre ou d'agir, quel que soit le nombre de personnes ; on discute en équipe des remarques de goût (couleurs, style).

Attention – Ce que l'entretien cognitif ne dit pas

Il montre si le support est compris, pas s'il fera changer les pratiques. Il porte sur quelques personnes, choisies, souvent plus motivées que la moyenne. Il complète l'indice de lisibilité et ne remplace pas l'évaluation de l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.35

Rédigez quatre questions de relance pour tester une affiche qui annonce un atelier « goûters » pour des parents d'une école maternelle.

Corrigé

« Avec vos mots, qu'est-ce que l'affiche vous propose ? » ; « Quel jour et à quelle heure est l'atelier ? Où ? » ; « Que veut dire, pour vous, le mot "goûter équilibré" ? » ; « Que représente la photo en bas à droite ? » On peut ajouter une tâche : « Montrez-moi comment vous feriez pour vous inscrire. »

5.3.13 Choisir et concevoir des outils pédagogiques accessibles

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Les **outils pédagogiques** (jeux, cartes, photos, maquettes, vidéos) rendent les notions concrètes et favorisent la participation, surtout auprès des publics à littératie limitée. Les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé mettent à disposition des **pédagothèques** (prêt d'outils) et des bases documentaires qui en présentent l'analyse.

Type d'outil	Exemples en nutrition	Intérêt pour la littératie
Objets réels	Emballages vides, aliments, ustensiles, verres doseurs, morceaux de sucre	Concrets, compréhensibles sans lecture
Photos et photolangage	Photos de plats, de portions, de situations de repas	Expression sans écrit, représentations
Maquettes et répliques d'aliments	Répliques de portions (féculents, viande, fromage)	Estimer les quantités (numératie)
Jeux de cartes et de plateau	Classer des aliments, composer un menu à petit prix	Apprentissage actif, coopération
Outils numériques	Vidéos courtes sous-titrées, quiz sur tablette	Attractifs, à accompagner (illectronisme)
Supports à emporter	Fiches recettes en photos, calendrier des légumes secs, aimant « repères »	Rappel à la maison

Méthode pas à pas – Analyser un outil pédagogique avant de l'utiliser : 8 questions

1. **Qui l'a conçu**, quand, avec quelles sources ? (institution, association, marque ?)
2. Le **contenu** est-il exact et à jour (repères de 2019, PNNS 5) ?
3. Les **objectifs** de l'outil correspondent-ils aux miens ?
4. Le **public** visé (âge, langue, littératie) correspond-il au mien ?
5. L'outil favorise-t-il la **participation** ou seulement l'écoute ?
6. Est-il **non stigmatisant** (images de corps, vocabulaire moral) ?
7. Est-il **accessible** (images, peu d'écrit, manipulation simple) ?
8. Quelles **adaptations** sont nécessaires (traduction, simplification, prix locaux) ?

Exemple – Concevoir un jeu « le panier à 10 € » (littératie alimentaire et numératie)

Objectif : composer, en groupe, les repas d'une journée pour 4 personnes avec 10 €. **Matériel** : 30 cartes-aliments avec photo, nom, portion et **prix par portion** (par exemple lentilles 0,16 € ; œufs 0,28 € l'unité ; poulet 0,75 € ; yaourt 0,18 € ; pomme 0,30 € ; pain complet 0,10 € la tranche). **Déroulé** : chaque équipe compose 3 repas et un goûter, additionne les prix, vérifie la présence des familles d'aliments (code couleur),

présente son panier. **Exemple de calcul** d'un déjeuner pour 4 : lentilles 4 × 0,16 = 0,64 € ; riz 4 × 0,14 = 0,56 € ; carottes 4 × 0,19 = 0,76 € ; yaourts 4 × 0,18 = 0,72 € ; pommes 4 × 0,30 = 1,20 € ; total **3,88 €**, soit 0,97 € par personne. **Intérêt** : manipuler des prix réels, comparer, discuter, sans lecture complexe.

Le photolangage : faire parler sans écrire

Le **photolangage** est une méthode d'animation née à Lyon à la fin des années 1960, dans la formation des adultes. On étale sur une table une série de photos variées ; chaque participant choisit une ou deux photos qui répondent à une question, puis explique son choix au groupe. Il se distingue de l'image d'illustration : la photo n'est pas là pour montrer la « bonne réponse », mais pour **aider à parler** de ses représentations et de son expérience. C'est un outil précieux avec les publics qui lisent peu ou qui parlent peu le français.

Méthode pas à pas – Animer un photolangage en 30 minutes

1. Préparer la question : ouverte et liée à l'objectif (« Choisissez une photo qui représente pour vous un bon repas en famille »).

2. Choisir 30 à 50 photos variées : plats de différentes cultures, situations de repas (seul, en famille, devant un écran), lieux d'achat, personnes de tous âges et de toutes corpulences ; éviter les photos publicitaires et les images qui jugent.

3. Temps de choix silencieux (5 minutes) : chacun regarde et choisit, sans parler.

4. Tour de parole (20 minutes) : chacun montre sa photo et dit pourquoi ; l'animateur reformule, ne juge pas, ne corrige pas.

5. Synthèse (5 minutes) : l'animateur relève les points communs et les différences, qui serviront de point de départ à l'atelier.

Exemple – Ce que le photolangage a révélé

Dans un atelier avec des mères de jeunes enfants, la question était : « Choisissez une photo qui montre un goûter pour votre enfant. » Plusieurs mères ont choisi la photo d'une boisson à la fraise et d'un gâteau emballé : « C'est ce qu'il aime, et c'est propre, ça vient du magasin. » D'autres ont choisi la photo d'un pain avec du chocolat : « Chez nous, c'était ça. » L'animatrice a découvert que pour certaines mères, le produit emballé était un signe de **soin** et de **sécurité**. Elle a construit la suite de l'atelier sur cette idée, au lieu de commencer par les « sucres cachés ».

Attention – Respecter les règles du photolangage

Chacun a le droit de ne pas parler ou de passer son tour ; on ne commente pas le choix des autres ; ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Les photos de personnes doivent être libres de droits et ne pas présenter de corps comme des modèles ou des contre-modèles.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.36

Vous préparez un photolangage pour un groupe de retraités sur le thème « manger seul ». Rédigez la question posée et citez six photos à prévoir.

Corrigé

Question : « Choisissez une photo qui ressemble à votre repas du soir, ou à celui que vous aimeriez avoir. » Photos : une personne âgée qui mange seule devant la télévision ; un repas partagé au club ; un plateau-repas livré ; une soupe maison ; un marché ; une table dressée avec une nappe et des fleurs ; un sandwich sur

un coin de table ; une cuisine collective. Les photos montrent des situations variées, sans porter de jugement.

5.3.14 Animer un atelier accessible : une séquence type

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Un atelier conçu selon les **précautions universelles** (5.3.4) profite à tous. La séquence suivante, de 2 heures, intègre les principes du chapitre.

Durée	Étape	Adaptations de littératie
10 min	Accueil	Accueil individuel, prénom écrit en grand, consignes de sécurité montrées (pictogrammes, démonstration), interprète ou médiatrice si besoin
10 min	Recueil des pratiques	Photolangage : « Montrez la photo qui ressemble à votre repas d'hier soir » ; aucune lecture nécessaire
15 min	Message principal	Un seul message (« les légumes secs : bons, rassasiants, pas chers »), avec objets réels (sachets, verre doseur, prix) ; chiffres concrets (0,16 € la portion)
15 min	Démonstration	Geste clé montré lentement (rincer, cuire les lentilles corail), puis refait par un participant
40 min	Pratique en binômes	Recette en photos (une action par photo), binômes mixtes (lecteur / non- lecteur, langues), animateur qui circule et reformule
15 min	Dégustation	Vocabulaire sensoriel simple, échelle à smileys
10 min	Faire dire	Chaque binôme montre ou explique une astuce ; l'animateur réexplique autrement si besoin
5 min	Clôture	Fiche recette en photos à emporter, rappel oral de la date suivante (et message vocal la veille)

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la compréhension en fin d'atelier

L'animatrice note, pour 10 participants, la réussite de trois « faire dire » : expliquer la cuisson des lentilles corail (8 réussites), estimer le coût d'une portion à 20 centimes près (6 réussites), citer une recette à refaire (10 réussites).

- Taux de réussite : 8 / 10 = **80 %** ; 6 / 10 = **60 %** ; 10 / 10 = **100 %**.
- Moyenne des trois : (80 + 60 + 100) / 3 = 240 / 3 = **80 %**.
- **Ajustement** : l'estimation du coût est la moins réussie (numératie) : à la séance suivante, l'animatrice prévoit des étiquettes de prix par portion déjà calculées et un exercice de comparaison en binôme.

Adapter la séquence type à quelques publics

La séquence type de 2 heures (5.3.14) se modifie selon le public. Les principes restent les mêmes (précautions universelles, démonstration, faire dire), mais la durée, le rythme et les supports changent.

Public	Adaptations principales
Enfants de 6 à 10 ans	Séance d'une heure ; consignes très courtes ; une tâche par enfant (laver, verser, mélanger) ; vocabulaire des sens (« croquant, doux, acide ») ; dégustation avec une échelle à 3 visages ; aucun jugement sur ce que les familles mangent
Adolescents	Partir de leurs pratiques (restauration rapide, boissons énergisantes) ; méthodes actives et défis ; usage du téléphone (photo, vidéo) ; éviter le ton moralisateur ; donner des choix

Public	Adaptations principales
Personnes âgées	Rythme lent, grande police, bonne lumière, sièges ; tenir compte de l'audition et de la vue ; recettes simples à une seule casserole ; lien social au cœur de la séance
Personnes en situation de handicap intellectuel	Séance courte et régulière, même jour et même lieu ; supports FALC, pictogrammes, une étape à la fois ; routines (lavage des mains en chanson) ; présence d'un éducateur connu
Personnes allophones	Démonstration avant explication ; vocabulaire illustré ; interprète pour les consignes de sécurité ; binômes de même langue si possible ; recettes des pays d'origine valorisées

Exemple – La séance d'un ESAT, en 1 h 15 (données fictives)

L'atelier « Salade de pâtes » accueille 8 travailleurs d'un ESAT, le jeudi à 14 h, chaque semaine pendant 6 semaines. Déroulé : accueil et lavage des mains avec la même chanson chaque semaine (10 minutes) ; présentation des ingrédients réels, chacun nomme ou montre un ingrédient (10 minutes) ; démonstration de l'étape du jour (10 minutes) ; préparation en binômes avec la recette en 5 photos (25 minutes) ; dégustation et vote avec gommettes (10 minutes) ; rangement et « faire faire » : chaque binôme montre l'étape qu'il a réussie (10 minutes). Total : 10 + 10 + 10 + 25 + 10 + 10 = **75 minutes**.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.37

Un club de collégiens veut un atelier « petit-déjeuner » d'une heure, de 12 h 30 à 13 h 30. Proposez un déroulé minuté avec deux adaptations propres à ce public.

Corrigé

Exemple : 5 minutes d'accueil ; 10 minutes de défi « le vrai prix du petit-déjeuner » (les élèves classent par prix des produits réels et des photos de petits-déjeuners) ; 10 minutes de démonstration d'un petit-déjeuner rapide (pain, fromage, fruit, boisson) ; 20 minutes de préparation en équipes, chacune invente sa version ; 10 minutes de dégustation et de photos ; 5 minutes de « faire dire » : chaque équipe dit l'astuce qu'elle va utiliser un matin pressé. Total : 60 minutes. Adaptations : partir des contraintes réelles des élèves (temps, réveil tardif) sans les juger ; utiliser leur téléphone pour photographier leur création et la partager.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.3.12 à 5.3.15 – Supports, outils et ateliers accessibles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un entretien cognitif ? Combien de personnes faut-il environ ?
2. Pourquoi l'indice de lisibilité ne suffit-il pas pour valider un support ?
3. Citez quatre des huit questions pour analyser un outil pédagogique.
4. Décrivez en trois étapes l'animation d'un photolangage.
5. Citez deux adaptations d'un atelier pour des personnes âgées.
6. Dans le fil rouge des Tilleuls, citez deux adaptations de la communication.

Corrigé – Point d'étape 5.3.12 à 5.3.15

1. Une méthode de test où des personnes du public lisent ou utilisent le support à voix haute, puis répondent à des questions sur ce qu'elles ont compris ; 5 à 8 personnes.
2. Il ne mesure ni le sens des mots, ni les sigles, ni les images, ni la mise en page ; seul un test auprès du public montre la compréhension.

3. Qui l'a conçu ; contenu à jour ; objectifs ; public visé ; participation ; non-stigmatisation ; accessibilité ; adaptations nécessaires.
4. Choix silencieux d'une photo à partir d'une question ouverte ; tour de parole où chacun explique son choix ; synthèse par l'animateur, sans jugement.
5. Rythme lent, grande police et bonne lumière, prise en compte de l'audition, recettes simples, place du lien social.
6. Invitation sur papier, message vocal WhatsApp enregistré par la référente familles, bouche-à-oreille par les mamans relais, pas d'inscription seulement en ligne.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes des sections 5.3.12 à 5.3.14.
Moins de 3 sur 6	Je relis les sections 5.3.12 à 5.3.15 et je refais les exercices d'application.

5.3.15 Fil rouge : la littératie au centre social des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a observé et adapté

- **Diagnostic** : lors de la passation du questionnaire à la sortie de l'école, 11 parents sur 48 ont demandé à Inès de lire les questions à voix haute ; 6 parents parlaient peu le français. Inès a donc réalisé la passation **en entretien oral**, avec l'aide d'une médiatrice parlant arabe et soninké.
- **Calcul** : 11 / 48 × 100 = **22,9 %** des parents ont eu besoin d'une lecture orale ; 6 / 48 × 100 = **12,5 %** parlaient peu le français. Ces chiffres ne sont pas des taux d'illettrisme : ils indiquent un **besoin d'adaptation**.
- **Supports** : les fiches recettes ont été refaites en **photos** (une photo par étape), avec des quantités en verres et en cuillères ; l'indice de lisibilité de la fiche « lentilles corail » est passé de 54 à 82 après réécriture ; la fiche a été testée par 3 mamans du groupe.
- **Animation** : à chaque atelier, Inès termine par un « tour de faire dire » : chaque binôme explique au groupe une astuce retenue.
- **Communication** : invitation sur papier, message vocal WhatsApp enregistré par la référente familles, bouche-à-oreille par les mamans relais ; pas d'inscription uniquement en ligne.
- **Évaluation** : questionnaire de satisfaction à **smileys** et question orale « Qu'allez-vous refaire à la maison ? ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : l'atelier « lire une étiquette » et le livret des Tilleuls

- **Atelier étiquettes** (intégré à l'atelier 4) : comparaison de deux céréales et de deux boissons, morceaux de sucre posés à côté des bouteilles ; à la question « Combien de morceaux de sucre dans cette bouteille de 33 cL ? », 2 parents sur 11 répondaient juste avant la démonstration (18,2 %), 9 sur 11 après (81,8 %).
- **Numératie** : Inès a remplacé « 400 g de fruits et légumes » par « 5 portions = 5 poings » et « 2 fois par semaine des légumes secs » par un calendrier illustré de la semaine.
- **Livret de recettes** : indice de lisibilité moyen des 12 fiches 84 (minimum 78, maximum 91) ; chaque recette en 6 photos au plus, quantités en verres et cuillères ; testé par 3 mamans (correction de 4 mots jugés difficiles : « émincer », « blanchir », « réserver », « assaisonner »).
- **Allophones** : 6 familles sur 12 parlent une autre langue à la maison ; une médiatrice a traduit oralement les consignes de sécurité ; les allergènes étaient signalés par pictogrammes.
- **Numérique** : 9 familles sur 12 utilisent WhatsApp : rappels vocaux la veille ; aucune inscription n'était

uniquement en ligne.

5.3.16 Six cas guidés pour s'entraîner à intégrer la littératie

Module · Référentiel et guide : voir 5.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 5.2.2)

Ces six cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre attendu par le jury : décrire la situation avec des chiffres, l'analyser avec les notions du cours, puis proposer des adaptations argumentées qui valent pour tout le public. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – L'affiche du menu végétarien au restaurant universitaire (données fictives)

Un restaurant universitaire propose chaque jour un plat végétarien, peu choisi. L'affiche actuelle, en police de 11 points, gris clair sur fond blanc, dit : « Dans le cadre de notre engagement en faveur d'une alimentation durable, nous vous proposons quotidiennement une alternative végétarienne équilibrée… » Elle compte 96 mots, 4 phrases et 175 syllabes. Une enquête auprès de 120 étudiants montre que 41 savent qu'un plat végétarien est proposé chaque jour ; 180 plats végétariens sont vendus sur 1 450 repas par jour.

Une nouvelle affiche est conçue avec des étudiants : 60 mots, 9 phrases, 87 syllabes, photo du plat du jour, texte noir. Deux semaines plus tard, 78 étudiants sur 130 interrogés connaissent l'offre et 255 plats végétariens sont vendus sur 1 480 repas.

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez l'indice de lisibilité des deux affiches et les pourcentages avant et après (connaissance de l'offre, part des plats végétariens vendus).
2. Relevez trois défauts de l'ancienne affiche.
3. Peut-on attribuer toute la hausse des ventes à la nouvelle affiche ? Justifiez.
4. Proposez deux autres actions, en dehors de l'affiche, pour faire connaître le plat végétarien.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Ancienne affiche : 96 / 4 = 24 mots par phrase ; 175 / 96 = 1,823 syllabe par mot ; L = 207 − 24,36 − 134,17 = **48,47** : difficile. Nouvelle : 60 / 9 = 6,67 ; 87 / 60 = 1,45 ; L = 207 − 6,77 − 106,72 = **93,51** : très facile. Connaissance de l'offre : 41 / 120 = **34,2 %** puis 78 / 130 = **60,0 %**. Part des plats végétariens : 180 / 1 450 = **12,4 %** puis 255 / 1 480 = **17,2 %**.

2. Contraste faible (gris clair sur blanc) ; petite police ; phrases longues et jargon (« dans le cadre de notre engagement », « alternative ») ; aucune image du plat ; le message principal (« un plat végétarien chaque jour ») n'apparaît pas d'abord.

3. Non : il n'y a pas de groupe de comparaison, et d'autres facteurs ont pu jouer en deux semaines (plats du jour plus appréciés, météo, bouche-à-oreille, prix). On parle d'une évolution favorable observée, à confirmer sur une plus longue période.

4. Une dégustation gratuite du plat végétarien à l'entrée du self ; une présentation du plat en première position sur la ligne de self ; une publication sur les réseaux sociaux des associations étudiantes avec la photo du jour ; un pictogramme « végétarien » sur le menu en ligne.

Cas guidé 2 – Le courrier aux parents après le bilan de santé de l'école (données fictives)

Lors du bilan de santé des élèves de 6 ans d'une circonscription, l'infirmière scolaire a mesuré 112 enfants ; 14 ont un indice de masse corporelle au-dessus de la zone habituelle pour leur âge. Les parents de ces 14 enfants ont reçu dans le cartable une lettre : « Votre enfant présente un IMC supérieur au 97e percentile des courbes de référence ; une prise en charge est recommandée. » Seuls 6 parents sont venus à la réunion

proposée. Une mère a dit : « J'ai cru que mon fils était malade. Il a lu la lettre avant moi. »

Questions – Cas guidé 2

1. Calculez la part d'enfants concernés et la part de parents venus à la réunion.

2. Expliquez le « 97e percentile » en fréquences naturelles, avec des mots simples.

3. Relevez les problèmes de littératie et d'éthique de ce courrier.

4. Proposez une autre façon d'informer ces familles.

Corrigé – Cas guidé 2

1. Enfants concernés : 14 / 112 = **12,5 %**. Parents venus : 6 / 14 = **42,9 %**.

2. « Si l'on range 100 enfants du même âge et du même sexe du plus mince au plus fort, votre enfant fait partie des 3 enfants les plus forts. » On ajoute que ce n'est pas une maladie, mais un repère qui invite à faire le point.

3. Littératie : vocabulaire technique (IMC, percentile, courbes de référence, prise en charge) ; aucune explication ni conseil concret ; aucune personne à contacter. Éthique : courrier transmis par le cartable, que l'enfant peut lire ; risque de stigmatisation et d'inquiétude ; le mot « prise en charge » fait penser à une maladie ; la confidentialité n'est pas garantie.

4. Un entretien individuel proposé par téléphone ou à la sortie de l'école, avec l'infirmière, sans l'enfant ; une courbe de corpulence montrée et expliquée oralement ; des conseils centrés sur toute la famille (repas, activité, sommeil), sans parler de régime ; l'orientation vers le médecin traitant ; un courrier envoyé par voie postale, court et en écriture claire, qui propose simplement un rendez-vous. Pour toutes les familles de l'école, une action collective non ciblée (atelier goûters, activité physique) évite de désigner les enfants.

Cas guidé 3 – L'application des menus de la cantine (données fictives)

Une commune de 2 400 élèves remplace l'affichage papier des menus par une application. Une enquête auprès de 300 parents montre : 171 ont installé l'application ; 120 consultent les menus chaque semaine ; 135 souhaitent garder un menu papier ; parmi les 63 parents d'enfants allergiques, 48 trouvent l'information sur les allergènes. Dans l'application, le texte est gris moyen (#8A8A8A, luminance relative 0,2542) sur fond blanc.

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez les pourcentages de l'enquête.

2. Calculez le ratio de contraste du texte et concluez.

3. Analysez les risques de cette dématérialisation pour les familles.

4. Proposez quatre améliorations.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Application installée : 171 / 300 = **57,0 %** ; consultation hebdomadaire : 120 / 300 = **40,0 %** ; menu papier souhaité : 135 / 300 = **45,0 %** ; parents d'enfants allergiques qui trouvent l'information : 48 / 63 = **76,2 %**, donc **23,8 %** ne la trouvent pas.

2. (1 + 0,05) / (0,2542 + 0,05) = 1,05 / 0,3042 = **3,45** : sous le seuil de 4,5 pour un texte courant ; seul un grand texte serait conforme.

3. 43 % des parents n'ont pas l'application et 60 % ne consultent pas les menus chaque semaine : les familles éloignées du numérique perdent l'information. Pour les allergies, près d'un parent concerné sur quatre ne

trouve pas l'information : c'est un risque pour la sécurité des enfants. Le faible contraste gêne la lecture.

4. Garder un affichage papier à l'entrée de l'école et sur le site de la mairie ; ajouter dans l'application des pictogrammes d'allergènes et un texte foncé (par exemple #595959, ratio de 7,0) ; envoyer chaque mois le menu papier aux familles qui le demandent ; organiser une présentation de l'application lors d'une réunion de parents, avec un « faire faire » (trouver les allergènes du jeudi) ; prévoir un contact téléphonique pour les parents d'enfants allergiques.

Cas guidé 4 – Les boissons énergisantes au club de football (données fictives, étiquette courante)

Un club de football amateur accueille 46 joueurs de 13 à 17 ans. L'entraîneur vous alerte : 21 jeunes boivent une boisson énergisante au moins une fois par semaine, dont 14 avant les matchs. L'étiquette d'une canette de 250 mL courante indique pour 100 mL : 11 g de sucres et 32 mg de caféine. Un jeune dit : « Ça donne des ailes, c'est fait pour le sport. »

Questions – Cas guidé 4

1. Calculez la part de jeunes concernés, puis le sucre (en grammes et en morceaux) et la caféine d'une canette.
2. Un jeune de 50 kg boit deux canettes avant un match. Comparez sa dose de caféine à la valeur de 3 mg par kilogramme de poids corporel retenue par l'EFSA (2015) pour les enfants et adolescents.
3. Analysez la phrase du jeune avec la notion de littératie critique.
4. Proposez une séance de 45 minutes avec les jeunes, puis une action avec le club.

Corrigé – Cas guidé 4

1. Au moins une fois par semaine : 21 / 46 = **45,7 %** ; avant les matchs : 14 / 46 = **30,4 %**. Sucres : 11 × 2,5 = **27,5 g**, soit **5,5 morceaux** (55 % du repère de 50 g de sucres libres pour un adulte) ; caféine : 32 × 2,5 = **80 mg**.

2. Valeur de l'EFSA : 3 × 50 = **150 mg**. Deux canettes : 2 × 80 = **160 mg**, au-dessus de cette valeur. L'ANSES (2013) déconseille la consommation de boissons énergisantes par les enfants et les adolescents, et au cours d'un effort physique.

3. Le jeune reprend un slogan publicitaire comme une information de santé. La littératie critique consiste à se demander qui parle (une marque), dans quel but (vendre) et ce que disent les sources indépendantes (pas d'intérêt pour la performance, risques liés à la caféine et au sucre).

4. Séance : 10 minutes de « vrai ou faux » sur les boissons ; 10 minutes pour poser les morceaux de sucre à côté de la canette ; 15 minutes d'analyse d'une publicité en petits groupes (qui, pourquoi, quelles preuves) ; 10 minutes pour fabriquer une boisson de match (eau, un peu de jus) et faire dire « ce que je bois avant et pendant le match ». Action avec le club : remplacer la vente de boissons énergisantes à la buvette par de l'eau et des fruits ; informer les parents par un message court ; impliquer l'entraîneur, que les jeunes écoutent.

Cas guidé 5 – Cuisiner les légumes du chantier d'insertion (données fictives)

Un chantier d'insertion en maraîchage emploie 18 salariés. Lors d'entretiens oraux, 7 disent lire difficilement, 5 parlent peu le français et 12 disent ne pas cuisiner les légumes qu'ils récoltent (« je ne sais pas quoi faire des courgettes »). L'encadrante propose un atelier « tortilla de courgettes » pour 6 personnes : 6 œufs (3,30 € les 12), 600 g nets de pommes de terre (1,20 € le kg, 15 % de pertes), 600 g de courgettes du jardin (sans coût), 100 g nets d'oignon (1,80 € le kg, 10 % de pertes), 30 g d'huile d'olive (6,50 € le kg), sel et poivre (forfait de 0,20 €). Au premier atelier, 14 salariés sont présents ; 11 réussissent à montrer comment couper et cuire les légumes.

Questions – Cas guidé 5

1. Calculez les pourcentages du diagnostic, de la présence et de la réussite du « faire faire ».

2. Calculez le coût de la recette pour 6 et par portion.

3. Situez les difficultés dans les domaines de la littératie alimentaire.

4. Proposez trois adaptations de l'atelier et un support à emporter.

Corrigé – Cas guidé 5

1. Lisent difficilement : 7 / 18 = **38,9 %** ; parlent peu le français : 5 / 18 = **27,8 %** ; ne cuisinent pas les légumes récoltés : 12 / 18 = **66,7 %**. Présence : 14 / 18 = **77,8 %** ; réussite : 11 / 14 = **78,6 %**.

2. Œufs : 6 × 3,30 / 12 = 1,65 € ; pommes de terre : 600 / 0,85 = 705,9 g bruts, soit 0,85 € ; oignon : 100 / 0,90 = 111,1 g bruts, soit 0,20 € ; huile : 0,030 × 6,50 = 0,20 € ; forfait : 0,20 €. Total : 1,65 + 0,85 + 0,20 + 0,20 + 0,20 = **3,09 €** (calcul non arrondi : 3,09 €), soit environ **0,52 €** par portion.

3. Préparer : ne pas savoir cuisiner les légumes récoltés (domaine principal). Planifier et gérer : utiliser ce que l'on a, sans gaspiller. Sélectionner : l'accès aux légumes est déjà assuré par le chantier, c'est un atout. Manger : faire goûter et partager un repas entre collègues.

4. Démonstration de chaque geste avant de le faire faire ; recette en 6 photos, une action par photo, quantités en nombre (« 6 œufs », « 4 pommes de terre moyennes ») ; binômes mélangeant lecteurs et non-lecteurs, et participants de même langue si besoin ; dégustation au repas de midi du chantier. Support : une carte recette en photos, avec un pictogramme de saison pour chaque légume, et un message vocal de l'encadrante qui reprend les étapes.

Cas guidé 6 – Former les aides à domicile au « faire dire » (données fictives)

Un service d'aide à domicile veut prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'il accompagne. Les 24 aides à domicile ont suivi une formation de 3 heures : conseils d'enrichissement des repas, écriture claire, « faire dire ». Avant et après la formation, une responsable a observé 2 visites par aide (48 visites) et noté si l'aide vérifiait la compréhension d'un conseil. Elle a aussi demandé à 24 personnes accompagnées d'expliquer un conseil d'enrichissement reçu. Résultats : vérification de la compréhension dans 5 visites sur 48 avant, 29 sur 48 après ; explication correcte par 9 personnes sur 24 avant, 17 sur 24 après.

Questions – Cas guidé 6

1. Calculez les pourcentages avant et après, et leur évolution en points.

2. Montrez que cette action relève à la fois de la littératie des personnes et de la littératie organisationnelle.

3. Citez deux limites de cette évaluation.

4. Proposez deux actions pour faire durer les effets de la formation.

Corrigé – Cas guidé 6

1. Vérification de la compréhension : 5 / 48 = **10,4 %** avant, 29 / 48 = **60,4 %** après, soit **+ 50,0 points**. Explication correcte par les personnes accompagnées : 9 / 24 = **37,5 %** avant, 17 / 24 = **70,8 %** après, soit **+ 33,3 points**.

2. Littératie des personnes : les personnes âgées comprennent mieux et savent mieux expliquer les conseils d'enrichissement. Littératie organisationnelle : le service forme son personnel et change ses pratiques de communication, ce qui rend l'information plus accessible pour toutes les personnes accompagnées.

3. Observation par une responsable, qui peut modifier le comportement des aides pendant la visite (elles savent qu'on les observe) ; mesure juste après la formation, sans recul sur la durée ; pas de groupe témoin ; petit effectif.

4. Un temps d'échange de 15 minutes lors des réunions d'équipe mensuelles pour partager des situations ; une fiche aide-mémoire « 3 conseils, 1 question de faire dire » dans le classeur de chaque domicile ; une nouvelle observation six mois plus tard ; la formation des nouvelles aides à leur arrivée.

5.4 Approfondissements

5.4.1 La littératie numérique en santé (e-santé)

La **littératie numérique en santé** (*eHealth literacy*, Norman et Skinner, 2006) est la capacité à rechercher, trouver, comprendre et évaluer l'information de santé en ligne et à l'utiliser. Elle combine six littératies : traditionnelle, en santé, informationnelle, scientifique, médiatique et informatique. Avec la dématérialisation des démarches (Mon espace santé, prise de rendez-vous, inscriptions aux ateliers), les personnes en situation d'**illectronisme** risquent d'être exclues : les **Conseillers numériques** et les **espaces France Services** peuvent être des partenaires d'une action de santé publique.

Méthode pas à pas – Juger la fiabilité d'une information de santé en ligne : 6 questions

1. Qui est l'auteur ? Est-il identifié, compétent (professionnel de santé, institution) ?

2. Quel est l'objectif : informer ou vendre ?

3. D'où viennent les informations : sources citées, études, recommandations officielles ?

4. Quand le contenu a-t-il été publié ou mis à jour ?

5. Le contenu est-il **cohérent** avec les repères officiels (Santé publique France, ANSES, HAS) ?

6. Promet-il des **résultats miraculeux**, rapides, sans effort ? (signal d'alerte).

Mesurer la littératie numérique en santé : l'échelle eHEALS

Norman et Skinner (2006) ont proposé une échelle courte, l'**eHEALS** (*eHealth Literacy Scale*), traduite et validée en français. Elle comporte **8 affirmations** sur la capacité à trouver, utiliser et juger l'information de santé sur internet. La personne répond pour chacune sur une échelle de 1 (« pas du tout d'accord ») à 5 (« tout à fait d'accord »). Le **score total** va donc de **8 à 40** : plus il est élevé, plus la personne se sent capable d'utiliser l'information de santé en ligne.

N°	Idée de l'affirmation (formulation simplifiée)	Compétence
1	Je sais quelles ressources de santé existent sur internet.	Accéder
2	Je sais où trouver sur internet des ressources utiles.	Accéder
3	Je sais comment trouver ces ressources.	Accéder
4	Je sais utiliser internet pour répondre à mes questions de santé.	Comprendre
5	Je sais utiliser l'information trouvée pour m'aider.	Appliquer
6	J'ai les compétences pour évaluer les ressources trouvées.	Évaluer
7	Je sais distinguer les ressources de bonne et de mauvaise qualité.	Évaluer
8	Je me sens en confiance pour utiliser l'information d'internet pour décider.	Appliquer

Attention – Une mesure déclarative, pas un test

L'eHEALS mesure ce que la personne **pense** savoir faire, pas ce qu'elle sait réellement faire. Une personne très confiante peut se tromper sur la fiabilité d'un site. Il n'existe pas de seuil officiel en France : dans un projet, on utilise surtout l'échelle pour **comparer** un groupe avant et après une action, en toute

confidentialité et avec l'accord des participants.

Exemple – Le score de M. B. et l'évaluation d'un atelier

M. B., 62 ans, répond 4, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Son score est 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 = **22 sur 40**, soit une moyenne de 22 / 8 = **2,75** par affirmation. Ses réponses sont les plus basses pour l'utilisation et l'évaluation (affirmations 4 à 8) : il sait que des ressources existent, mais il ne sait pas juger leur qualité.

Huit participants d'un atelier « Bien s'informer sur l'alimentation » à l'espace France Services remplissent l'échelle avant et un mois après l'atelier (données fictives).

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8
Avant	18	22	25	30	16	27	21	24
Après	24	26	29	32	22	30	25	28
Progression	+ 6	+ 4	+ 4	+ 2	+ 6	+ 3	+ 4	+ 4

Moyenne avant : 183 / 8 = **22,875**, soit environ 22,9. Moyenne après : 216 / 8 = **27**. Progression moyenne : **+ 4,1 points**. Six participants sur huit gagnent au moins 4 points. Ce résultat est encourageant, mais l'effectif est très petit et il n'y a pas de groupe de comparaison : on parle d'une **évolution observée**, pas d'une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.38

Trois personnes ont rempli l'eHEALS au début d'un atelier.

- Awa : 5, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4.
- Gérard : 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1.
- Inès : 4, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 3.

1. Calculez le score de chacune.

2. Pour Inès, repérez les affirmations les plus basses et la compétence correspondante.

3. Proposez une adaptation de l'atelier pour Gérard, sans le mettre à l'écart du groupe.

Corrigé – Exercice d'application 5.39

1. Awa : 31 sur 40 ; Gérard : 12 sur 40 ; Inès : 29 sur 40.

2. Inès répond 2, 2 et 3 aux affirmations 6, 7 et 8 : elle trouve facilement l'information, mais se sent peu capable de l'**évaluer** et de l'utiliser pour décider. L'atelier doit insister sur les six questions de fiabilité.

3. Gérard se sent peu à l'aise dès l'accès à internet. On peut former des binômes (Gérard avec Awa par exemple), partir de son propre téléphone, montrer un seul site fiable (manger-bouger.fr) enregistré en favori et lui proposer un rendez-vous avec le conseiller numérique, sans souligner son score devant les autres.

5.4.2 La médiation en santé et l'interprétariat

La **médiation en santé** est reconnue par la loi de modernisation de notre système de santé (2016, article L. 1110-13 du Code de la santé publique) et encadrée par un référentiel de la HAS (2017) : un médiateur fait le **lien** entre des publics éloignés et les professionnels, facilite l'accès aux droits et aux soins et aide les professionnels à adapter leurs pratiques. L'**interprétariat linguistique** professionnel dans le domaine de la santé fait l'objet d'un autre référentiel de la HAS (2017). Dans un projet en quartier prioritaire, s'appuyer sur un médiateur ou des **habitants relais** est souvent plus efficace que la traduction d'une affiche.

Médiateur, interprète, habitant relais : qui fait quoi ?

Ces trois intervenants sont souvent confondus (la conduite d'un entretien avec un interprète est détaillée en 5.3.11). Ils sont pourtant complémentaires, et le diététicien doit savoir lequel solliciter selon le besoin.

	Médiateur en santé	Interprète professionnel	Habitant relais (ou pair)
Rôle principal	Faire le lien entre le public et les services ; faciliter l'accès aux droits et aux soins	Traduire fidèlement les propos, dans les deux sens	Informer, mobiliser et accompagner ses voisins ou sa communauté
Formation	Formation spécifique (référentiel HAS 2017)	Formation à l'interprétariat et à la déontologie (neutralité, secret)	Formation courte, souvent par la structure
Statut	Salarié d'une association, d'une collectivité, d'un hôpital	Professionnel, sur place, par téléphone ou par vidéo	Bénévole ou indemnisé
Exemple dans un projet alimentaire	Accompagner des familles vers le centre social et l'épicerie solidaire	Permettre un entretien individuel avec une mère qui parle tamoul	Inviter les voisines à l'atelier et traduire les idées clés de façon informelle
Limite	Ne remplace pas les professionnels de santé	Ne donne pas son avis, ne conseille pas	Ne doit pas traduire des informations médicales individuelles ou confidentielles

En France, le **Programme national de médiation sanitaire**, lancé en 2011 pour les personnes vivant en habitat précaire (bidonvilles, squats), a montré que la présence régulière de médiateurs améliore l'ouverture des droits, la vaccination et le suivi des grossesses. La médiation en santé se développe aussi dans les quartiers prioritaires (adultes-relais, ateliers santé ville).

Méthode pas à pas – Travailler avec un médiateur dans un projet

1. L'associer dès le diagnostic : il connaît les habitudes, les freins et les lieux fréquentés par le public.

2. Définir ensemble les rôles : qui invite, qui anime, qui traduit, qui fait le lien avec les familles après l'atelier.

3. Partager les messages clés : le diététicien vérifie l'exactitude, le médiateur vérifie que les mots et les exemples conviennent au public.

4. Préparer la séance ensemble : supports, exemples d'aliments, moments de reformulation.

5. Faire le bilan à deux : ce qui a été compris, ce qui a surpris, ce qu'il faut changer.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.40

Pour chaque besoin, indiquez l'intervenant le plus adapté (médiateur, interprète professionnel, habitant relais) et justifiez.

a) Mme R., qui ne parle que le bengali, vient pour un entretien sur l'alimentation de son enfant diabétique.

b) Le centre social veut faire connaître un nouvel atelier cuisine aux familles d'un immeuble.

c) Des familles vivant dans un campement ne connaissent pas leurs droits à la complémentaire santé solidaire ni l'épicerie solidaire.

d) Un atelier collectif réunit des femmes qui parlent arabe et qui comprennent un peu le français ; une participante bilingue propose son aide.

Corrigé – Exercice d'application 5.41

a) **Interprète professionnel** : il s'agit d'informations de santé individuelles et confidentielles, qui demandent une traduction fidèle et neutre ; on évite de faire traduire par un enfant ou un proche.

b) **Habitant relais** : il connaît les familles, inspire confiance et mobilise par le bouche-à-oreille.

c) **Médiateur en santé** : il fait le lien avec les services, accompagne l'ouverture des droits et oriente vers

l'épicerie solidaire.

d) **Habitant relais** (la participante bilingue) pour les consignes et les idées générales d'un atelier collectif, à condition de lui demander son accord, de ne pas lui confier de questions personnelles et de vérifier la compréhension de toutes avec des images et le « faire dire ».

5.4.3 Les organisations « amies de la littératie »

Agir sur la littératie, ce n'est pas seulement former les personnes : c'est aussi **simplifier l'environnement**. Une structure « littératie-amicale » (*health literate organization*, Brach et coll., 2012) : forme son personnel, associe les usagers à la conception des documents, rend les lieux faciles à trouver (signalétique, pictogrammes), simplifie les formulaires et propose de l'aide, communique clairement les coûts, vérifie la compréhension. Le diététicien peut proposer à un centre social, à une cuisine centrale ou à une épicerie solidaire un **audit** simple de ses supports (fiche-outil O5.3).

Les dix caractéristiques d'une organisation « amie de la littératie »

Brach et ses collègues (2012, *Institute of Medicine*, États-Unis) décrivent **dix caractéristiques** d'une organisation de santé qui facilite la vie des personnes ayant une littératie limitée. Elles s'adaptent facilement à un centre social, une épicerie solidaire, un service de restauration ou une association.

N°	Caractéristique (formulation adaptée)	Exemple dans une épicerie solidaire
1	La direction fait de la littératie une priorité.	Le projet associatif mentionne l'accessibilité des informations.
2	La littératie est intégrée à la planification et à l'évaluation.	Un indicateur « compréhension » figure dans le bilan annuel.
3	Le personnel est formé.	Les bénévoles ont suivi une formation « communiquer pour tous ».
4	Le public participe à la conception des supports.	Les affiches sont testées auprès de bénéficiaires.
5	L'organisation répond à des niveaux de compétences variés, sans stigmatiser.	Les informations existent à l'écrit, en images et à l'oral.
6	La communication orale est claire et la compréhension est vérifiée.	Les bénévoles pratiquent le « faire dire » à l'accueil.
7	L'accès à l'information et l'orientation sont faciles.	Signalétique avec pictogrammes, plan affiché, horaires clairs.
8	Les documents écrits, audiovisuels et numériques sont faciles à comprendre et à utiliser.	Fiches recettes en écriture claire, avec photos.
9	La littératie est prise en compte dans les situations à risque.	Information claire sur les allergènes et les dates de consommation.
10	Les coûts et les droits sont expliqués clairement.	Le prix restant à payer par la famille est affiché simplement.

Méthode pas à pas – Réaliser un audit rapide avec une grille à 3 niveaux

1. Noter chaque caractéristique : 0 = absent ; 1 = partiel ; 2 = en place. Le total est sur 20.

2. Croiser les regards : remplir la grille avec l'équipe et avec deux ou trois usagers, puis comparer.

3. Exprimer le résultat en pourcentage du maximum, pour suivre l'évolution d'une année sur l'autre.

4. Choisir deux ou trois priorités : les caractéristiques notées 0, en commençant par celles qui sont faciles à améliorer et utiles au public.

5. Fixer une date pour refaire l'audit (par exemple dans un an).

Exemple – L'audit de l'épicerie solidaire « Le Panier partagé » (données fictives)

Notes obtenues pour les caractéristiques 1 à 10 : 2, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2. Total : **11 sur 20**, soit 11 / 20 × 100 = **55 %**.

Les deux caractéristiques notées 0 sont la formation des bénévoles (3) et la qualité des documents (8). L'équipe retient deux priorités : une formation de deux heures pour les bénévoles et la réécriture des cinq fiches recettes en écriture claire, testées auprès de six bénéficiaires.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.42

La cuisine centrale d'une ville obtient les notes suivantes pour les caractéristiques 1 à 10 : 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 0 (données fictives).

1. Calculez le total et le pourcentage.
2. Identifiez les caractéristiques absentes.
3. Choisissez deux priorités et proposez pour chacune une action concrète liée aux menus ou à l'information des familles.

Corrigé – Exercice d'application 5.43

1. Total : 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 0 = **8 sur 20**, soit **40 %**.
2. Caractéristiques notées 0 : la littératie dans la planification et l'évaluation (2), la formation du personnel (3), la participation du public (4), la clarté des coûts (10).
3. Exemples : **participation du public (4)** : tester le nouvel affichage des menus et des allergènes auprès de 10 parents et d'une classe d'élèves avant de le diffuser ; **coûts (10)** : présenter le tarif de la cantine selon le quotient familial dans un tableau simple, avec un exemple chiffré et le contact d'une personne qui aide à faire la démarche. D'autres choix sont possibles s'ils sont justifiés.

5.4.4 La littératie en santé des professionnels et des organisations

La littératie n'est pas seulement l'affaire du public : les **professionnels** doivent être formés à communiquer clairement, et les **organisations** à réduire la complexité de leurs démarches (5.4.3). En France, la stratégie nationale de santé et plusieurs plans régionaux intègrent désormais la littératie en santé ; des formations courtes (« communiquer pour tous », faire dire, FALC) sont proposées par les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé. Pour un diététicien, c'est une compétence transversale, utile en consultation (BC1), en restauration (BC2 : menus, affichage des allergènes) et en santé publique.

Former une équipe à communiquer clairement : un exemple

Former les professionnels est l'une des actions les plus rentables : une seule formation améliore ensuite des centaines d'échanges avec le public. Le diététicien peut concevoir et animer une courte formation pour une équipe d'animateurs, d'agents de restauration ou de bénévoles.

Exemple – Deux demi-journées pour l'équipe d'un centre social (données fictives)

Public : 14 animateurs et bénévoles du centre social. **Durée** : deux séances de 3 heures.

Objectifs : à la fin de la formation, les participants seront capables de réécrire une consigne en écriture claire, de pratiquer le « faire dire » et de repérer trois signaux possibles de difficulté de lecture, sans stigmatiser.

Séance	Contenu	Méthode
1	Qu'est-ce que la littératie ? Les chiffres de HLS19 ; les précautions universelles	Photolangage, quiz à main levée

Séance	Contenu	Méthode
1	Les règles d'écriture claire	Réécriture en binômes de trois documents du centre
2	Le « faire dire » et l'accueil	Jeux de rôle filmés avec l'accord des participants
2	Plan d'action de l'équipe	Chaque binôme choisit un support à améliorer dans le mois

Évaluation : un quiz de 10 questions est proposé avant et après la formation.

Agent	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Avant	4	6	5	3	7	5	6	4	5	6	3	5	7	6
Après	8	8	7	7	9	8	8	7	8	9	6	8	9	8

Moyenne avant : 72 / 14 = **5,1 sur 10** ; moyenne après : 110 / 14 = **7,9 sur 10** ; progression moyenne : **+ 2,7 points**. Après la formation, 10 agents sur 14, soit **71,4 %**, obtiennent au moins 8 sur 10.

Coût : intervention du diététicien 2 × 3 h × 45 € = 270 € ; pause et documents 14 × 2 × 3,50 € = 98 € ; total **368 €**, soit **26,29 €** par participant.

Attention – Évaluer la pratique, pas seulement les connaissances

Un bon score au quiz ne prouve pas que les pratiques changent. Pour aller plus loin, on observe quelques accueils (avec l'accord des agents), on compte les supports réécrits trois mois plus tard ou on interroge les usagers sur la clarté des informations reçues. On retrouve les niveaux d'évaluation des connaissances, des pratiques et des résultats pour le public (chapitre 9).

À vous de jouer – Exercice d'application 5.44

Le service de restauration d'un EHPAD vous demande une formation d'une séance de 2 heures pour 9 agents qui servent les repas et présentent les menus aux résidents.

1. Formulez deux objectifs pédagogiques.
2. Proposez le déroulé de la séance en trois temps, avec une méthode active pour chacun.
3. Calculez le coût si votre intervention est facturée 45 € de l'heure et si les documents coûtent 2 € par agent.
4. Proposez un indicateur de pratique à mesurer un mois plus tard.

Corrigé – Exercice d'application 5.45

1. Exemples : « présenter oralement le menu du jour en phrases courtes, en montrant le plat » ; « vérifier par le "faire dire" qu'un résident a compris le choix proposé ».
2. Exemple : 20 minutes de mise en situation (un agent présente un menu écrit en jargon, les autres jouent les résidents) puis échange ; 50 minutes d'atelier de réécriture des menus en mots simples avec photos ; 50 minutes de jeux de rôle sur la présentation du menu et le « faire dire », en tenant compte des troubles de l'audition et de la vue.
3. 2 × 45 = 90 € ; 9 × 2 = 18 € ; total **108 €**, soit **12 €** par agent.
4. Exemple : part des repas observés où le menu est présenté oralement avec le plat montré (observation de 20 services) ; ou nombre de menus réécrits et affichés en gros caractères.

5.4.5 L'intelligence artificielle et la simplification des textes

Les outils d'intelligence artificielle générative peuvent aider à **simplifier** un texte, proposer des versions dans d'autres langues ou générer des idées d'images ; ils peuvent aussi introduire des **erreurs** (« hallucinations »), des simplifications abusives ou des traductions inexactes. Leur usage professionnel suppose : de ne pas y saisir de données personnelles ou de santé (RGPD, chapitre 6) ; de **vérifier** chaque information auprès des sources officielles ; de faire **relire** par une personne compétente (et par le public pour le FALC) ; d'assumer la responsabilité du contenu diffusé. La compétence C3.3 du référentiel mentionne explicitement la connaissance des enjeux de l'IA.

Utiliser une IA pour simplifier un texte : une méthode prudente

Les règles juridiques et la sécurité des données sont traitées au chapitre 20. Ici, on s'intéresse à la question de la littératie : comment une intelligence artificielle peut **aider** à rendre un texte plus clair sans **dégrader** l'information.

Méthode pas à pas – Simplifier un texte avec une IA en cinq étapes

1. Préparer un texte source exact, déjà validé, sans aucune donnée personnelle (pas de nom, pas de situation de santé individuelle).

2. Donner une consigne précise : le public visé, le niveau de langue, la longueur, les règles d'écriture claire, les mots à conserver (« légumes secs », « Nutri-Score »).

3. Comparer phrase par phrase le texte produit avec le texte source : chaque chiffre, chaque repère et chaque conseil doit être identique ou équivalent.

4. Vérifier les repères auprès des sources officielles datées (Santé publique France, ANSES, HAS) et noter la date de vérification.

5. Tester le texte final auprès de quelques personnes du public (entretien cognitif, 5.3.12) ; pour un texte FALC, la relecture par des personnes en situation de handicap intellectuel reste obligatoire.

Attention – Les erreurs typiques d'une simplification automatique

- **Chiffre modifié** : une quantité, une fréquence ou une unité change (« par semaine » devient « par jour »).
- **Nuance supprimée** : « limiter » devient « supprimer », « au moins » disparaît.
- **Conseil inventé** : une recommandation qui n'existait pas dans le texte source apparaît.
- **Source inventée** : une étude ou un organisme cité n'existe pas.
- **Ton infantilisant** : simplifier ne veut pas dire parler à un adulte comme à un enfant.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.46

Une collègue a demandé à une IA de simplifier un texte sur les repères alimentaires de Santé publique France (2019). Voici le résultat. Repérez les erreurs et corrigez-les.

« Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Les jus de fruits comptent : vous pouvez boire 5 verres de jus pour remplacer les fruits. Mangez des légumes secs (lentilles, pois chiches) une fois par mois. Ne mangez plus jamais de charcuterie. Une étude de l'université de Lyon de 2023 montre que le pain complet fait maigrir. »

Corrigé – Exercice d'application 5.47

- « Au moins 5 fruits et légumes par jour » : **correct**.
- Les jus : **erreur**. Le repère conseille de ne pas boire plus d'un petit verre de jus de fruits par jour ; les jus ne remplacent pas les fruits entiers.
- Légumes secs : **erreur de fréquence**. Le repère est **au moins deux fois par semaine**.
- Charcuterie : **nuance supprimée**. Le repère est de **limiter** la charcuterie à **150 g par semaine**, pas de

l'interdire.

- L'étude citée : **source invérifiable**, probablement inventée ; le texte source ne la contenait pas. On la supprime.

Conclusion : le texte simplifié contient quatre erreurs sur cinq phrases. Il ne doit pas être diffusé sans une vérification complète, phrase par phrase.

5.4.6 Développer la littératie alimentaire des enfants à l'école

L'école est un lieu privilégié pour développer la littératie alimentaire dès l'enfance, car elle touche tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Le **parcours éducatif de santé** (circulaire du 28 janvier 2016) organise, de la maternelle au lycée, trois axes : l'éducation à la santé, la prévention et la protection de la santé. L'éducation à l'alimentation et au goût y a toute sa place. L'éducation sensorielle (classes du goût) est présentée aux chapitres 1 et 11 ; on s'intéresse ici aux compétences de **lecture**, de **calcul** et d'**esprit critique** liées à l'alimentation.

Âge	Compétences de littératie alimentaire à développer	Exemple d'activité
Maternelle	Nommer les aliments, les classer, reconnaître des familles	Jeu de tri avec de vrais aliments et des photos
Élémentaire (CP-CM2)	Lire une liste d'ingrédients simple, repérer le sucre, comparer deux produits	Poser les morceaux de sucre à côté de l'emballage
Collège	Lire le tableau nutritionnel, calculer pour une portion, analyser une publicité	Comparer deux céréales, décoder une publicité en ligne
Lycée	Juger une information en ligne, débattre d'un sujet (influenceurs, régimes)	Enquête sur la fiabilité de trois vidéos

Exemple – Une séance « Le sucre caché » en CM1 (données fictives)

Une classe de CM1 compte 26 élèves. Avant la séance, 9 élèves savent montrer où se trouve le sucre sur un emballage, soit 9 / 26 = **34,6 %**. La diététicienne apporte un yaourt aromatisé de 125 g qui contient 13 g de sucres pour 100 g : 13 × 1,25 = **16,25 g** de sucres, soit environ **3 morceaux** de 5 g (3,25 exactement). Les élèves posent les morceaux à côté du pot, puis cherchent l'information sur trois autres emballages en binômes. Une semaine plus tard, l'enseignante refait le test : 21 élèves sur 26 réussissent, soit **80,8 %**.

La séance respecte les règles de la littératie : objets réels, consignes courtes, travail à deux, vérification par le « faire dire », aucun aliment présenté comme « interdit ». Un mot simple est remis aux parents avec l'activité à refaire à la maison.

Attention – Ne pas culpabiliser les enfants ni leurs familles

Un enfant n'est pas responsable des achats de sa famille. Les messages doivent rester positifs (« on peut choisir », « on peut goûter »), éviter les aliments « bons » ou « mauvais » et ne jamais commenter le contenu d'un goûter apporté de la maison devant la classe. Associer les parents (réunion, atelier parents-enfants) renforce l'action et évite le conflit de loyauté.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.48

Un collège vous demande une séance de 55 minutes pour une classe de 5e sur les boissons.

1. Formulez un objectif de littératie fonctionnelle et un objectif de littératie critique.
2. Une boisson aux fruits de 33 cL contient 9 g de sucres pour 100 mL. Calculez la quantité de sucres et le nombre de morceaux de 5 g.

3. Proposez le déroulé de la séance en trois temps.
4. Proposez une action pour associer les familles.

Corrigé – Exercice d'application 5.49

1. Fonctionnel : « trouver sur l'étiquette la quantité de sucres pour 100 mL et la calculer pour la bouteille ». Critique : « repérer dans une publicité les techniques utilisées pour donner envie d'acheter une boisson ».
2. 9 × 3,3 = **29,7 g** de sucres, soit environ **6 morceaux** de 5 g (5,94).
3. Exemple : 15 minutes de lecture d'étiquettes en binômes (quatre boissons, calcul pour la bouteille, morceaux de sucre posés à côté) ; 25 minutes d'analyse de deux publicités en petits groupes (qui parle, pour quoi faire, quelles images, quelles preuves) ; 15 minutes de mise en commun et de « faire dire » : chaque groupe énonce une chose qu'il retient.
4. Exemple : les élèves conçoivent eux-mêmes une affiche ou une courte vidéo pour les parents, présentée à la réunion parents-professeurs ; un message court et traduit si besoin est envoyé par l'application de l'établissement.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 5.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien d'affirmations compte l'échelle eHEALS, et entre quelles valeurs varie son score ?
2. Quelle est la différence principale entre un médiateur en santé et un interprète professionnel ?
3. Citez quatre des dix caractéristiques d'une organisation « amie de la littératie ».
4. Une grille d'audit donne 13 sur 20. Exprimez ce résultat en pourcentage.
5. Citez trois erreurs typiques d'un texte simplifié par une IA.
6. Pourquoi faut-il éviter de commenter le goûter d'un enfant devant la classe ?

Corrigé – Point d'étape 5.4

1. 8 affirmations notées de 1 à 5 ; score de 8 à 40.
2. Le médiateur fait le lien entre le public et les services et facilite l'accès aux droits ; l'interprète traduit fidèlement et de façon neutre, sans conseiller.
3. Direction engagée ; littératie dans la planification et l'évaluation ; personnel formé ; participation du public ; réponse à des niveaux variés sans stigmatiser ; communication orale claire et vérifiée ; orientation facile ; documents faciles à comprendre ; situations à risque ; coûts expliqués clairement.
4. 13 / 20 × 100 = 65 %.
5. Chiffre modifié ; nuance supprimée ; conseil inventé ; source inventée ; ton infantilisant.
6. L'enfant n'est pas responsable des achats de sa famille ; le commentaire le stigmatise et crée un conflit de loyauté entre l'école et la famille.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie « Pour aller plus loin ».
3 ou 4 sur 6	Je relis les méthodes et les exemples de la partie 5.4.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 5.4 et je refais les exercices d'application.

5.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer la littératie en santé

Plusieurs instruments existent : **HLS-EU-Q47** et ses versions courtes (Q16, Q12 du HLS19), fondés sur l'autoévaluation des difficultés ; tests de performance comme le **NVS** (*Newest Vital Sign*, Weiss et coll., 2005), qui demande de lire une étiquette de crème glacée et de répondre à 6 questions (calculs de portions, d'énergie, d'allergènes) ; le **HLQ** (*Health Literacy Questionnaire*, Osborne et coll., 2013), à 9 dimensions, conçu pour orienter les interventions (démarche **Ophelia**). Les mesures autodéclarées et les tests de performance ne mesurent pas la même chose ; en pratique de terrain, on ne « teste » pas le public, on applique les précautions universelles.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie critique et capacité d'agir collective

Nutbeam (2008) oppose deux conceptions : la littératie comme **facteur de risque** (à repérer et à compenser dans les soins) et la littératie comme **atout** (*asset*) à développer par l'éducation, qui renforce le pouvoir d'agir des personnes et des communautés. Cette seconde conception rejoint la Charte d'Ottawa et la pédagogie de Paulo Freire (*Pédagogie des opprimés*, 1968) : apprendre à « lire le monde » pour le transformer. Dans un projet alimentaire, elle peut conduire un groupe d'habitants à interpeller la mairie sur l'offre de fruits et légumes de leur quartier.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie et intelligence artificielle générative

Les outils d'intelligence artificielle générative (agents conversationnels) sont désormais utilisés par une partie du public pour s'informer sur l'alimentation et la santé. Ils peuvent simplifier un texte, mais produisent parfois des informations inexactes présentées avec assurance. La littératie **critique** inclut désormais la capacité à vérifier une réponse générée par une IA auprès de sources officielles ; le professionnel reste responsable des contenus qu'il diffuse.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La numératie et la perception des risques

Les recherches de Gerd Gigerenzer (Institut Max Planck, Berlin) montrent que de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé, interprètent mal les probabilités conditionnelles et les risques relatifs, alors qu'elles comprennent bien les **fréquences naturelles**. Exemple : « Sur 1 000 personnes, 10 ont la maladie ; le test est positif chez 9 d'entre elles et chez 99 des 990 non-malades » permet de calculer facilement que, parmi les 9 + 99 = 108 tests positifs, seuls 9 / 108 = **8,3 %** correspondent à une maladie réelle, alors que la même information exprimée en pourcentages (prévalence 1 %, sensibilité 90 %, taux de faux positifs 10 %) induit souvent des réponses de l'ordre de 90 %. Ces travaux fondent l'usage des fréquences naturelles et des tableaux d'icônes dans la communication en santé.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La littératie en santé, priorité internationale

La **Déclaration de Shanghai** (OMS, 2016), présentée au chapitre 1 avec les autres grandes conférences de promotion de la santé, fait de la littératie en santé l'un de ses **trois piliers**, avec la bonne gouvernance et les villes-santé. Le rapport du bureau régional de l'OMS pour l'Europe *Health literacy: the solid facts* (Kickbusch, Pelikan, Apfel et Tsouros, 2013) synthétise les données européennes et recommande d'agir à la fois sur les **compétences** des personnes et sur la **complexité** des systèmes. En France, la littératie en santé est inscrite dans la stratégie nationale de santé et dans plusieurs projets régionaux de santé ; l'action du diététicien s'inscrit donc dans des orientations publiques identifiables, qu'il peut citer pour justifier un projet.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La « réactivité » des organisations à la littératie

Le concept de *health literacy responsiveness* (Trezona, Dodson et Osborne, 2017) déplace la question : il ne s'agit plus seulement de savoir si une personne a une littératie suffisante, mais si une **organisation** est capable de s'adapter aux besoins de littératie de tous ses usagers. Le cadre décrit plusieurs domaines (engagement de la direction, systèmes et procédures, communication, compétences du personnel, environnement physique, partenariats). Il complète les dix caractéristiques de Brach (2012) et permet de construire des indicateurs d'évaluation au niveau de la structure, et pas uniquement au niveau des participants.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Littératie, numératie et choix alimentaires : ce que montre la recherche

Plusieurs études observent que les personnes ayant une numératie limitée utilisent moins le tableau nutritionnel, se trompent davantage dans le calcul d'une portion et s'appuient plus sur les allégations de façade. Les logos simples et colorés, comme le Nutri-Score, ont été conçus en partie pour réduire cet écart : les essais menés en France (équipe EREN, Hercberg et Julia) ont montré qu'ils sont mieux compris que des repères chiffrés, y compris par les personnes les moins diplômées. La recherche conclut cependant qu'un logo ne suffit pas : l'environnement (prix, offre, publicité) pèse plus lourd que la compréhension seule sur les achats.

5.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et compréhension

Un patient diabétique de type 2 repart d'une consultation avec un plan alimentaire de 4 pages. Le diététicien réduit à 3 messages prioritaires, utilise l'assiette modèle et des photos de portions, pratique le « faire dire » et remet un support d'une page.

Situation bc2 – Les menus affichés

En restauration collective, le diététicien conçoit un affichage des menus avec pictogrammes (plat végétarien, allergènes, fait maison), lisible par les enfants et par les familles qui maîtrisent peu le français.

Situation bc3 – Atelier « lire une étiquette » à l'épicerie solidaire

Le diététicien anime un atelier avec de vrais emballages : comparaison de deux céréales par le Nutri-Score, repérage du sucre dans la liste d'ingrédients, jeu de tri ; les consignes sont orales et imagées, et l'atelier se termine par un « faire dire ».

Situation bc3 – Une campagne municipale accessible

Une ville prépare une campagne sur les boissons sucrées. Le diététicien propose de tester les affiches auprès de collégiens et de parents, de produire une version FALC et une vidéo sous-titrée, et de relayer par les associations de quartier.

Situation bc2 – Affichage des allergènes

Le diététicien d'une cuisine centrale conçoit un affichage des 14 allergènes par pictogrammes et couleurs, compréhensible par les enfants, les familles allophones et les agents, et le teste auprès de 10 parents.

Situation bc3 – Une campagne « sucres cachés »

Pour une campagne dans des collèges, le diététicien remplace les grammes par des morceaux de sucre réels, présente les risques en fréquences naturelles et fait concevoir les affiches par des élèves.

Méthode 1 – Justifier à l'oral E5 la prise en compte de la littératie dans un projet

À l'oral, le jury demande souvent : « Comment avez-vous adapté votre action à votre public ? » Une réponse vague (« j'ai fait simple ») ne montre pas la compétence. Une réponse structurée en quatre temps, appuyée sur des faits, est beaucoup plus convaincante.

Méthode pas à pas – Répondre en 2 minutes avec la structure « constat, choix, vérification, limite »

1. Le constat (20 secondes) : ce que vous saviez du public, avec une source datée (données HLS19, diagnostic, entretien avec la structure). Exemple : « la référente familles m'a indiqué que la moitié des participantes lisent difficilement le français ».

2. Les choix (50 secondes) : deux ou trois adaptations précises, chacune reliée au constat (supports imagés, consignes orales, vrais aliments, horaires, mode d'inscription).

3. La vérification (30 secondes) : comment vous avez vérifié la compréhension (test du support, « faire dire », indice de lisibilité avant et après, retour des participants).

4. La limite et l'amélioration (20 secondes) : ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous changeriez. Le jury apprécie un regard critique honnête.

Exemple – Une réponse structurée (projet fictif)

« **Constat** : l'atelier s'adressait à des résidents d'un foyer de travailleurs migrants ; le directeur m'a indiqué que beaucoup parlent un peu le français mais le lisent peu, et l'enquête HLS19 montre que la littératie limitée est plus fréquente chez les personnes peu diplômées.

Choix : j'ai remplacé la fiche recette écrite par une fiche en six photos numérotées ; j'ai fait les consignes à l'oral en montrant les gestes ; j'ai utilisé des boîtes de conserve réelles pour la lecture des étiquettes, en me limitant au sel.

Vérification : j'ai testé la fiche auprès de trois résidents la semaine précédente, ce qui m'a fait changer deux photos ; en fin d'atelier, chaque participant a montré la boîte la moins salée et expliqué pourquoi.

Limite : deux résidents ne parlaient que le soninké ; la prochaine fois, je prévoirai un résident relais pour la traduction des consignes. »

Attention – Les phrases à éviter devant le jury

- « Mon public avait un faible niveau » : formulation stigmatisante. Préférez « certains participants lisaient difficilement le français ».
- « J'ai testé leur niveau de lecture » : contraire aux précautions universelles, sauf démarche de recherche encadrée et consentie.
- « Le support était adapté » sans preuve : citez un test, un indice ou un retour du public.
- « J'ai traduit avec Google Traduction » sans vérification : un outil automatique ne remplace pas la relecture par une personne qui maîtrise la langue.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.50

Vous avez animé un atelier « petit-déjeuner » dans une école maternelle avec des parents dont plusieurs maîtrisent peu le français écrit. Rédigez votre réponse orale à la question « Comment avez-vous adapté votre action ? » en suivant les quatre temps (environ 10 lignes).

Corrigé – Exercice d'application 5.51

Exemple de réponse : « **Constat** : la directrice m'a signalé que plusieurs parents parlent arabe, turc ou tamoul et lisent peu le français ; les invitations écrites précédentes avaient eu peu de retours. **Choix** : l'invitation a été remise en main propre par les enseignantes, avec un dessin et l'heure en gros chiffres ; pendant l'atelier, j'ai montré de vrais aliments et une assiette modèle, et j'ai limité le message à trois idées ; une maman bilingue a accepté de reformuler les consignes. **Vérification** : à la fin, chaque parent a composé un petit-déjeuner avec les aliments posés sur la table et l'a expliqué à son voisin ; 11 parents sur 13 ont composé un petit-déjeuner conforme aux trois idées. **Limite** : l'atelier avait lieu à 8 h 30, et les parents qui travaillent n'ont pas pu venir ; je proposerais une deuxième séance en fin de journée. »

Le corrigé n'est qu'un exemple : l'essentiel est que chaque adaptation réponde à un constat et que la compréhension soit vérifiée.

Méthode 2 – Analyser un support dans une question écrite de l'épreuve

Les sujets E5 présentent souvent un document (affiche, dépliant, page web, menu) et demandent : « Analysez ce support au regard de la littératie en santé et proposez des améliorations. » La méthode ci-dessous évite d'oublier des critères et donne une réponse organisée.

Méthode pas à pas – Analyser un support en cinq critères

1. Le public et l'objectif : à qui s'adresse le support, et que doit faire la personne après l'avoir lu ?

2. Le texte : longueur des phrases, mots difficiles, sigles, chiffres, formulations négatives ; si possible, un indice de lisibilité calculé sur un extrait.

3. La mise en page : taille des caractères, contraste, hiérarchie (titre, message principal), place des images, espaces.

4. Les images et les chiffres : images utiles ou décoratives, pictogrammes compréhensibles, chiffres présentés en fréquences ou en mesures ménagères.

5. L'accès et l'action : où le support est-il diffusé, existe-t-il en version orale, traduite ou numérique accessible ; l'action demandée est-elle possible (coût, lieu, horaires) ?

Pour chaque critère, on écrit **un point fort ou une faiblesse observée dans le document**, puis **une amélioration précise**. On termine par la manière de tester la nouvelle version auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 5.52

Une mairie distribue ce texte imprimé en police 9, en gris clair sur fond blanc, sans image : « Dans le cadre du PNNS et du PAT, la Ville organise, sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits, des ateliers nutritionnels non obligatoires visant l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation des ménages. Inscriptions exclusivement sur le portail citoyen avant le 15/03. »

Analysez ce support avec les cinq critères et proposez une nouvelle version.

Corrigé – Exercice d'application 5.53

1. Public et objectif : le public n'est pas nommé et l'action attendue (s'inscrire) arrive à la fin. Amélioration : commencer par l'invitation.

2. Texte : deux phrases longues, deux sigles (PNNS, PAT), une négation (« non obligatoires »), des mots abstraits (« qualité nutritionnelle de l'alimentation des ménages »). Amélioration : phrases courtes, mots courants, sigles supprimés.

3. Mise en page : police 9 et gris clair, contraste insuffisant. Amélioration : police d'au moins 12 à 14 points, texte noir ou très foncé, titre en gras.

4. Images : aucune. Amélioration : une photo d'un atelier ou d'un plat, un pictogramme pour la date et le lieu.

5. Accès et action : inscription uniquement en ligne, ce qui exclut une partie du public. Amélioration : inscription aussi par téléphone et à l'accueil de la mairie ou du centre social.

Nouvelle version : « Venez cuisiner avec nous ! Ateliers cuisine gratuits pour toute la famille. Où : centre social, 12 rue des Écoles. Quand : les mercredis de 14 h à 16 h. Pour vous inscrire : à l'accueil de la mairie, par téléphone au (numéro) ou sur le site de la ville. Avant le 15 mars. » La version est ensuite testée auprès de cinq habitants.

Méthode 3 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

À vous de jouer – Vrai ou faux commentés

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et justifiez en une phrase.

1. « La littératie en santé, c'est savoir lire. »
2. « Une personne diplômée a forcément une bonne littératie en santé. »
3. « Les précautions universelles consistent à communiquer clairement avec tout le monde. »
4. « Il faut demander aux participants leur niveau de lecture au début d'un atelier. »
5. « Un indice de Flesch élevé signifie que le texte est difficile. »
6. « Un bon indice de lisibilité suffit pour valider un support. »
7. « Le FALC peut être rédigé seul par un professionnel, sans relecture. »
8. « Demander "Avez-vous compris ?" permet de vérifier la compréhension. »
9. « Le "faire dire" teste la mémoire du patient. »
10. « Un risque qui passe de 2 sur 1 000 à 1 sur 1 000 diminue de 50 %. »
11. « Faire traduire un entretien de santé par l'enfant de la famille est une bonne solution. »
12. « Le Nutri-Score permet de comparer des produits d'une même catégorie. »
13. « Mettre tout le texte en majuscules le rend plus lisible. »
14. « La littératie critique permet d'agir collectivement sur son environnement. »
15. « Agir sur la littératie, c'est seulement former les personnes. »

Corrigé – Vrai ou faux commentés

1. **Faux.** Elle comprend l'accès, la compréhension, l'évaluation et l'application de l'information de santé (Sørensen, 2012), à l'écrit comme à l'oral et en ligne.
2. **Faux.** La littératie dépend aussi de la situation : une personne diplômée peut être en difficulté face à un diagnostic grave, au stress ou à un vocabulaire médical inhabituel.
3. **Vrai.** On ne peut pas savoir qui a des difficultés ; on adapte donc la communication pour tous, sans repérage stigmatisant.
4. **Faux.** C'est stigmatisant et contraire aux précautions universelles ; la honte peut éloigner les personnes de l'atelier.
5. **Faux.** C'est l'inverse : plus l'indice de Flesch (ou de Kandel et Moles) est élevé, plus le texte est facile à lire.

6. **Faux.** L'indice ne mesure ni le sens des mots, ni les images, ni la mise en page ; seul un test auprès du public montre la compréhension.
7. **Faux.** Les règles européennes du FALC prévoient la participation de personnes en situation de handicap intellectuel à la rédaction ou à la relecture.
8. **Faux.** La plupart des personnes répondent « oui » par politesse ou par gêne ; il faut demander de reformuler ou de montrer.
9. **Faux.** Il teste la **clarté des explications du professionnel** : si la personne ne sait pas reformuler, c'est l'explication qu'il faut reprendre.
10. **Vrai**, en risque relatif ; mais la diminution absolue n'est que de 1 sur 1 000. Il faut présenter les deux, de préférence en fréquences naturelles.
11. **Faux.** L'enfant n'a ni la neutralité ni le vocabulaire d'un interprète, et le rôle inverse sa place dans la famille ; on fait appel à un interprète professionnel.
12. **Vrai.** Il est surtout utile pour comparer des produits comparables (des céréales entre elles, par exemple) ; il ne dit pas s'il faut manger un aliment ni en quelle quantité.
13. **Faux.** Les majuscules ralentissent la lecture, car les mots perdent leur forme ; on les réserve à quelques mots courts.
14. **Vrai.** Selon Nutbeam, la littératie critique permet d'analyser l'information et d'agir, seul ou en groupe, sur les déterminants de la santé.
15. **Faux.** Il faut aussi simplifier l'environnement : documents, démarches, signalétique, formation des professionnels (organisations « amies de la littératie »).

Méthode 4 – Relier la littératie aux autres chapitres du cours

La littératie n'est pas une notion isolée : à l'épreuve, elle se combine presque toujours avec d'autres parties du programme. Le tableau ci-dessous aide à faire ces liens sans répéter les contenus.

Notion du chapitre 5	Lien avec	Ce que l'on mobilise
Gradient social de la littératie	Chapitre 2 (inégalités sociales de santé)	Universalisme proportionné, lentille inégalités
Précautions universelles, honte	Chapitre 3 (psychologie sociale)	Estime de soi, stigmatisation, influence des pairs
Littératie alimentaire	Chapitre 4 (pratiques alimentaires)	Stratégies des ménages modestes, cultures culinaires
Respect de la personne, interprétariat	Chapitre 6 (éthique)	Autonomie, consentement, secret
Littératie à chaque étape du projet	Chapitres 7 à 9 (démarche de projet)	Diagnostic participatif, objectifs, évaluation
Atelier accessible	Chapitre 10 (atelier culinaire)	Fiches recettes imagées, consignes orales
Supports écrits et numériques	Chapitres 14 et 15 (communication)	Choix du canal, conception graphique, accessibilité
Numératie, risques	Chapitre 16 (épidémiologie)	Risques relatifs et absolus, fréquences
Fiabilité de l'information	Chapitre 19 (veille et lecture critique)	Sources, niveau de preuve
IA, données, accessibilité numérique	Chapitre 20 (numérique en santé)	RGPD, responsabilité, outils

À vous de jouer – Exercice d'application 5.54

Un sujet E5 présente un projet de « défi cuisine » dans un quartier prioritaire, avec inscription en ligne et livret de recettes de 20 pages. Citez trois chapitres du cours que vous mobiliseriez en plus du chapitre 5 et

indiquez pour chacun l'idée principale.

Corrigé – Exercice d'application 5.55

Exemples : **chapitre 2**, l'inscription en ligne et le livret long risquent de creuser les inégalités, d'où des modalités adaptées aux habitants les plus éloignés ; **chapitre 7**, associer les habitants au diagnostic et à la conception du défi ; **chapitre 15**, transformer le livret en fiches recettes courtes et imagées, testées auprès du public ; **chapitre 10**, prévoir des recettes réalisables avec un petit équipement et un petit budget. Trois liens justifiés suffisent.

5.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Définitions et données

- **Littératie en santé** (Sørensen, 2012) : connaissances, motivation et compétences pour **accéder, comprendre, évaluer, appliquer** l'information, dans les domaines des **soins**, de la **prévention** et de la **promotion de la santé** (12 dimensions).
- **Niveaux** (Nutbeam, 2000) : **fonctionnel** (lire, comprendre), **interactif** (échanger), **critique** (juger, agir).
- **Littératie alimentaire** : planifier et gérer, sélectionner, préparer, manger (Vidgen et Gallegos, 2014).
- **France (HLS19, 2021)** : environ **44 %** des adultes ont une littératie limitée ; difficultés encore plus fréquentes en **numérique** ; **gradient social**.
- **Illettrisme** 7 % des 18-65 ans (ANLCI, 2011) ; **illectronisme** 7 % des 16-74 ans en 2025 (Insee, 2026) ; faible maîtrise de l'écrit 28 % des 16-65 ans (PIAAC 2023).
- Conséquences : moins de prévention, plus d'hospitalisations, moins bonne gestion des maladies chroniques ; **creusement des inégalités** si la communication n'est pas adaptée.

À retenir – Pratique professionnelle

- **Précautions universelles** : communiquer clairement avec tous, sans tester ni stigmatiser.
- **Écrire simple** : une idée par phrase, mots courants, forme active et positive, chiffres concrets, pictogrammes, mise en page aérée ; **FALC** ; tester les supports.
- **Lisibilité** : L = 207 − 1,015 × (mots/phrase) − 73,6 × (syllabes/mot).
- **Faire dire** (HAS, 2015) : expliquer → faire reformuler → vérifier → réexpliquer autrement → confirmer.
- **Plusieurs canaux** : oral, imagé, numérique accompagné, médiation, relais.

À retenir – Compléments : étiquettes, numératie, numérique, allophonie

- **Étiquette** (règlement INCO 1169/2011) : dénomination, ingrédients (ordre décroissant, 14 allergènes), Nutri-Score (comparer dans une même famille ; algorithme révisé), tableau pour 100 g et par portion, dates, prix au kilo.
- **Sucres** : g pour 100 mL × volume / 100 ; un morceau ≈ 5 g ; OMS : sucres libres < 10 % de l'énergie (≈ 50 g pour 2 000 kcal).
- **Numératie** : fréquences naturelles (« 6 sur 100 ») ; tableaux d'icônes ; donner la réduction **absolue** et **relative**.
- **Numérique** : évaluer une application (éditeur, fondement, mise à jour, données, accessibilité, effets indésirables) ; RGAA / WCAG ; texte alternatif, sous-titres.
- **Allophones** : interprétariat professionnel, médiateurs, supports testés, pictogrammes ; pas d'enfants

interprètes.
- **Tester** : l'indice de lisibilité ne remplace pas le test de compréhension auprès du public.

5.8 Entraînement

5.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Selon Sørensen (2012), les quatre compétences de la littératie en santé sont :

a) accéder **b)** mémoriser **c)** évaluer **d)** appliquer

QCM 2 – Les trois domaines du modèle de Sørensen sont :

a) les soins **b)** la prévention **c)** la promotion de la santé **d)** la recherche

QCM 3 – La littératie critique (Nutbeam) correspond à :

a) savoir lire une étiquette **b)** juger la fiabilité d'une information et agir sur ses déterminants **c)** échanger avec un professionnel **d)** le niveau le plus élevé d'autonomie

QCM 4 – D'après HLS19, la part des adultes en France ayant une littératie en santé limitée est d'environ :

a) 7 % **b)** 15 % **c)** 44 % **d)** 90 %

QCM 5 – L'illettrisme concerne des personnes :

a) jamais scolarisées **b)** scolarisées en France sans maîtrise suffisante de l'écrit **c)** apprenant le français comme langue étrangère **d)** environ 7 % des 18-65 ans en 2011

QCM 6 – L'approche des précautions universelles consiste à :

a) tester le niveau de lecture de chaque participant **b)** communiquer clairement avec tout le monde **c)** éviter de désigner les personnes en difficulté **d)** réserver les supports simplifiés aux personnes illettrées

QCM 7 – La technique du « faire dire » :

a) consiste à demander « Vous avez compris ? » **b)** fait reformuler la personne avec ses mots **c)** vérifie la clarté du professionnel **d)** a fait l'objet d'une fiche-outil de la HAS

QCM 8 – Parmi ces règles d'écriture claire, lesquelles sont correctes ?

a) une idée par phrase **b)** utiliser des sigles pour gagner de la place **c)** préférer la forme active **d)** écrire en majuscules pour être lisible

QCM 9 – Le FALC :

a) signifie « facile à lire et à comprendre » **b)** repose sur des règles européennes **c)** implique une relecture par des personnes concernées **d)** est réservé aux enfants

QCM 10 – Dans l'indice de Kandel et Moles, la lisibilité augmente quand :

a) les phrases sont plus courtes **b)** les mots ont moins de syllabes **c)** le texte est plus long **d)** le texte contient plus de sigles

QCM 11 – La littératie alimentaire comprend :

a) planifier et gérer **b)** sélectionner **c)** préparer **d)** manger

QCM 12 – Une littératie en santé limitée est associée à :

a) un moindre recours à la prévention **b)** davantage d'hospitalisations **c)** une meilleure observance **d)** un creusement des inégalités sociales de santé

QCM 13 – L'illectronisme :

a) concerne environ 7 % des 16-74 ans (Insee, 2025) **b)** est sans effet sur l'accès à la prévention **c)** justifie de ne pas réserver une inscription au numérique **d)** désigne une maladie de la vue

QCM 14 – La médiation en santé :

a) est inscrite dans le Code de la santé publique **b)** a fait l'objet d'un référentiel de la HAS en 2017 **c)** remplace le diététicien **d)** facilite le lien entre publics éloignés et professionnels

QCM 15 – Le Nutri-Score :

a) a été conçu pour être compris par le plus grand nombre **b)** remplace la liste d'ingrédients **c)** permet de comparer des produits d'une même famille **d)** n'a aucun lien avec la littératie

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d (+ comprendre). 2. **a, b, c**. 3. **b, d**. 4. **c**. 5. **b, d** (a = analphabétisme ; c = FLE). 6. **b, c**. 7. **b, c, d** (a est justement à éviter). 8. **a, c**. 9. **a, b, c**. 10. **a, b**. 11. **a, b, c, d**. 12. **a, b, d**. 13. **a, c**. 14. **a, b, d**. 15. **a, c**.

QCM 16 – Dans la liste des ingrédients :

a) les ingrédients sont classés par ordre décroissant de poids **b)** les allergènes sont mis en évidence **c)** le premier ingrédient est le moins abondant **d)** le classement est libre

QCM 17 – Une boisson à 10 g de sucres pour 100 mL, en bouteille de 50 cL, contient environ :

a) 10 g de sucres **b)** 50 g de sucres **c)** 10 morceaux de sucre **d)** 2 morceaux de sucre

QCM 18 – Un risque qui passe de 4 sur 100 à 2 sur 100 correspond à :

a) une réduction absolue de 2 points **b)** une réduction relative de 50 % **c)** une réduction relative de 2 % **d)** une réduction absolue de 50 %

QCM 19 – Pour rendre une vidéo de prévention accessible, on ajoute :

a) des sous-titres **b)** une musique forte **c)** une version audio-décrite ou un texte explicatif **d)** un texte alternatif aux images de la page

QCM 20 – Le Nutri-Score permet de :

a) comparer des produits d'une même famille **b)** comparer une pizza et une pomme **c)** remplacer la liste des ingrédients **d)** mesurer le degré de transformation

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. a, b. 17. **b, c** (10 × 500 / 100 = 50 g ; 50 / 5 = 10 morceaux). 18. **a, b**. 19. **a, c, d**. 20. **a**.

5.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le modèle de Sørensen

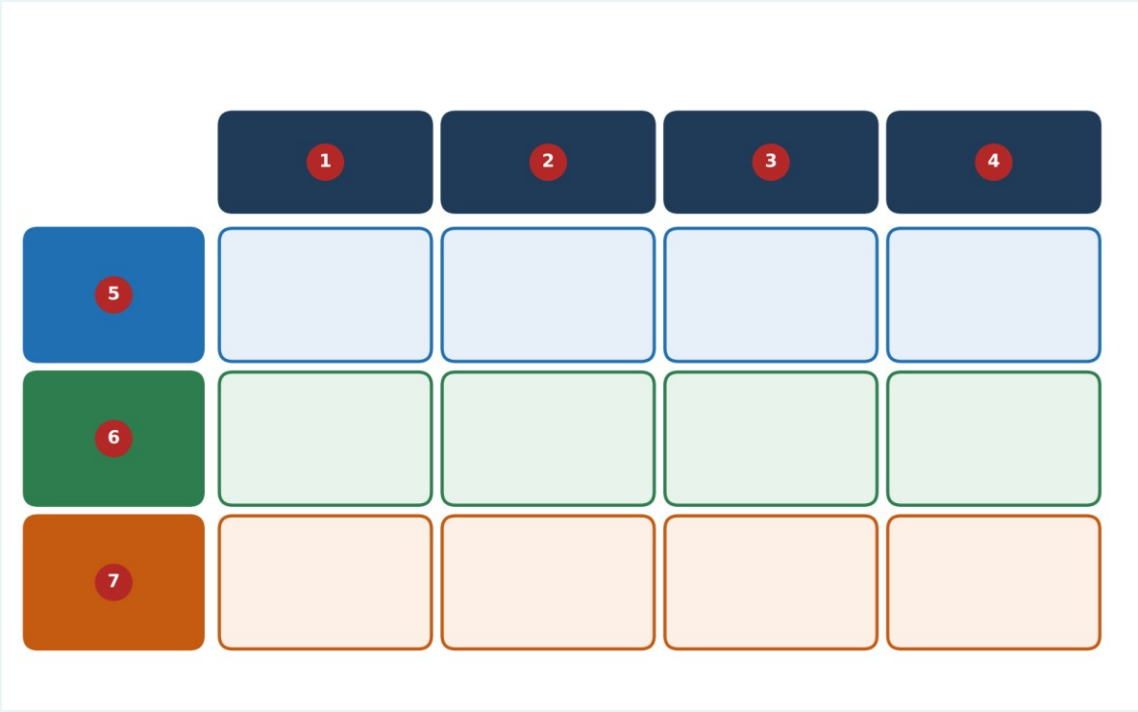


Figure 5.9 – Schéma à légender

Légendez les colonnes 1 à 4 et les lignes 5 à 7, puis complétez trois cases avec un exemple alimentaire.

Corrigé

1. Accéder. 2. Comprendre. 3. Évaluer. 4. Appliquer. 5. Soins. 6. Prévention. 7. Promotion de la santé. Exemples : *prévention × comprendre* : comprendre le Nutri-Score ; *prévention × évaluer* : juger un conseil minceur sur un réseau social ; *promotion × accéder* : connaître l'épicerie solidaire du quartier.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les niveaux de Nutbeam

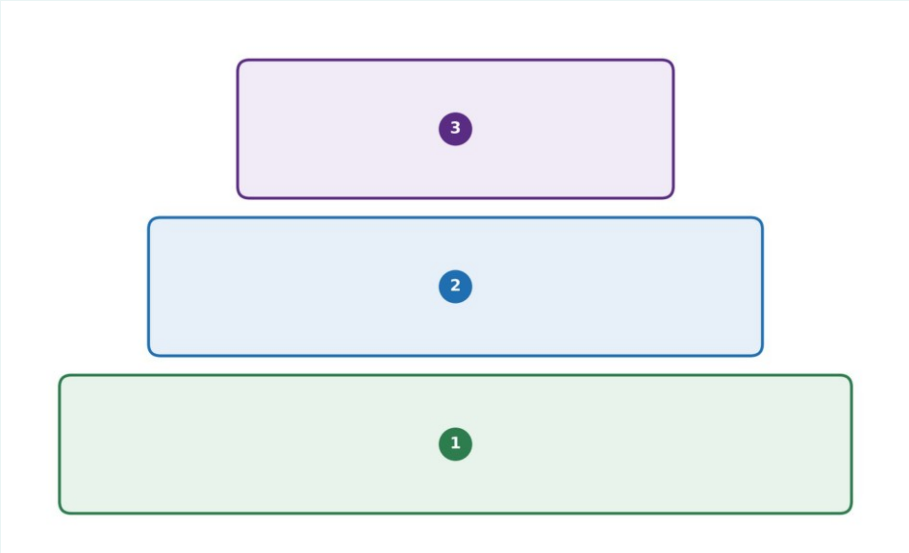


Figure 5.10 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 3 et associez chacune des situations suivantes à un niveau : a) Mme K. lit la date limite sur un yaourt ; b) M. T. demande au diététicien si les conseils s'appliquent à son travail de nuit ; c) un collectif de parents obtient de l'eau en carafe à la cantine.

Corrigé

1. Fonctionnelle – a. 2. **Interactive** – b. 3. **Critique** – c (action collective sur un déterminant).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le faire dire

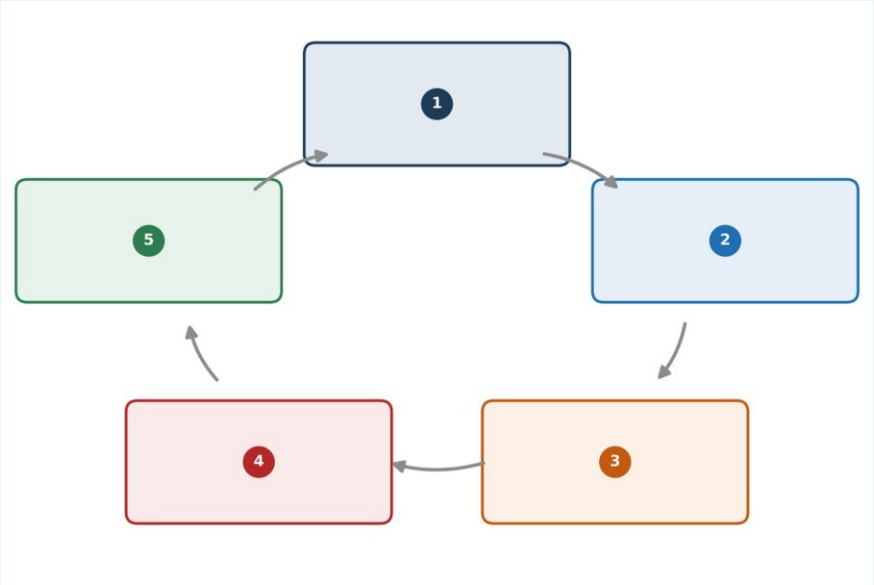


Figure 5.11 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 5 et rédigez la phrase que vous utiliseriez à l'étape 2 après un atelier sur la lecture des étiquettes.

Corrigé

1. Expliquer. 2. Faire dire. 3. Vérifier. 4. Réexpliquer autrement. 5. Confirmer. Phrase : « Pour vérifier que j'ai bien expliqué : montrez-moi, avec ces deux paquets de biscuits, lequel vous choisiriez et pourquoi. »

À vous de jouer – Exercice 4 – Calculer un indice de lisibilité

Un texte de prévention compte 150 mots, 6 phrases et 255 syllabes. a) Calculez l'indice de Kandel et Moles et interprétez. b) Après réécriture : 140 mots, 14 phrases, 210 syllabes. Recalculez et concluez.

Corrigé

a) Mots/phrase = 150 / 6 = **25** ; syllabes/mot = 255 / 150 = **1,7**. L = 207 − 1,015 × 25 − 73,6 × 1,7 = 207 − 25,375 − 125,12 = **56,505 ≈ 56,5** → assez difficile. **b)** Mots/phrase = 140 / 14 = **10** ; syllabes/mot = 210 / 140 = **1,5**. L = 207 − 1,015 × 10 − 73,6 × 1,5 = 207 − 10,15 − 110,4 = **86,45** → facile. Gain : 86,45 − 56,505 = **29,9 points**. L'indice confirme l'amélioration, mais le texte doit encore être **testé** auprès du public.

À vous de jouer – Exercice 5 – Réécrire un message

Réécrivez en langage clair : « La consommation de légumineuses, sources de protéines végétales et de fibres, doit être augmentée à au moins deux fois par semaine conformément aux recommandations nutritionnelles en vigueur. »

Corrigé

« Mangez des lentilles, des pois chiches ou des haricots secs au moins 2 fois par semaine. Ils nourrissent bien et coûtent peu cher. » + photos des trois aliments + un exemple de plat (dahl, chili, salade de lentilles). Les mots « légumineuses », « protéines végétales » et « recommandations en vigueur » ont été remplacés par des exemples concrets.

À vous de jouer – Exercice 6 – Analyser un support existant

Une affiche d'atelier comporte : un titre « Programme d'éducation nutritionnelle PNNS – Session 2 », un texte justifié de 12 lignes en police 10, une photo décorative de salade, une inscription par QR code uniquement. Relevez les problèmes et proposez des corrections.

Corrigé

Problèmes : sigle (PNNS), titre abstrait qui ne dit pas ce qu'on va faire ; texte long, justifié, police trop petite ; image décorative sans information ; inscription uniquement numérique (exclusion des personnes en illectronisme). Corrections : titre concret « Cuisinons ensemble des repas pas chers » ; 3 informations (quand, où, gratuit) en gros caractères avec pictogrammes (horloge, lieu, euro barré) ; photo de participants en train de cuisiner ; inscription à l'accueil, par téléphone **ou** par QR code.

À vous de jouer – Exercice 7 – Interpréter des données

Dans un questionnaire de diagnostic rempli par 60 personnes d'une épicerie solidaire, 27 déclarent qu'il leur est « difficile » ou « très difficile » de comprendre les informations sur les emballages, et 42 n'ont jamais utilisé le site *mangerbouger.fr*. Calculez les pourcentages et proposez deux conséquences pour l'action.

Corrigé

27 / 60 × 100 = **45 %** ont des difficultés avec les emballages (proche de l'ordre de grandeur national de HLS19, 44 %) ; 42 / 60 × 100 = **70 %** n'utilisent pas le site. Conséquences : atelier pratique avec de vrais emballages (compétence « comprendre » et « évaluer ») ; supports papier et oraux plutôt qu'un renvoi au site, ou accompagnement à son utilisation sur smartphone.

À vous de jouer – Exercice 8 – Recette en images

Transformez la recette suivante en fiche accessible : « Faire revenir 1 oignon émincé dans 1 c. à s. d'huile, ajouter 200 g de lentilles corail rincées, 400 g de tomates concassées et 600 mL d'eau, cuire 15 min, assaisonner de cumin. »

Corrigé

Titre : **Soupe de lentilles corail** (4 personnes, 20 minutes, environ 2 €). Étape 1 (photo) : Coupez 1 oignon en petits morceaux. Étape 2 : Faites cuire l'oignon avec 1 cuillère à soupe d'huile, 3 minutes. Étape 3 : Lavez 1 grand verre de lentilles corail (200 g) dans une passoire. Étape 4 : Mettez les lentilles, 1 boîte de tomates et 3 verres d'eau (600 mL avec un verre de 200 mL). Étape 5 : Faites cuire 15 minutes. Étape 6 : Ajoutez 1 pincée de cumin et de sel. Chaque étape a une photo, une seule action, un verbe d'action au début.

À vous de jouer – Exercice 9 – Juger une information en ligne

Une vidéo d'un influenceur affirme : « Le jus de citron à jeun fait fondre les graisses : -5 kg en 2 semaines ! » Appliquez la grille des 6 questions.

Corrigé

Auteur : influenceur sans qualification en santé identifiée ; objectif : souvent commercial (lien vers une cure) ; sources : aucune étude citée ; date : non pertinente ici ; cohérence : contraire aux connaissances (aucun aliment ne « fait fondre » les graisses) ; promesse miraculeuse et rapide : **signal d'alerte**. Conclusion : information non fiable ; c'est un bon support pour un atelier de littératie critique.

À vous de jouer – Exercice 10 – Questionnaire accessible

Transformez la question suivante pour des enfants de 8 ans : « Évaluez votre niveau de satisfaction concernant l'atelier sur une échelle de 1 à 10. »

Corrigé

« As-tu aimé l'atelier ? » avec trois ou cinq visages (très content, content, moyen, pas content, pas du tout content) à entourer ou une gommette à coller ; question complémentaire orale : « Qu'est-ce que tu as préféré ? ».

5.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi dit-on que la littératie en santé est aussi une responsabilité des professionnels et des organisations ?

Corrigé

Parce que la difficulté naît de la **rencontre** entre les compétences d'une personne et la complexité de l'information et des services. Simplifier les documents, former les professionnels, proposer plusieurs canaux réduit les difficultés pour tous, sans faire porter l'effort sur les seules personnes (littératie organisationnelle). C'est aussi une question d'équité.

À vous de jouer – Question 2

Une campagne de prévention diffusée uniquement sur les réseaux sociaux peut-elle accroître les inégalités ?

Corrigé

Oui : les personnes les plus favorisées ont plus d'accès et de compétences numériques et critiques ; elles s'approprient mieux les messages. Les personnes en illectronisme ou à littératie limitée sont moins touchées. D'où l'universalisme proportionné : diffusion large **et** actions de proximité adaptées (ateliers, relais, médiation).

À vous de jouer – Question 3

Simplifier un message, est-ce le rendre moins exact ?

Corrigé

Non, si on choisit l'**essentiel** et qu'on le formule concrètement : « 5 fruits et légumes par jour » est simple et exact. Le risque est de simplifier jusqu'à l'erreur (« le gras, c'est mauvais ») ; on garde donc la validation scientifique du fond (repères officiels) et on adapte la forme. La simplification est un travail exigeant, pas un appauvrissement.

5.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le foyer de travailleurs migrants

Un foyer de travailleurs migrants (180 résidents, âge moyen 58 ans) souhaite une action sur le diabète et l'alimentation. Une partie des résidents lit peu le français ; beaucoup cuisinent collectivement dans les cuisines d'étage ; le gestionnaire propose de « distribuer la brochure de l'Assurance maladie ».

1. Analysez les enjeux de littératie (domaines et niveaux).
2. Pourquoi la brochure seule est-elle insuffisante ?
3. Proposez une action adaptée (supports, méthodes, partenaires).
4. Comment vérifier la compréhension ?
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation accessibles.

Corrigé

1. Domaines : **prévention** (dépistage du diabète), **soins** (comprendre un traitement) ; niveaux fonctionnel (lecture) et interactif (échanger avec un soignant) ; facteurs : langue, âge, culture culinaire, cuisine collective.
2. Elle repose sur l'écrit en français, est générale, ne tient pas compte des plats cuisinés au foyer ni des pratiques (Ramadan, plats communautaires).
3. Groupe de parole et atelier culinaire dans la cuisine d'étage, avec un **médiateur en santé** ou un résident relais parlant les langues du groupe ; supports imagés (assiette, portions de riz et de semoule en photos) ; travail sur les plats habituels (mafé, riz au poisson) pour ajuster les portions de féculents et ajouter des légumes ; partenariat avec la CPAM ou un centre d'examens de santé pour un dépistage, la PASS ou le centre de santé pour l'orientation.
4. Faire dire en petit groupe (« Montrez-moi la quantité de riz pour une assiette »), démonstrations, questions ouvertes, avec traduction.
5. Nombre de résidents ayant participé et ayant réalisé un dépistage ; proportion de participants capables de montrer la portion conseillée en fin de séance (observation).

5.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Donnez une définition de la littératie en santé. »

Corrigé

Ce sont les connaissances, la motivation et les compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé, dans les soins, la prévention et la promotion de la santé (Sørensen, 2012).

Mise en situation – MSE 2

Une participante dit : « J'ai oublié mes lunettes, je remplirai le questionnaire chez moi. »

Corrigé

Je ne mets pas la personne en difficulté : je propose de lui poser les questions oralement (« Je peux vous les lire, ça ira plus vite ») et je note les réponses ; à l'avenir, je proposerai l'oral à tout le groupe.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pourquoi ne pas demander "Vous avez compris ?" »

Corrigé

Parce que la réponse est presque toujours « oui », par politesse ou par gêne ; je préfère le faire dire : faire reformuler ou montrer, ce qui vérifie vraiment ma clarté.

Mise en situation – MSE 4

Votre tutrice vous demande une affiche pour un atelier ; vous avez 30 minutes.

Corrigé

Un titre concret, trois informations (quoi, quand, où) en gros caractères, des pictogrammes, une photo réelle, une inscription possible à l'accueil ; je la fais relire par deux personnes du public avant impression.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Quel chiffre retenez-vous sur la littératie en France ? »

Corrigé

Environ 44 % des adultes ont une littératie en santé limitée (HLS19, résultats 2021), avec des difficultés plus fréquentes pour les informations numériques et un gradient social marqué.

Mise en situation – MSE 6

Un parent ne parle pas français et vient à l'atelier avec son enfant de 10 ans qui traduit.

Corrigé

J'accueille le parent, je privilégie la démonstration et les images ; je ne fais pas porter à l'enfant des informations de santé complexes ou intimes ; je recherche un interprète ou un adulte relais (médiatrice) pour les séances suivantes.

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Qu'est-ce que le FALC ? »

Corrigé

Le « facile à lire et à comprendre » : une méthode de rédaction fondée sur des règles européennes (Inclusion Europe, 2009), conçue avec des personnes en situation de handicap intellectuel, et validée par des relecteurs

concernés.

Mise en situation – MSE 8

Un participant affirme : « J'ai vu sur internet que le gluten est un poison. »

Corrigé

Je l'écoute, puis on applique ensemble la grille de fiabilité (qui ? quel objectif ? quelles sources ?) ; j'explique que l'éviction du gluten ne se justifie qu'en cas de maladie cœliaque ou d'allergie diagnostiquée ; j'en fais un exemple de littératie critique pour le groupe.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Comment avez-vous pris en compte la littératie dans votre projet ? »

Corrigé

À chaque étape : diagnostic oral, objectifs de compétences, supports testés et imagés, méthodes actives et faire dire, communication multicanale, évaluation par smileys et questions orales ; j'illustre par un exemple précis et un chiffre (par exemple, l'indice de lisibilité avant et après).

Mise en situation – MSE 10

La mairie veut lancer une application de recettes pour les familles du quartier.

Corrigé

Je salue l'idée mais je rappelle l'illectronisme (7 % des 16-74 ans en 2025, et 34 % en difficulté numérique) : je propose de l'associer à des ateliers d'accompagnement, à une version papier des recettes et à des relais humains, et de tester l'application avec des habitants.

Mise en situation – MSE 11

Le jury : « Faut-il faire passer un test de lecture aux participants ? »

Corrigé

Non : cela stigmatise et n'est pas nécessaire ; j'applique les précautions universelles en communiquant clairement avec tout le monde, et j'observe les besoins pour ajuster.

Mise en situation – MSE 12

Une collègue propose de traduire l'affiche avec un traducteur automatique.

Corrigé

Je propose plutôt une traduction relue par une personne qui parle la langue (médiatrice, habitant relais), car une erreur dans un message de santé peut être grave ; et je privilégie les pictogrammes et la transmission orale.

5.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Sucres en morceaux

Calculez en grammes et en morceaux de sucre (5 g) : a) un soda à 10,6 g/100 mL, canette de 33 cL ; b) un yaourt aromatisé de 125 g à 12 g/100 g ; c) une compote « sans sucres ajoutés » à 12,5 g/100 g, gourde de 90 g. Commentez c.

Corrigé

a) 10,6 × 3,3 = **35,0 g**, soit **7 morceaux**. b) 12 × 1,25 = **15 g**, soit **3 morceaux**. c) 12,5 × 0,9 = **11,25 g**, soit **2,25 morceaux** : « sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres » : ce sont les sucres naturellement présents dans les fruits (moins préoccupants que les sucres libres d'un soda, mais à connaître).

À vous de jouer – Exercice 12 – Fréquences naturelles

Reformulez en fréquences naturelles et donnez les réductions absolue et relative : « Manger des fruits et légumes chaque jour réduit le risque de ce problème de 0,8 % à 0,6 %. »

Corrigé

« Sur 1 000 personnes, 8 auraient ce problème sans fruits et légumes quotidiens, et 6 avec. » Réduction absolue : 8 − 6 = **2 personnes sur 1 000** (0,2 point) ; relative : 2 / 8 × 100 = **25 %**.

À vous de jouer – Exercice 13 – Évaluer une application

Une famille utilise une application qui note les produits de 0 à 100 et colore en rouge tous les produits contenant un additif. Appliquez la grille d'évaluation et donnez un conseil.

Corrigé

Éditeur et financement : à vérifier (société privée, modèle économique) ; fondement : algorithme propre, différent du Nutri-Score officiel, qui pénalise fortement les additifs ; mise à jour : variable ; données personnelles : vérifier les autorisations ; effets indésirables possibles : peur de tous les additifs, exclusion de produits utiles (conserves de légumes), culpabilisation. Conseil : l'utiliser comme une information parmi d'autres, se référer au Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle et privilégier les produits peu transformés, sans s'inquiéter de chaque additif.

À vous de jouer – Exercice 14 – Lisibilité et test

Une fiche passe de 180 mots en 8 phrases (300 syllabes) à 120 mots en 15 phrases (180 syllabes). Calculez les deux indices. Au test, 4 personnes sur 10 comprennent la version 1 et 8 sur 10 la version 2. Concluez.

Corrigé

V1 : 180 / 8 = 22,5 mots par phrase ; 300 / 180 = 1,667 syllabe par mot ; L = 207 − 1,015 × 22,5 − 73,6 × 1,667 = 207 − 22,84 − 122,69 = **61,47** (standard). V2 : 120 / 15 = 8 ; 180 / 120 = 1,5 ; L = 207 − 8,12 − 110,4 = **88,48** (facile). Compréhension : **40 %** → **80 %**. Les deux mesures convergent ; c'est le test qui démontre la compréhension.

À vous de jouer – Exercice 15 – Adapter pour un public allophone

Un atelier réunit 10 participantes dont 4 parlent peu le français (2 en arabe, 2 en tamoul). Proposez 5 adaptations.

Corrigé

Interprète professionnel ou médiatrice pour l'accueil et les consignes de sécurité ; démonstration avant chaque étape ; recette en photos, quantités en contenants ; pictogrammes des allergènes ; binômes associant une participante francophone et une non francophone ; vocabulaire culinaire illustré à emporter ; vérification par « montrez-moi » plutôt que par questions verbales.

5.9 Glossaire

Terme	Définition
Analphabétisme	Situation de personnes jamais scolarisées, n'ayant pas appris à lire et à écrire
FALC	Facile à lire et à comprendre : méthode de rédaction fondée sur des règles européennes (2009), avec relecture par des personnes concernées
Faire dire (teach-back)	Technique qui fait reformuler la personne pour vérifier la clarté du professionnel
HLS19	Enquête européenne sur la littératie en santé (réseau M-POHL, OMS Europe), 2019-2021
Illectronisme	Difficulté ou incapacité à utiliser les outils numériques et internet
Illettrisme	Maîtrise insuffisante de l'écrit et du calcul chez des personnes scolarisées en France
Indice de lisibilité	Estimation de la difficulté d'un texte à partir de la longueur des phrases et des mots
Littératie alimentaire	Compétences pour planifier, sélectionner, préparer et manger des aliments
Littératie critique	Capacité à juger l'information et à agir sur les déterminants de sa santé
Littératie en santé	Connaissances, motivation et compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information en santé
Littératie fonctionnelle	Compétences de base en lecture, écriture et calcul
Littératie interactive	Capacité à échanger et à extraire l'information d'une communication
Littératie numérique en santé	Capacité à trouver, comprendre, évaluer et utiliser l'information de santé en ligne
Littératie organisationnelle	Capacité d'une structure à rendre information et services faciles à trouver, comprendre et utiliser
Médiation en santé	Fonction d'interface entre publics éloignés et professionnels (art. L. 1110-13 CSP ; HAS, 2017)
Précautions universelles	Communication claire appliquée à tous, sans repérage stigmatisant
Pictogramme	Dessin simple qui représente une action, un objet ou une information
Allophone	Personne dont la langue maternelle n'est pas celle du pays où elle vit

Terme	Définition
Fréquences naturelles	Présentation d'un risque en nombre de personnes (« 6 sur 100 »)
Numératie	Capacité à comprendre et utiliser nombres, pourcentages et risques
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité des services numériques publics
Règlement INCO	Règlement (UE) n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Réduction absolue / relative	Différence de risques en points / rapportée au risque initial
Tableau d'icônes	Représentation d'un risque par 100 (ou 1 000) pictogrammes dont certains colorés
Texte alternatif	Description textuelle d'une image, lue par les logiciels de synthèse vocale

5.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, modèles	[1] Sørensen ; [2] Nutbeam 2000 ; [3] Nutbeam 2008 ; [4] Vidgen et Gallegos
Données	[5] HLS19 ; [6] ANLCI ; [7] Insee illectronisme ; [8] OCDE PIAAC
Conséquences	[9] Berkman et coll.
Adapter, FALC	[10] Santé publique France, Communiquer pour tous ; [11] Inclusion Europe ; [12] Kandel et Moles
Faire dire, médiation	[13] HAS Faire dire ; [14] HAS médiation et interprétariat
Organisations, mesure	[15] Brach et coll. ; [16] Norman et Skinner ; [17] Weiss (NVS)

5.12 Bibliographie numérotée

1. Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J. et coll. « Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models ». *BMC Public Health*, 2012, 12, 80.
2. Nutbeam D. « Health literacy as a public health goal ». *Health Promotion International*, 2000, 15 (3), p. 259-267.
3. Nutbeam D. « The evolving concept of health literacy ». *Social Science & Medicine*, 2008, 67 (12), p. 2072-2078.
4. Vidgen H. A., Gallegos D. « Defining food literacy and its components ». *Appetite*, 2014, 76, p. 50-59.
5. The HLS19 Consortium of the WHO Action Network M-POHL. *International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19)*. 2021 (rapport international et résultats France).
6. Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). *L'évolution de l'illettrisme en France* (enquête IVQ 2011, Insee). 2013.
7. Insee. Enquête TIC ménages 2025 (usages et compétences numériques), publiée le 19 février 2026 ; pour l'évolution : *Insee Première* sur l'illectronisme en 2021, 2023.
8. OCDE. *Survey of Adult Skills 2023 (PIAAC, 2e cycle)*. Décembre 2024 ; Dares. « Compétences des adultes en 2023 ». *Dares Analyses* n° 73, décembre 2024.
9. Berkman N. D. et coll. « Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review ». *Annals of Internal Medicine*, 2011, 155 (2), p. 97-107.

10. Ruel J., Allaire C. (dir.). *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Santé publique France, mai 2018, mise à jour février 2025.

11. Inclusion Europe. *L'information pour tous : règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre*. 2009.

12. Kandel L., Moles A. « Application de l'indice de Flesch à la langue française ». *Cahiers d'études de radio-télévision*, 1958, 19, p. 253-274.

13. HAS. *Faire dire*. Fiche outil, 2015.

14. HAS. *La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins* ; *Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé*. Référentiels de compétences, 2017.

15. Brach C. et coll. *Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations*. Institute of Medicine, 2012.

16. Norman C. D., Skinner H. A. « eHealth literacy: essential skills for consumer health in a networked world ». *Journal of Medical Internet Research*, 2006, 8 (2), e9.

17. Weiss B. D. et coll. « Quick assessment of literacy in primary care: the Newest Vital Sign ». *Annals of Family Medicine*, 2005, 3 (6), p. 514-522.

18. Marmot M. *Fair Society, Healthy Lives* (The Marmot Review). 2010.

19. Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO).

20. Santé publique France. *Nutri-Score* : documents de référence et mise à jour de l'algorithme (2022-2024), *santepubliquefrance.fr*.

21. OMS. *Guideline: Sugars intake for adults and children*. Genève, 2015.

22. Gigerenzer G. *Calculated Risks: How to Know When Numbers Deceive You*. New York, Simon & Schuster, 2002.

23. DINUM. *Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)*, version 4, *accessibilite.numerique.gouv.fr*.

24. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023.

25. Conférence nationale de santé. *La littératie en santé – usagers et professionnels : tous concernés*. Avis adopté le 6 juillet 2017.

26. Van den Broucke S. « La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique ». *La Santé en action*, n° 440, juin 2017.

27. Le Brun M., Godard D., Camps L. et coll. « La littératie en santé : définition, outils d'évaluation, état des lieux en Europe ». *La Revue de médecine interne*, 2025, 46, p. 32-39.

28. DEPP. « Journée défense et citoyenneté 2025 : 14 % des jeunes rencontrent des difficultés de lecture ». *Note d'information* n° 26.43, octobre 2026.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 5.2.2)

29. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

30. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.